

Buku Ajar

Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah

Nurseha
Inggar Ratna Kusuma
Ike Putri Setyatama
Lilik Hanifah
Nurbaiti
Lidya Fransisca
Ida Sofiyanti

Editor: Zakkiyatus Zainiyah



Buku Ajar

Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah

Penulis:

Bdn. Nurseha, S.ST., M.Keb.

Dr. Inggar Ratna Kusuma, MPH.

Ike Putri Setyatama, S.ST., M.Kes.

Lilik Hanifah, SST., M.Kes., M.Keb.

Nurbaiti, SKM., M.Kes.

Lidya Fransisca, SST., M.Kes.

Ida Sofiyanti, S.Si.T., M.Keb.

Editor: Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.



Buku Ajar Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah

Penulis: Bdn. Nurseha, S.ST., M.Keb.

Dr. Inggar Ratna Kusuma, MPH.

Ike Putri Setyatama, S.ST., M.Kes.

Lilik Hanifah, SST., M.Kes., M.Keb.

Nurbaiti, SKM., M.Kes.

Lidya Fransisca, SST., M.Kes.

Ida Sofiyanti, S.Si.T., M.Keb.

Editor: Prof. Dr. Bdn. Zakkiyatus Zainiyah, M.Keb.

ISBN: 978-634-96029-7-6

Desain Sampul : Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak : Achmad Faisal

Cetakan Pertama: Juni, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

Prakata

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya *Buku Ajar Bayi, Balita dan Anak Prasekolah*. Buku ini disusun sebagai upaya untuk menyediakan referensi yang komprehensif dan aplikatif bagi mahasiswa kebidanan, tenaga kesehatan, serta para pendidik yang terlibat dalam pelayanan dan pemantauan tumbuh kembang anak usia dini.

Masa bayi, balita, dan anak prasekolah merupakan fase penting yang menentukan kualitas hidup anak di masa depan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep dasar tumbuh kembang, prinsip-prinsip pemantauan, hingga strategi deteksi dan intervensi dini menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh setiap tenaga kesehatan. Buku ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut melalui pendekatan teoritis dan praktis yang mudah dipahami dan diterapkan di lapangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penulis dan kontributor yang telah bekerja dengan dedikasi tinggi dan mengarahkan penyusunan buku ini secara sistematis. Harapan kami, buku ini dapat menjadi panduan yang berguna dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan kebidanan dan kesehatan anak di Indonesia.

Jakarta, Mei 2025

Tim Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi.....	iv

Bab 1 Konsep Dasar Tumbuh Kembang Bayi, Balita, dan Anak

Prasekolah.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Capaian Pembelajaran	1
C. Konsep Dasar Tumbuh Kembang.....	3
1. Definisi Pertumbuhan dan Perkembangan	3
2. Prinsip Dasar Tumbuh Kembang Anak	3
3. Tahap Tumbuh Kembang Menurut Kelompok Umur	4
D. Praktik	6
1. Praktik Pengukuran Antropometri	6
2. Praktik Observasi Perkembangan Anak	8
3. Praktik Edukasi kepada Orang Tua atau Pengasuh.....	11
4. Praktik Dokumentasi Hasil Pemeriksaan dan Evaluasi.....	13
E. Tugas Mandiri	15
F. Soal Kasus	16
G. Soal OSCE.....	19

Bab 2 Perkembangan Bayi (0–12 Bulan)

A. Pendahuluan	21
B. Capaian Pembelajaran	21
C. Ciri - Ciri Tumbuh Kembang Normal Bayi.....	22
1. Pertumbuhan Fisik Sesuai Grafik Tumbuh Kembang	22
2. Pola Tidur dan Makan yang Teratur	22
3. Peningkatan Keterampilan Motorik Secara Bertahap	23
4. Respons Emosional dan Sosial Sesuai Usia	24
D. Perkembangan Fisik, Motorik Kasar, dan Motorik Halus Bayi (0–12 Bulan).....	25
1. Usia 0–3 Bulan.....	25
2. Usia 4–6 Bulan.....	25
3. Usia 7–9 Bulan.....	25
4. Usia 10–12 Bulan.....	26
5. Strategi Mendukung Perkembangan Motorik Bayi	26

6. Deteksi Dini Gangguan Perkembangan Motorik	27
E. Perkembangan Kognitif, Emosional, Bahasa, dan Sosial Bayi (0–12 Bulan)	27
1. Perkembangan Kognitif.....	27
2. Perkembangan Emosional.....	27
3. Perkembangan Bahasa	28
4. Perkembangan Sosial.....	29
5. Strategi Stimulasi Perkembangan Kognitif, Emosional, Bahasa, dan Sosial.....	29
6. Deteksi Dini Gangguan Perkembangan Kognitif, Emosional, Bahasa, dan Sosial	29
F. Pemantauan Tumbuh Kembang Bayi Sesuai Standar Profesi Bidan	30
1. Pengukuran Antropometri	30
2. Penggunaan Grafik WHO atau Kartu Menuju Sehat (KMS).....	30
3. Mengamati Milestone Perkembangan.....	31
4. Konseling Perkembangan Kepada Orang Tua	31
5. Strategi Stimulasi untuk Mendukung Tumbuh Kembang.....	32
6. Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang	32
G. Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang Bayi.....	32
1. Identifikasi Keterlambatan Motorik atau Gangguan Koordinasi	32
2. Mengenali Tanda-tanda Gangguan Pendengaran atau Penglihatan	33
3. Mengenali Gangguan Bahasa dan Sosial pada Bayi Usia Dini	33
4. Intervensi Dini dan Dukungan	34
H. Praktik	34
I. Tugas.....	36
J. Soal Kasus Kebidanan	37
K. Soal OSCE.....	40

Bab 3 Perkembangan Balita (1-5 Tahun) 42

A. Pendahuluan	42
B. Capaian Pembelajaran	42
C. Karakteristik Tumbuh Kembang Balita	43
1. Pertumbuhan Fisik.....	43
2. Perkembangan Motorik	43
3. Perkembangan Bahasa	44
4. Perkembangan Sosial dan Emosional.....	45
5. Perkembangan Kognitif.....	46
6. Strategi Stimulasi Optimal untuk Balita.....	46
7. Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang Balita.....	46
D. Perkembangan Fisik dan Motorik.....	47
1. Perkembangan Fisik Balita dan Anak Prasekolah	47
2. Perkembangan Motorik Kasar	47

3. Perkembangan Motorik Halus.....	48
4. Strategi Stimulasi Motorik Kasar dan Halus.....	48
5. Deteksi Dini Gangguan Motorik.....	49
E. Perkembangan Sosial, Emosi, Bahasa, dan Kognitif.....	49
1. Perkembangan Sosial Balita.....	49
2. Perkembangan Emosi Balita.....	49
3. Perkembangan Bahasa Balita.....	50
4. Perkembangan Kognitif Balita.....	51
5. Strategi Stimulasi Perkembangan.....	51
6. Deteksi Dini Gangguan Perkembangan.....	51
F. Pengukuran Tumbuh Kembang Berdasarkan Grafik WHO/NCHS.....	52
1. Pentingnya Pemantauan Pertumbuhan Balita.....	52
2. Indikator Utama dalam Grafik Pertumbuhan.....	52
3. Langkah-langkah Melakukan Pengukuran.....	53
4. Plotting Data pada Grafik Pertumbuhan.....	53
5. Interpretasi Hasil Pengukuran.....	53
6. Tindak Lanjut dan Intervensi.....	53
G. Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang.....	53
1. Pengertian Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang.....	53
2. Tanda-Tanda Awal Gangguan Tumbuh Kembang Balita.....	54
3. Metode Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang Balita.....	54
4. Wawancara dan Konseling Orang Tua.....	55
5. Intervensi Dini untuk Gangguan Tumbuh Kembang Balita.....	55
6. Peran Bidan dan dalam Deteksi Dini.....	56
H. Praktik.....	56
I. Tugas.....	60
J. Soal Kasus Kebidanan.....	63
K. Soal OSCE dan Rubrik Penilaian.....	66

Bab 4 Perkembangan Anak Prasekolah (3-6 Tahun) 69

A. Pendahuluan.....	69
B. Capaian Pembelajaran.....	69
C. Karakteristik Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Prasekolah.....	70
1. Perkembangan Fisik dan Motorik.....	70
2. Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah (3–6 Tahun).....	72
3. Perkembangan Bahasa Anak Prasekolah (3–6 Tahun).....	74
4. Perkembangan Emosi dan Sosial Anak Prasekolah (3–6 Tahun).....	76
D. Peran Bidan dalam Stimulasi Perkembangan Anak Prasekolah (3–6 Tahun).....	78
1. Pentingnya Stimulasi Sesuai Tahapan Perkembangan Anak.....	78
2. Teknik Bermain yang Mendukung Perkembangan Motorik dan Kognitif.....	79

3. Memberikan Dukungan Emosional dan Sosial Melalui Interaksi Positif Sehari-hari.....	79
4. Menyusun Rencana Intervensi Dini Bila Ditemukan Gangguan atau Keterlambatan Perkembangan.....	80
E. Deteksi Dini Gangguan Perkembangan Anak Prasekolah (3–6 Tahun)	80
1. Penggunaan Instrumen Skrining Denver II	81
2. Observasi Tanda-tanda Keterlambatan Perkembangan	82
3. Konsultasi dengan Tenaga Ahli atau Rujukan ke Spesialis Terkait.....	82
F. Praktik.....	83
1. Praktik Skrining Perkembangan Menggunakan Denver II	83
2. Edukasi dan Demonstrasi Stimulasi Motorik dan Bahasa kepada Orang Tua	85
G. Tugas.....	88
H. Soal Kasus	88
I. Soal OSCE Kebidanan.....	91

Bab 5 Asuhan Neonatus dan Bayi Sehat 94

A. Pendahuluan	94
B. Capaian Pembelajaran	95
C. Asuhan Segera Setelah Lahir.....	97
1. Penilaian Awal Bayi (APGAR Score)	97
2. Pengeringan dan Kehangatan	98
3. Pemotongan dan Perawatan Tali Pusat.....	99
4. Pemberian Profilaksis Mata dan Vitamin K	99
D. Asuhan Rutin Pada Bayi Baru Lahir Normal Hingga Usia 28 Hari	100
1. Tujuan Asuhan Rutin	100
2. Pemeriksaan Fisik Rutin.....	100
3. Pemantauan Tanda Vital.....	101
4. Pemberian Imunisasi Dasar.....	102
5. Pemantauan Tumbuh Kembang.....	102
6. Skrining Neonatal	102
E. Edukasi Orang Tua Tentang Perawatan Bayi Sehat.....	103
1. Pemberian ASI Eksklusif	103
2. Perawatan Tali Pusat.....	104
3. Perawatan Kulit Bayi	104
4. Tanda Bahaya pada Bayi	105
5. Manajemen Pola Tidur dan Menenangkan Bayi	105
F. Pencegahan Infeksi Pada Neonatus dan Bayi	106
1. Cuci Tangan.....	106
2. Imunisasi Tepat Waktu	107
3. Perawatan Kulit dan Tali Pusat yang Steril	107

4. Kontak Terbatas dengan Orang Sakit.....	108
5. Sterilisasi Alat dan Lingkungan	108
G. Tugas.....	109
H. Soal Kasus	111
I. Soal OSCE.....	114

Bab 6 Gizi Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah..... 118

A. Pendahuluan	118
B. Capaian Pembelajaran	118
C. Kebutuhan Nutrisi Pada Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah	120
1. Kebutuhan Nutrisi pada Bayi (0–12 bulan).....	120
2. Kebutuhan Nutrisi pada Balita (1–3 tahun)	121
3. Kebutuhan Nutrisi pada Anak Prasekolah (4–6 tahun).....	122
4. Sumber Makanan yang Dianjurkan	124
5. Implikasi dari Pemenuhan Nutrisi yang Tidak Optimal	124
D. ASI Eksklusif dan MP-ASI Sesuai Standar WHO	125
1. Pentingnya ASI Eksklusif selama 6 Bulan Pertama	125
2. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Menurut Standar WHO.....	126
3. Contoh MP-ASI yang Sesuai Standar WHO	127
E. Penatalaksanaan Pemberian Makanan Sehat Pada Anak.....	127
1. Mengatur Jadwal Makan yang Teratur	128
2. Memastikan Variasi Makanan dari Berbagai Kelompok Nutrisi.....	128
3. Pemberian Makanan dalam Porsi Sesuai Usia Anak.....	129
4. Melibatkan Anak dalam Aktivitas Makan.....	129
5. Edukasi kepada Orang Tua tentang Pemilihan Bahan Makanan, Penyajian, dan Kebersihan Makanan.....	130
F. Pencegahan dan Penanganan Gizi Kurang, Gizi Buruk, dan Stunting.....	130
1. Pencegahan Gizi Kurang, Gizi Buruk, dan Stunting	130
2. Penanganan Gizi Kurang dan Gizi Buruk.....	131
3. Penanganan Stunting.....	132
G. Tugas.....	133
H. Soal Kasus	135
I. Soal OSCE.....	139

Daftar Pustaka 143

Bab 1

Konsep Dasar Tumbuh Kembang Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah

A. Pendahuluan

Tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah merupakan periode krusial dalam siklus kehidupan manusia yang sangat menentukan kualitas hidup di masa mendatang. Pemahaman mendalam tentang konsep dasar tumbuh kembang menjadi penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan, agar mampu memberikan asuhan dan intervensi yang tepat waktu dan efektif. Pemantauan tumbuh kembang yang tepat memungkinkan deteksi dini berbagai gangguan, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi genetik dan lingkungan yang mendukung.

B. Capaian Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan program studi, lulusan mampu:

"Memberikan asuhan kebidanan secara holistik, profesional, dan sesuai standar pada bayi, balita, dan anak prasekolah dengan memperhatikan prinsip tumbuh kembang optimal."

Indikator pencapaian lulusan:

- a. Menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang konsep tumbuh kembang anak.
- b. Menerapkan asuhan kebidanan berbasis bukti dengan mempertimbangkan aspek fisik, psikologis, sosial, dan emosional.
- c. Melakukan deteksi dini dan intervensi tepat terhadap gangguan tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah.
- d. Mengedukasi keluarga dan masyarakat mengenai stimulasi tumbuh kembang yang optimal.

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu:

"Memahami, menjelaskan, serta mengaplikasikan konsep dasar tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah dalam praktik kebidanan sehari-hari."

Indikator pencapaian mata kuliah:

- a. Menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan anak secara ilmiah, jelas, dan komprehensif.
- b. Memahami prinsip dasar yang mendasari tumbuh kembang anak secara mendalam.
- c. Menerapkan pengetahuan tentang tahap-tahap tumbuh kembang anak sesuai kelompok usia dalam praktik nyata.
- d. Mengidentifikasi secara dini gangguan tumbuh kembang melalui observasi dan pengukuran antropometri yang tepat.
- e. Memberikan edukasi efektif kepada orang tua atau pengasuh tentang stimulasi tumbuh kembang anak secara optimal.

3. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi pertumbuhan dan perkembangan secara komprehensif.
- b. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar tumbuh kembang anak secara mendetail.
- c. Mahasiswa mampu mengidentifikasi tahap-tahap tumbuh kembang anak berdasarkan kelompok usia (bayi, balita, dan anak prasekolah).

C. Konsep Dasar Tumbuh Kembang

1. Definisi Pertumbuhan dan Perkembangan

a. Pertumbuhan

Pertumbuhan adalah perubahan fisik yang bersifat kuantitatif, ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh seperti berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, dan parameter fisik lainnya. Proses pertumbuhan dapat diukur secara objektif menggunakan metode antropometri, yang mencakup berbagai teknik pengukuran fisik seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, serta lingkar kepala. Pertumbuhan merupakan hasil interaksi antara faktor genetik, nutrisi, dan lingkungan fisik.

b. Perkembangan

Perkembangan adalah proses pematangan fungsi tubuh yang mencakup berbagai aspek, antara lain motorik, bahasa, kognitif, sosial, dan emosional. Perkembangan bersifat kualitatif, yang merefleksikan peningkatan kompleksitas dalam fungsi-fungsi tubuh serta kemampuan anak untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Proses perkembangan dipengaruhi oleh interaksi yang dinamis antara faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan.

2. Prinsip Dasar Tumbuh Kembang Anak

Dalam memahami tumbuh kembang anak secara menyeluruh dan efektif, terdapat beberapa prinsip dasar penting yang harus dipahami oleh tenaga kesehatan maupun orang tua. Prinsip-prinsip tersebut membantu dalam pemantauan, evaluasi, serta intervensi yang tepat terhadap anak. Prinsip-prinsip dasar tumbuh kembang anak adalah sebagai berikut:

a. Tumbuh kembang bersifat teratur dan berurutan

Tumbuh kembang anak berlangsung secara teratur dan memiliki pola tertentu yang konsisten dari tahap yang sederhana menuju kompleks. Setiap tahap perkembangan merupakan dasar bagi tahap berikutnya, sehingga tahapan yang terlewati secara tidak sempurna dapat memengaruhi tahap selanjutnya.

b. Kecepatan tumbuh kembang setiap anak berbeda-beda

Setiap anak memiliki kecepatan tumbuh kembang yang unik, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti genetik, nutrisi, status kesehatan, serta stimulasi yang diberikan oleh lingkungan sekitar. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa perbedaan individual dalam kecepatan tumbuh kembang merupakan hal yang wajar.

- c. Tumbuh kembang berlangsung secara menyeluruh dan integratif
Proses tumbuh kembang mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan, yaitu aspek fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Keseimbangan antar aspek tersebut sangat penting dalam mencapai tumbuh kembang yang optimal.
- d. Pertumbuhan dan perkembangan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan
Pertumbuhan fisik dan perkembangan fungsi-fungsi tubuh berjalan seiring dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pertumbuhan yang optimal mendukung perkembangan kemampuan fungsi tubuh anak, sedangkan perkembangan fungsi tubuh yang baik menunjang proses pertumbuhan secara optimal.
- e. Faktor genetik dan lingkungan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak
Potensi genetik yang dimiliki oleh anak memberikan dasar pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan lingkungan berperan dalam memberikan stimulasi dan dukungan yang dibutuhkan anak untuk mencapai potensi optimalnya. Oleh karena itu, intervensi yang tepat melalui stimulasi lingkungan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

3. Tahap Tumbuh Kembang Menurut Kelompok Umur

Pemahaman tentang tahapan tumbuh kembang berdasarkan kelompok umur penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan pemantauan serta intervensi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka pada setiap tahap. Berikut ini penjelasan secara rinci mengenai tahap-tahap tumbuh kembang menurut kelompok umur:

a. Bayi (0-12 bulan)

Pada tahap ini, pertumbuhan fisik bayi berlangsung sangat cepat. Aspek tumbuh kembang yang penting diperhatikan pada usia ini meliputi:

- Pertumbuhan fisik: Pertambahan berat badan dan panjang badan yang signifikan, pertumbuhan lingkar kepala yang cepat.
- Perkembangan motorik kasar: Mulai dari kemampuan mengangkat kepala, berguling, duduk dengan bantuan, duduk mandiri, merangkak, hingga berjalan.
- Perkembangan motorik halus: Bayi mulai mampu menggenggam benda, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain, dan menjepit benda kecil dengan jari.

- Perkembangan sosial: Bayi mampu mengenali wajah orang tua, menunjukkan senyuman sosial pertama, merespon suara, serta menunjukkan rasa nyaman atau tidak nyaman terhadap lingkungan.

b. Balita (1-3 tahun)

Pada tahap balita, kecepatan pertumbuhan fisik mulai melambat dibandingkan tahap bayi, namun perkembangan fungsi tubuh meningkat secara signifikan. Aspek tumbuh kembang yang perlu diperhatikan mencakup:

- Pertumbuhan fisik: Berat dan tinggi badan meningkat lebih perlahan tetapi stabil.
- Perkembangan motorik kasar: Anak mampu berjalan dengan stabil, berlari, melompat, dan mulai belajar memanjat.
- Perkembangan motorik halus: Anak mulai dapat makan sendiri menggunakan alat makan sederhana, memakai pakaian dengan sedikit bantuan, menyusun balok, serta mencoret-coret di kertas.
- Perkembangan bahasa: Anak mampu mengucapkan kata-kata sederhana hingga membentuk kalimat pendek yang jelas.
- Perkembangan sosial: Anak mulai menunjukkan minat bermain dengan teman sebaya, meniru perilaku orang dewasa, serta mempelajari konsep sederhana tentang berbagi.

c. Anak Prasekolah (3-6 tahun)

Tahap ini ditandai dengan pertumbuhan fisik yang lebih stabil dan proporsional serta perkembangan berbagai fungsi tubuh yang semakin kompleks. Beberapa aspek tumbuh kembang yang menjadi perhatian khusus meliputi:

- Pertumbuhan fisik: Pertambahan tinggi badan dan berat badan berlangsung secara teratur dengan proporsi tubuh yang semakin ideal.
- Perkembangan motorik kasar: Anak mampu melakukan aktivitas fisik seperti melompat dengan satu kaki, bersepeda roda tiga atau dua, dan aktivitas fisik yang lebih kompleks lainnya.
- Perkembangan motorik halus: Anak mulai mampu menggambar dengan lebih rinci, menulis huruf atau angka sederhana, mengancingkan pakaian, dan menggunakan alat tulis dengan lebih baik.
- Perkembangan bahasa: Anak mampu berkomunikasi secara efektif menggunakan kalimat kompleks, memahami instruksi yang lebih rumit, serta mulai bercerita tentang pengalaman sehari-hari.

- Perkembangan sosial: Anak dapat beradaptasi dengan baik dalam kelompok, mengikuti aturan sederhana, bermain secara kooperatif, serta mulai mengembangkan keterampilan sosial seperti empati dan kerja sama.

D. Praktik

1. Praktik Pengukuran Antropometri

Pengukuran antropometri merupakan teknik penting yang digunakan untuk memantau pertumbuhan fisik bayi, balita, dan anak prasekolah secara rutin. Dengan melakukan pengukuran secara tepat dan konsisten, tenaga kesehatan dapat mendeteksi dini gangguan pertumbuhan serta memberikan intervensi yang sesuai.



Gambar 1.1 Pengukuran Antropometri

Berikut adalah langkah-langkah rinci dalam praktik pengukuran antropometri:

a. Menimbang Berat Badan

Alat: Timbangan bayi atau balita (digital atau manual)

Langkah-langkah:

- Pastikan timbangan berada pada permukaan datar dan stabil.
- Nol-kan atau kalibrasi timbangan sebelum menimbang.
- Lepaskan pakaian tebal dan alas kaki anak untuk akurasi maksimal.
- Letakkan bayi atau anak secara perlahan di tengah timbangan.
- Tunggu hingga angka stabil muncul di layar atau indikator timbangan.
- Catat hasil pengukuran berat badan hingga satu angka desimal terdekat.

b. Mengukur Panjang Badan Bayi (0-24 bulan)

Alat: Infantometer (alat ukur panjang bayi)

Langkah-langkah:

- Letakkan infantometer di atas permukaan yang datar dan stabil.
- Letakkan bayi dengan posisi terlentang di infantometer.
- Pastikan kepala bayi tegak lurus, menempel pada bagian kepala infantometer.
- Luruskan tubuh bayi dengan lembut, pastikan kaki lurus, rapat, dan tumit menempel pada bagian ujung infantometer.
- Geser bagian ujung infantometer hingga menyentuh tumit bayi tanpa tekanan berlebih.
- Catat hasil pengukuran panjang badan hingga satu angka desimal terdekat.

c. Mengukur Tinggi Badan Anak (di atas 24 bulan)

Alat: Stadiometer (alat pengukur tinggi badan)

Langkah-langkah:

- Letakkan stadiometer di lantai yang datar dan stabil.
- Anak berdiri tegak dengan tumit, bokong, punggung, dan kepala menempel pada stadiometer.
- Pastikan tumit anak rapat, pandangan lurus ke depan, dan tangan berada di sisi tubuh.
- Turunkan bagian geser stadiometer hingga menyentuh bagian atas kepala anak secara lembut tanpa menekan.
- Catat hasil pengukuran tinggi badan hingga satu angka desimal terdekat.

d. Mengukur Lingkar Kepala

Alat: Pita pengukur non-elastis

Langkah-langkah:

- Letakkan pita pengukur di sekitar kepala anak.
- Posisi pita berada tepat di atas alis, melewati telinga, dan bagian paling menonjol dari belakang kepala (oksipital).
- Pastikan pita tidak terlalu ketat maupun terlalu longgar.
- Catat hasil pengukuran lingkar kepala hingga satu angka desimal terdekat.

e. Dokumentasi Hasil Pengukuran

- Catat semua hasil pengukuran secara teliti.
- Masukkan data ke dalam grafik pertumbuhan yang sesuai dengan usia dan jenis kelamin anak.

- Analisis dan evaluasi hasil pengukuran untuk menentukan status pertumbuhan anak.
- Berikan edukasi dan tindak lanjut yang diperlukan kepada orang tua atau pengasuh berdasarkan hasil pengukuran.

2. Praktik Observasi Perkembangan Anak

Observasi perkembangan anak merupakan langkah penting dalam menilai dan memastikan tumbuh kembang anak berjalan sesuai tahapannya. Observasi ini melibatkan penilaian mendalam pada aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, dan emosional.

Berikut adalah panduan lengkap dan sistematis untuk melakukan praktik observasi perkembangan anak:

a. Observasi Motorik Kasar



Gambar 1.2 Perkembangan Motorik Kasar

Observasi ini bertujuan menilai kemampuan anak dalam menggunakan otot besar tubuhnya:

- Bayi (0-12 bulan): Amati kemampuan bayi untuk mengangkat kepala saat tengkurap, kemampuan berguling, duduk dengan atau tanpa bantuan, merangkak, berdiri sambil berpegangan, dan mulai berjalan.

- Balita (1-3 tahun): Perhatikan kemampuan anak berjalan stabil, berlari tanpa terjatuh, menaiki dan menuruni tangga dengan pegangan, melompat dengan dua kaki, dan mulai memanjat dengan pengawasan.
- Anak Prasekolah (3-6 tahun): Amati kemampuan anak melompat dengan satu kaki, berlari dan berhenti dengan kontrol yang baik, naik sepeda roda tiga atau dua, serta aktivitas fisik yang lebih terkoordinasi.

b. Observasi Motorik Halus



Gambar 1.3 Perkembangan Motorik Halus

Observasi motorik halus bertujuan untuk menilai kemampuan anak menggunakan otot kecil, terutama di tangan dan jari:

- Bayi (0-12 bulan): Perhatikan kemampuan menggenggam benda, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain, serta kemampuan mengambil benda kecil menggunakan jari telunjuk dan ibu jari (pincer grasp).
- Balita (1-3 tahun): Amati kemampuan anak makan menggunakan sendok secara mandiri, memakai pakaian sederhana, menyusun balok sederhana menjadi menara, serta mencoret-coret di kertas.
- Anak Prasekolah (3-6 tahun): Observasi kemampuan anak menggambar bentuk sederhana, mulai menulis huruf atau angka sederhana, menggunakan gunting untuk memotong garis lurus, dan mengancingkan atau membuka kancing pakaian sendiri.

c. Observasi Perkembangan Bahasa



Gambar 1.4 Perkembangan Bahasa

Observasi perkembangan bahasa bertujuan menilai kemampuan komunikasi verbal anak:

- Bayi (0-12 bulan): Amati respons bayi terhadap suara dan bunyi-bunyi lingkungan, respons terhadap panggilan nama, serta munculnya celotehan seperti "ma-ma" atau "pa-pa".
- Balita (1-3 tahun): Observasi kemampuan anak dalam mengucapkan kata tunggal hingga kalimat pendek, merespon instruksi sederhana, dan mulai bertanya atau mengekspresikan keinginannya.
- Anak Prasekolah (3-6 tahun): Amati kemampuan anak menggunakan kalimat kompleks, bercerita tentang pengalaman atau kejadian sederhana, memahami dan mengikuti instruksi lebih kompleks, serta berpartisipasi dalam percakapan dengan jelas.

d. Observasi Perkembangan Sosial dan Emosional

Observasi ini bertujuan menilai bagaimana anak berinteraksi secara sosial serta bagaimana ia menunjukkan emosi:

- Bayi (0-12 bulan): Perhatikan bagaimana bayi merespons interaksi dengan orang tua atau pengasuh, ekspresi wajah yang ditampilkan (senang, sedih, takut), serta reaksi terhadap lingkungan baru.

- Balita (1-3 tahun): Amati bagaimana anak mulai berinteraksi dengan teman sebaya, kemampuan berbagi atau bergantian mainan, serta cara mengekspresikan emosinya secara verbal maupun non-verbal.
 - Anak Prasekolah (3-6 tahun): Observasi kemampuan anak bermain dalam kelompok, mengikuti aturan permainan sederhana, menunjukkan empati kepada teman sebaya, serta mengelola emosinya ketika menghadapi situasi stres atau konflik.
- e. Dokumentasi dan Evaluasi Hasil Observasi
- Pencatatan hasil observasi dilakukan secara terperinci dan terstruktur, meliputi:
- Identitas anak yang diamati (nama lengkap, usia, jenis kelamin, tanggal observasi).
 - Hasil observasi pada masing-masing aspek (motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial dan emosional).
 - Bandingkan hasil observasi dengan pedoman standar perkembangan anak sesuai usia.
 - Tuliskan kesimpulan mengenai status perkembangan anak, apakah sesuai usia, mengalami keterlambatan, atau membutuhkan intervensi khusus.
 - Berikan rekomendasi lanjutan berupa saran stimulasi atau intervensi yang diperlukan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

3. Praktik Edukasi kepada Orang Tua atau Pengasuh

Praktik edukasi kepada orang tua atau pengasuh sangat penting dalam mendukung perkembangan optimal anak. Dengan pemahaman dan keterampilan yang tepat, orang tua atau pengasuh mampu memberikan stimulasi yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Berikut adalah langkah-langkah lengkap dalam praktik edukasi ini:

a. Pentingnya Stimulasi Dini

Awali edukasi dengan memberikan penjelasan tentang pentingnya stimulasi dini bagi anak:

- Stimulasi dini membantu mempercepat perkembangan otak dan kemampuan fisik, bahasa, sosial, serta emosional anak.
- Stimulasi yang tepat sejak dini dapat mencegah atau mengurangi risiko keterlambatan perkembangan.
- Stimulasi rutin dapat membantu anak mencapai perkembangan optimal sesuai potensi genetik dan lingkungannya.

b. Jenis Stimulasi Sesuai Usia dan Aspek Perkembangan

Berikan edukasi secara detail mengenai jenis-jenis stimulasi yang dapat diberikan berdasarkan usia anak:

1) Stimulasi Motorik Kasar

- Bayi (0-12 bulan): Memberikan waktu tummy time (posisi tengkurap), membantu bayi duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan dengan aman.
- Balita (1-3 tahun): Mengajak bermain bola, berlari, melompat, memanjat di tempat yang aman, serta menari atau bergerak mengikuti musik.
- Anak Prasekolah (3-6 tahun): Mengajak anak bersepeda, bermain permainan yang melibatkan aktivitas fisik seperti lompat tali atau kejar-kejaran.

2) Stimulasi Motorik Halus

- Bayi (0-12 bulan): Memberikan mainan bertekstur lembut yang mudah digenggam, permainan memindahkan benda dari tangan ke tangan lain, serta latihan menjepit benda kecil.
- Balita (1-3 tahun): Menyediakan puzzle sederhana, balok susun, permainan plastisin, atau memberikan alat gambar untuk mencoret-coret di kertas.
- Anak Prasekolah (3-6 tahun): Mengajak anak menggambar, mewarnai, menulis huruf atau angka sederhana, serta bermain dengan alat yang membutuhkan keterampilan jari seperti gunting dan mengancingkan pakaian.

3) Stimulasi Bahasa

- Bayi (0-12 bulan): Berbicara secara rutin kepada bayi, membacakan buku cerita bergambar, bernyanyi, serta merespon suara bayi dengan komunikasi aktif.
- Balita (1-3 tahun): Rutin membaca buku cerita yang sederhana, berbicara dan bertanya mengenai kegiatan sehari-hari anak, mengajak anak bernyanyi lagu anak-anak.
- Anak Prasekolah (3-6 tahun): Mengajak anak bercerita tentang pengalaman sehari-hari, berdiskusi tentang buku cerita yang dibacakan, mengenalkan kosakata baru, serta melatih anak untuk menjawab pertanyaan dengan kalimat lengkap.

4) Stimulasi Sosial dan Emosional

- Bayi (0-12 bulan): Memberikan perhatian penuh dan responsif, sering melakukan kontak mata, berbicara lembut, serta memberikan sentuhan kasih sayang.

- Balita (1-3 tahun): Mengajak anak bermain bersama teman sebaya, mengenalkan konsep berbagi, mengungkapkan dan mengenali emosi sederhana seperti senang atau sedih.
 - Anak Prasekolah (3-6 tahun): Melatih anak bermain dalam kelompok, mengenalkan aturan sederhana dalam permainan, mengajarkan anak cara mengekspresikan emosi secara positif, serta mengembangkan rasa empati terhadap orang lain.
- c. Metode Demonstrasi Langsung
- Lakukan demonstrasi langsung di depan orang tua atau pengasuh:
- Tunjukkan bagaimana melakukan stimulasi motorik kasar, seperti bermain bola atau berlari bersama anak.
 - Demonstrasikan cara menggunakan mainan yang merangsang motorik halus seperti puzzle atau balok susun.
 - Tunjukkan bagaimana membaca buku cerita dengan interaktif, mengajak anak berbicara dan bernyanyi.
 - Perlihatkan cara berinteraksi dengan anak secara sosial dan emosional, seperti memberikan perhatian, sentuhan kasih sayang, serta mengajarkan anak cara bermain secara kooperatif.

4. Praktik Dokumentasi Hasil Pemeriksaan dan Evaluasi

Praktik dokumentasi hasil pemeriksaan dan evaluasi tumbuh kembang anak merupakan langkah krusial dalam praktik kebidanan. Dokumentasi yang sistematis dan akurat sangat membantu tenaga kesehatan dalam pemantauan tumbuh kembang anak secara kontinu, mendeteksi secara dini berbagai masalah, dan menentukan intervensi yang tepat waktu. Berikut adalah langkah-langkah lengkap untuk melakukan dokumentasi hasil pemeriksaan dan evaluasi secara rinci:

a. Dokumentasi Hasil Pengukuran Antropometri

Setelah melakukan pengukuran antropometri, catat hasilnya secara detail dalam grafik pertumbuhan:

- Berat badan dicatat dalam kilogram hingga satu angka desimal terdekat.
- Panjang badan atau tinggi badan dicatat dalam sentimeter hingga satu angka desimal terdekat.
- Lingkar kepala dicatat dalam sentimeter hingga satu angka desimal terdekat.
- Gunakan grafik pertumbuhan yang sesuai dengan usia dan jenis kelamin anak, seperti grafik WHO atau KMS (Kartu Menuju Sehat).

- Tandai dengan jelas titik pengukuran pada grafik dan hubungkan antar titik untuk melihat tren pertumbuhan anak.
- b. Dokumentasi Hasil Observasi Perkembangan Anak
- Catat secara sistematis hasil observasi perkembangan anak yang mencakup aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, dan emosional:
- Motorik Kasar: Tuliskan kemampuan spesifik anak yang diamati sesuai usianya, seperti kemampuan mengangkat kepala, duduk mandiri, berjalan, atau melompat.
 - Motorik Halus: Catat secara detail kemampuan menggenggam, memindahkan benda, menggunakan alat makan, menyusun balok, menggambar atau menulis.
 - Bahasa: Dokumentasikan respons anak terhadap suara, kemampuan berbicara, mulai dari kata tunggal hingga kalimat kompleks, serta pemahaman terhadap instruksi.
 - Sosial dan Emosional: Catat interaksi anak dengan orang lain, respons emosionalnya terhadap situasi baru, kemampuan bermain dengan teman sebaya, serta cara anak mengelola emosi dalam berbagai situasi.
- Setiap catatan observasi harus jelas, objektif, dan mencakup tanggal serta usia anak pada saat pemeriksaan.
- c. Kesimpulan dan Penilaian Tumbuh Kembang
- Berdasarkan hasil pengukuran antropometri dan observasi perkembangan, buatlah kesimpulan atau penilaian tumbuh kembang anak:
- Tentukan apakah pertumbuhan fisik anak berada dalam kategori normal, kurang, atau lebih dibandingkan dengan standar usia.
 - Tentukan apakah perkembangan motorik, bahasa, sosial, dan emosional anak sesuai dengan tahap perkembangan normal atau terdapat tanda-tanda keterlambatan atau gangguan.
 - Kesimpulan harus mencakup penilaian menyeluruh berdasarkan data objektif yang telah dicatat.
- d. Rencana Tindak Lanjut dan Rekomendasi Intervensi
- Setelah menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, tentukan rencana tindak lanjut dan rekomendasi intervensi yang tepat:
- Jika tumbuh kembang anak dalam batas normal, buat jadwal pemantauan rutin berikutnya.

- Jika terdapat keterlambatan atau masalah tumbuh kembang, tentukan intervensi spesifik seperti stimulasi tambahan, rujukan ke spesialis, atau tindakan medis yang diperlukan.
- Berikan rekomendasi kepada orang tua atau pengasuh tentang cara memberikan stimulasi di rumah sesuai dengan kebutuhan spesifik anak.
- Jadwalkan evaluasi ulang untuk memantau perkembangan setelah intervensi dilakukan.

E. Tugas Mandiri

Petunjuk:

Kerjakan tugas berikut ini dengan jelas, rinci, dan terstruktur. Setiap tugas harus didasarkan pada konsep tumbuh kembang yang telah dipelajari.

Tugas 1: Esai Definisi Pertumbuhan dan Perkembangan

Tuliskan esai singkat minimal 250 kata tentang definisi pertumbuhan dan perkembangan. Jelaskan perbedaan keduanya secara rinci dan berikan masing-masing satu contoh nyata yang dapat ditemukan dalam praktik kebidanan sehari-hari.

Tugas 2: Analisis Prinsip Dasar Tumbuh Kembang

Pilih dua prinsip dasar tumbuh kembang yang menurut Anda paling penting. Jelaskan secara rinci alasan Anda memilih prinsip-prinsip tersebut, serta bagaimana penerapannya dalam praktik kebidanan untuk mendukung tumbuh kembang optimal pada anak.

Tugas 3: Observasi Tahap Tumbuh Kembang

Lakukan observasi langsung terhadap seorang anak dalam salah satu kelompok usia berikut: bayi (0-12 bulan), balita (1-3 tahun), atau anak prasekolah (3-6 tahun). Dokumentasikan hasil observasi Anda pada aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, dan emosional. Bandingkan hasil observasi Anda dengan pedoman standar tumbuh kembang yang berlaku.

Tugas 4: Pembuatan Grafik Pertumbuhan Antropometri

Pilih seorang anak untuk dilakukan pengukuran antropometri (berat badan, tinggi/panjang badan, dan lingkar kepala). Catat hasil pengukuran dalam grafik pertumbuhan yang sesuai dengan usia dan jenis kelamin anak tersebut. Buat kesimpulan dan analisis singkat mengenai status pertumbuhan anak berdasarkan grafik tersebut.

Tugas 5: Edukasi Stimulasi Tumbuh Kembang

Susunlah materi edukasi sederhana yang dapat Anda sampaikan kepada orang tua atau pengasuh mengenai pentingnya stimulasi tumbuh kembang dini. Materi edukasi tersebut harus mencakup jenis stimulasi yang tepat sesuai kelompok usia dan aspek perkembangan (motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial dan emosional). Jelaskan juga metode demonstrasi yang akan Anda gunakan saat memberikan edukasi. Setiap tugas harus disusun secara jelas dan sistematis dalam format dokumen yang rapi.

F. Soal Kasus

Soal 1:

Seorang bayi perempuan berusia 9 bulan datang ke posyandu dengan berat badan 6,5 kg, panjang badan 65 cm, dan lingkar kepala 40 cm.

Menurut grafik pertumbuhan WHO, bayi tersebut berada di bawah garis normal. Kondisi ini termasuk dalam:

- A. Tumbuh kembang normal
- B. Pertumbuhan optimal
- C. Pertumbuhan kurang
- D. Perkembangan terhambat
- E. Perkembangan optimal

Soal 2:

Seorang balita laki-laki berusia 2 tahun belum mampu berjalan tanpa pegangan, namun mampu duduk sendiri, merangkak, dan berdiri dengan bantuan.

Menurut tahap perkembangan motorik kasar, kondisi anak ini menunjukkan:

- A. Perkembangan motorik normal
- B. Perkembangan motorik halus optimal
- C. Keterlambatan perkembangan motorik kasar
- D. Keterlambatan perkembangan bahasa
- E. Gangguan perkembangan emosional

Soal 3:

Seorang anak perempuan usia 4 tahun sangat sulit berinteraksi dengan teman sebaya, enggan berbagi, serta cenderung bermain sendiri.

Dalam aspek sosial dan emosional, kondisi anak tersebut dapat dikategorikan sebagai:

- A. Perkembangan sosial emosional optimal

- B. Perkembangan sosial emosional terlambat
- C. Perkembangan bahasa optimal
- D. Perkembangan motorik kasar terhambat
- E. Perkembangan motorik halus optimal

Soal 4:

Seorang anak usia 3 tahun mampu menggambar bentuk lingkaran, menggunakan gunting sederhana, dan mulai mengancingkan baju sendiri.

Berdasarkan tahapan tumbuh kembang, kondisi ini menggambarkan:

- A. Keterlambatan motorik kasar
- B. Perkembangan motorik halus yang optimal
- C. Perkembangan bahasa terlambat
- D. Perkembangan sosial emosional terlambat
- E. Gangguan tumbuh kembang

Soal 5:

Seorang balita berusia 18 bulan mampu mengatakan sekitar 10 kata sederhana namun belum mampu menyusun dua kata menjadi satu kalimat pendek.

Dalam aspek perkembangan bahasa, kondisi anak ini:

- A. Normal untuk usia tersebut
- B. Mengalami keterlambatan bicara berat
- C. Mengalami gangguan motorik halus
- D. Mengalami gangguan perkembangan emosional
- E. Memiliki perkembangan bahasa yang optimal

Kunci Jawaban:

1. Jawaban: C. Pertumbuhan kurang

Pembahasan:

Berdasarkan grafik pertumbuhan WHO, bayi usia 9 bulan dengan berat 6,5 kg dan panjang 65 cm berada di bawah garis normal, menandakan kondisi pertumbuhan kurang. Tindakan yang harus dilakukan adalah evaluasi lebih lanjut mengenai nutrisi, status kesehatan, dan stimulasi lingkungan.

2. Jawaban: C. Keterlambatan perkembangan motorik kasar

Pembahasan:

Normalnya anak usia 12-15 bulan sudah mampu berjalan sendiri tanpa bantuan. Anak usia 2 tahun yang belum mampu berjalan tanpa pegangan menunjukkan keterlambatan perkembangan motorik kasar, memerlukan stimulasi tambahan dan evaluasi lebih lanjut.

3. Jawaban: B. Perkembangan sosial emosional terlambat

Pembahasan:

Anak usia 4 tahun seharusnya sudah mampu bermain kooperatif dan mulai memahami konsep berbagi. Kondisi sulit berinteraksi dan enggan berbagi menunjukkan keterlambatan perkembangan sosial emosional yang memerlukan intervensi segera berupa stimulasi sosial.

4. Jawaban: B. Perkembangan motorik halus yang optimal

Pembahasan:

Anak usia 3 tahun memang sudah mampu menggambar bentuk sederhana, menggunakan gunting untuk memotong garis sederhana, dan mulai belajar mengancingkan pakaian sendiri. Kondisi tersebut menunjukkan perkembangan motorik halus yang optimal sesuai usia.

5. Jawaban: A. Normal untuk usia tersebut

Pembahasan:

Balita usia 18 bulan memang mampu mengucapkan sekitar 10-20 kata tunggal, namun umumnya belum mampu menyusun kalimat dua kata. Kondisi ini adalah perkembangan bahasa yang normal untuk anak usia tersebut.

G. Soal OSCE

SOAL OSCE KEBIDANAN

Judul Stasiun : Observasi Perkembangan Balita Usia 2 Tahun
Waktu Pelaksanaan : 10 menit

Skenario Kasus:

Anda seorang bidan yang sedang bertugas di Posyandu. Seorang ibu membawa anaknya yang berusia 2 tahun untuk pemeriksaan rutin perkembangan anak. Ibu khawatir karena merasa anaknya belum lancar bicara dan sulit berinteraksi dengan teman sebayanya.

Tugas Peserta:

1. Lakukan observasi perkembangan anak secara lengkap pada aspek motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, dan emosional sesuai pedoman tumbuh kembang anak usia 2 tahun.
2. Catat hasil observasi secara sistematis.
3. Sampaikan hasil observasi dan berikan edukasi serta rekomendasi intervensi kepada ibu.

Tugas Penguji:

1. Amati dengan teliti setiap tindakan peserta dalam melaksanakan observasi.
2. Berikan nilai sesuai rubrik penilaian yang tersedia.
3. Jangan memberikan arahan selama observasi berlangsung.
4. Berikan umpan balik konstruktif setelah peserta selesai melakukan tugasnya.

Tugas Pasien Simulasi (Ibu Anak):

1. Bersikap cemas mengenai kondisi perkembangan bicara dan interaksi sosial anak.
2. Jawablah pertanyaan peserta sesuai kondisi anak Anda dengan jelas dan singkat.

Alat dan Bahan:

- Pedoman Observasi Perkembangan Anak (KPSP)
- Alat tulis dan formulir dokumentasi observasi perkembangan
- Kursi dan meja untuk duduk nyaman
- Mainan sederhana untuk membantu observasi (balok susun, puzzle sederhana, bola kecil, buku cerita bergambar)

RUBRIK PENILAIAN OSCE

No	Aspek Penilaian	Kriteria Penilaian	Poin Maksimal
1	Persiapan dan Komunikasi	Menyapa, memperkenalkan diri, dan menjelaskan tujuan observasi secara jelas (5) / Kurang jelas (3) / Tidak dilakukan (0)	5
2	Persiapan Alat	Alat observasi lengkap dan tepat (5) / Sebagian lengkap (3) / Tidak disiapkan (0)	5
3	Observasi Motorik Kasar	Observasi lengkap dan benar (10) / Sebagian benar (5) / Tidak dilakukan (0)	10
4	Observasi Motorik Halus	Observasi lengkap dan benar (10) / Sebagian benar (5) / Tidak dilakukan (0)	10
5	Observasi Bahasa	Observasi lengkap dan benar (15) / Sebagian benar (8) / Tidak dilakukan (0)	15
6	Observasi Sosial dan Emosional	Observasi lengkap dan benar (15) / Sebagian benar (8) / Tidak dilakukan (0)	15
7	Dokumentasi Hasil Observasi	Dokumentasi jelas dan lengkap (10) / Sebagian jelas (5) / Tidak jelas (0)	10
8	Penjelasan Hasil Observasi ke Ibu	Jelas, lugas, dan lengkap (10) / Sebagian jelas (5) / Tidak jelas (0)	10
9	Edukasi dan Rekomendasi Intervensi	Tepat dan jelas (10) / Sebagian tepat (5) / Tidak tepat (0)	10
10	Sikap Profesional (Empati, sopan, menjaga privasi pasien)	Dilakukan dengan tepat (10) / Kurang tepat (5) / Tidak dilakukan (0)	10
Total Skor			100

Skor Kelulusan Minimal: 70 poin

Bab 2

Perkembangan Bayi (0–12 Bulan)

A. Pendahuluan

Periode perkembangan bayi usia 0–12 bulan merupakan tahap penting yang menentukan pertumbuhan fisik, mental, emosional, dan sosial anak. Pemahaman mengenai tahap-tahap perkembangan bayi akan membantu bidan dalam memberikan asuhan kebidanan yang optimal serta melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan gangguan perkembangan yang bisa timbul pada bayi.

B. Capaian Pembelajaran

1. CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan)

Mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan keterampilan praktik dalam pemantauan serta penatalaksanaan tumbuh kembang bayi usia 0–12 bulan secara profesional dan komprehensif.

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri tumbuh kembang normal bayi, memahami aspek perkembangan fisik, motorik, kognitif, emosional, bahasa, dan sosial bayi usia 0–12 bulan serta mampu melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi sesuai standar profesi bidan.

3. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Mahasiswa mampu menjelaskan ciri-ciri tumbuh kembang bayi usia 0–12 bulan.
- Mahasiswa mampu mendeskripsikan perkembangan fisik, motorik kasar, dan motorik halus bayi usia 0–12 bulan.

- Mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan kognitif, emosional, bahasa, dan sosial bayi usia 0–12 bulan.
- Mahasiswa mampu melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi sesuai standar profesi bidan.
- Mahasiswa mampu melakukan deteksi dini gangguan tumbuh kembang bayi.

C. Ciri - Ciri Tumbuh Kembang Normal Bayi

1. Pertumbuhan Fisik Sesuai Grafik Tumbuh Kembang

Pertumbuhan fisik bayi mencakup peningkatan berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala secara proporsional dan konsisten sesuai dengan usia bayi. Pemantauan dilakukan menggunakan grafik pertumbuhan WHO atau Kartu Menuju Sehat (KMS).

Indikator Pertumbuhan Normal

Berat Badan:

- 0–3 bulan: kenaikan sekitar 700–1000 gram/bulan.
- 4–6 bulan: kenaikan sekitar 500–600 gram/bulan.
- 7–12 bulan: kenaikan sekitar 300–400 gram/bulan.

Tinggi/Panjang Badan:

- 0–6 bulan: kenaikan 1,5–2,5 cm per bulan.
- 7–12 bulan: kenaikan sekitar 1–1,5 cm per bulan.

Lingkar Kepala:

- 0–6 bulan: kenaikan sekitar 1–2 cm per bulan.
- 7–12 bulan: kenaikan sekitar 0,5 cm per bulan.

2. Pola Tidur dan Makan yang Teratur

Bayi sehat memiliki pola tidur dan makan yang berkembang menjadi lebih teratur seiring bertambahnya usia.

Usia 0–3 bulan:

- Tidur: sekitar 14–17 jam per hari, pola tidur tidak teratur.
- Makan: ASI atau susu formula setiap 2–3 jam.

Usia 4–6 bulan:

- Tidur: sekitar 12–16 jam per hari, tidur malam mulai teratur.
- Makan: mulai diperkenalkan makanan pendamping ASI (MPASI) pada usia 6 bulan.

Usia 7–12 bulan:

- Tidur: sekitar 11–14 jam, tidur malam lebih lama, tidur siang teratur.
- Makan: pola makan teratur 3 kali sehari dengan tambahan 2–3 kali camilan.

3. Peningkatan Keterampilan Motorik Secara Bertahap



Gambar 2.1 Bayi Bermain Merangkak

Perkembangan motorik bayi terbagi menjadi motorik kasar dan motorik halus yang berkembang secara bertahap sesuai usia.

Motorik Kasar:

- 0–3 bulan: Mengangkat kepala saat tengkurap.
- 4–6 bulan: Berguling, mulai duduk dengan bantuan.
- 7–9 bulan: Duduk mandiri, merangkak.
- 10–12 bulan: Berdiri dan mulai berjalan dengan bantuan.

Motorik Halus:

- 0–3 bulan: Refleks menggenggam.
- 4–6 bulan: Meraih dan memegang benda.
- 7–9 bulan: Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain.
- 10–12 bulan: Mulai menggunakan ibu jari dan telunjuk untuk mengambil benda kecil (pincer grasp).

4. Respons Emosional dan Sosial Sesuai Usia



Gambar 2.2 Bayi Menangis Saat Bermain

Respons emosional dan sosial bayi berkembang sesuai dengan usia dan lingkungan interaksinya.

0–3 bulan:

- Senyum refleks menjadi senyum sosial.
- Mengenali suara orang tua.

4–6 bulan:

- Menunjukkan ekspresi emosi lebih jelas (bahagia, takut, marah).
- Menunjukkan minat terhadap wajah baru.

7–9 bulan:

- Mulai menunjukkan kecemasan terhadap orang asing (*stranger anxiety*).
- Mulai meniru ekspresi wajah orang lain.

10–12 bulan:

- Menunjukkan ikatan emosional kuat dengan pengasuh utama (*separation anxiety*).
- Merespons namanya sendiri dan memahami beberapa perintah sederhana.

D. Perkembangan Fisik, Motorik Kasar, dan Motorik Halus Bayi (0–12 Bulan)

1. Usia 0–3 Bulan

a. Perkembangan Fisik

Pada periode ini, bayi mengalami peningkatan berat badan sekitar 700–1000 gram setiap bulan. Pertumbuhan otot dan kontrol kepala berkembang secara signifikan.

b. Motorik Kasar

- Bayi memiliki refleks primitif seperti refleks Moro, refleks rooting (menoleh ke arah sentuhan pipi), refleks menggenggam, dan refleks mengisap.
- Mampu mengangkat kepala sebentar saat tengkurap di usia sekitar 1–2 bulan.
- Menggerakkan tangan dan kaki secara refleks dan acak.

c. Motorik Halus

- Menggenggam jari atau benda kecil dengan refleks menggenggam yang kuat.
- Belum mampu mengontrol gerakan tangan secara sadar.

2. Usia 4–6 Bulan

a. Perkembangan Fisik

Pertumbuhan tetap stabil dengan kenaikan berat badan sekitar 500–600 gram setiap bulan. Bayi mulai memiliki kekuatan otot yang lebih baik.

b. Motorik Kasar

- Mulai berguling dari posisi tengkurap ke posisi terlentang dan sebaliknya di usia sekitar 5 bulan.
- Dapat duduk dengan bantuan atau ditopang di usia sekitar 5–6 bulan.
- Mulai menumpu berat badan dengan kaki saat digendong dalam posisi berdiri.

c. Motorik Halus

- Mampu meraih benda di dekatnya dengan lebih terarah.
- Mulai memegang benda dengan telapak tangan (palmar grasp).
- Menggerakkan benda yang dipegangnya ke mulut untuk eksplorasi.

3. Usia 7–9 Bulan

a. Perkembangan Fisik

Pertumbuhan fisik melambat sedikit, dengan penambahan berat badan sekitar 400 gram per bulan. Otot menjadi semakin kuat dan bayi semakin aktif.

b. Motorik Kasar

- Dapat duduk mandiri tanpa bantuan di usia sekitar 7–8 bulan.
- Mulai merangkak atau bergerak dengan cara menarik badan.

- Bisa berpindah posisi dari duduk ke posisi merangkak dan sebaliknya.
- c. Motorik Halus
- Mulai memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya.
 - Mulai menggunakan jari-jari untuk memegang benda kecil.
 - Mampu mengambil benda kecil dengan metode seperti menjumput (pincer grasp sederhana).

4. Usia 10–12 Bulan

- a. Perkembangan Fisik
- Pertumbuhan melambat menjadi sekitar 300 gram per bulan. Bayi semakin ramping dan kuat.
- b. Motorik Kasar
- Berdiri dengan bantuan atau sambil berpegangan pada benda (meja, kursi) diusia sekitar 10 bulan.
 - Mulai berjalan dengan bantuan, seperti merambat di perabotan rumah.
 - Beberapa bayi mulai berjalan selangkah dua langkah tanpa bantuan menjelang usia 12 bulan.
- c. Motorik Halus
- Mampu mengambil benda kecil dengan ibu jari dan telunjuk secara baik (pincer grasp).
 - Bisa menunjuk benda dengan jari telunjuk.
 - Mulai memasukkan benda ke dalam wadah dan mengeluarkannya kembali.

5. Strategi Mendukung Perkembangan Motorik Bayi

- Berikan stimulasi berupa tummy time (posisi tengkurap) untuk memperkuat otot leher dan tubuh.
- Berikan mainan yang aman untuk mendukung keterampilan menggenggam dan meraih.
- Latih bayi duduk dan berdiri secara bertahap sesuai usianya.
- Dorong eksplorasi yang aman untuk meningkatkan perkembangan motorik kasar dan halus.

6. Deteksi Dini Gangguan Perkembangan Motorik

- Perhatikan bayi yang belum mampu mengangkat kepala pada usia 3 bulan.
- Waspadai jika bayi belum bisa duduk tanpa bantuan pada usia 9 bulan.
- Konsultasikan ke ahli jika bayi belum mulai merangkak atau berdiri dengan bantuan menjelang usia 12 bulan.

E. Perkembangan Kognitif, Emosional, Bahasa, dan Sosial Bayi (0–12 Bulan)

1. Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif bayi berhubungan dengan bagaimana bayi belajar, berpikir, dan memecahkan masalah.

Ciri Perkembangan Kognitif Bayi:

a. Mengenali wajah dan suara orang tua:

- Usia 0–3 bulan: mulai mengenali wajah orang tua, tertarik pada wajah manusia.
- Usia 4–6 bulan: menunjukkan preferensi terhadap wajah yang dikenal dan suara yang familiar.

b. Mengeksplorasi benda:

- Bayi menggunakan mulut dan tangan untuk mengeksplorasi lingkungan.
- Mulai usia 4 bulan, bayi aktif menjangkau benda dan membawanya ke mulut sebagai bentuk eksplorasi sensorik.

2. Perkembangan Emosional

Perkembangan emosional bayi adalah kemampuan bayi untuk mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi.

Tahapan Perkembangan Emosional:

Menunjukkan emosi dasar:

- Usia 0–3 bulan: bayi mulai mengekspresikan rasa nyaman dan tidak nyaman melalui tangisan atau senyuman.
- Usia 4–6 bulan: mampu menunjukkan emosi senang, takut, marah secara lebih jelas.
- Usia 7–12 bulan: menunjukkan kecemasan terhadap orang asing (*stranger anxiety*) dan kecemasan perpisahan (*separation anxiety*).

3. Perkembangan Bahasa



Gambar 2.3 Bayi Belajar Membaca

Perkembangan bahasa bayi mencakup kemampuan bayi untuk memahami dan menggunakan bahasa.

Tahapan Perkembangan Bahasa:

a. Mengoceh (babbling):

- Usia 0–3 bulan: mulai membuat suara berupa vokal sederhana seperti "aa", "oo".
- Usia 4–6 bulan: ocehan mulai beragam dengan kombinasi vokal dan konsonan seperti "ba-ba", "da-da".

b. Reaksi terhadap suara:

- Bayi bereaksi dengan menolehkan kepala atau berhenti menangis ketika mendengar suara familiar.

c. Menyebut kata sederhana:

- Menjelang usia 12 bulan, bayi mulai mengucapkan kata sederhana seperti "mama", "papa", atau kata lain yang sering didengar dalam lingkungan keluarga.

4. Perkembangan Sosial

Perkembangan sosial bayi adalah kemampuan bayi dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sosialnya.

Ciri Perkembangan Sosial:

a. Tersenyum sosial:

Mulai muncul pada usia sekitar 6 minggu, bayi merespons interaksi sosial dengan tersenyum.

b. Meniru gerakan:

Usia 6–9 bulan: bayi mulai meniru gerakan sederhana seperti melambaikan tangan atau bertepuk tangan.

c. Keterikatan (attachment):

Usia 7–12 bulan: bayi menunjukkan keterikatan kuat pada pengasuh utama dan merasa gelisah jika terpisah.

5. Strategi Stimulasi Perkembangan Kognitif, Emosional, Bahasa, dan Sosial

- **Beri stimulasi kognitif** dengan berbagai mainan yang aman, bertekstur berbeda, dan warna mencolok.
- **Respon emosi bayi** dengan ekspresi wajah yang jelas untuk membantu bayi mengenali dan mengelola emosinya.
- **Gunakan bahasa jelas dan sederhana** saat berbicara dengan bayi, sering menyebutkan nama benda dan aktivitas sehari-hari.
- **Interaksi sosial secara rutin** seperti berbicara, bernyanyi, atau bermain untuk memperkuat hubungan emosional dan sosial bayi dengan lingkungannya.

6. Deteksi Dini Gangguan Perkembangan Kognitif, Emosional, Bahasa, dan Sosial

- Jika bayi tidak menunjukkan respons terhadap suara atau wajah hingga usia 3–4 bulan.
- Jika bayi tidak menunjukkan ketertarikan eksplorasi benda hingga usia 6 bulan.
- Bayi tidak mengoceh atau bereaksi terhadap panggilan nama pada usia 9–10 bulan.
- Bayi tidak menunjukkan emosi dasar atau keterikatan sosial menjelang usia 12 bulan.

F. Pemantauan Tumbuh Kembang Bayi Sesuai Standar Profesi Bidan

1. Pengukuran Antropometri



Gambar 2.4 Pengukuran Kepala Bayi

Pengukuran antropometri adalah metode pengukuran fisik tubuh bayi yang meliputi:

a. Berat Badan

- Gunakan timbangan bayi digital atau manual dengan ketelitian minimal 10 gram.
- Pastikan bayi tidak mengenakan pakaian berat saat pengukuran.

b. Tinggi/Panjang Badan

- Untuk bayi usia < 2 tahun, gunakan infantometer dalam posisi berbaring.
- Pastikan kepala, tubuh, dan tumit bayi dalam posisi sejajar dan lurus.

c. Lingkar Kepala

- Gunakan pita pengukur lentur dengan ketelitian minimal 0,1 cm.
- Lingkar kepala diukur pada titik terbesar, melewati bagian tengah dahi dan bagian belakang kepala (oksipital).

2. Penggunaan Grafik WHO atau Kartu Menuju Sehat (KMS)

Pengukuran hasil antropometri dicatat dalam grafik WHO atau KMS untuk menilai status pertumbuhan bayi secara visual.

Langkah-langkah penggunaan KMS:

- a. Catat hasil pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala.
- b. Plot hasil pada grafik pertumbuhan WHO atau KMS.

- c. Evaluasi tren pertumbuhan dari waktu ke waktu:
- Pertumbuhan optimal mengikuti garis kurva standar.
 - Pertumbuhan bermasalah ditandai dengan pola yang stagnan atau menurun.

3. Mengamati Milestone Perkembangan

Milestone perkembangan adalah pencapaian kemampuan bayi sesuai usia, seperti motorik kasar dan halus, kemampuan sosial, kognitif, dan bahasa.

a. Milestone utama bayi (contoh):

- 0–3 bulan: Mengangkat kepala, senyum sosial.
- 4–6 bulan: Berguling, meraih benda.
- 7–9 bulan: Duduk mandiri, merangkak.
- 10–12 bulan: Berdiri dengan bantuan, mengatakan kata sederhana seperti "mama" atau "papa".

b. Metode Observasi:

- Lakukan observasi secara berkala setiap bulan.
- Gunakan tabel atau daftar milestone perkembangan untuk pencatatan.
- Diskusikan hasil observasi dengan orang tua.

4. Konseling Perkembangan Kepada Orang Tua

Bidan berperan penting dalam memberikan konseling perkembangan bayi kepada orang tua. Konseling ini bertujuan meningkatkan pemahaman orang tua terhadap tumbuh kembang anak.

a. Isi Konseling yang Perlu Disampaikan

- Informasi tentang milestone perkembangan normal.
- Stimulasi yang tepat sesuai usia bayi.
- Cara membaca grafik pertumbuhan (KMS).
- Tanda-tanda peringatan yang harus diwaspadai.
- Pentingnya pemeriksaan rutin bayi di fasilitas kesehatan.

b. Teknik Konseling Efektif

- Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
- Libatkan orang tua secara aktif dalam diskusi.
- Berikan demonstrasi cara stimulasi yang tepat.
- Tawarkan dukungan emosional dan berikan motivasi positif pada orang tua.

5. Strategi Stimulasi untuk Mendukung Tumbuh Kembang

- Stimulasi fisik: tummy time, latihan duduk dan berdiri.
- Stimulasi kognitif: menyediakan mainan aman yang dapat diraih, digenggam, dan dieksplorasi.
- Stimulasi bahasa: sering berbicara dengan bayi, bernyanyi, membaca buku cerita sederhana.
- Stimulasi sosial dan emosional: respon terhadap emosi bayi, berikan interaksi sosial secara rutin.

6. Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang

- Perhatikan pola pertumbuhan yang tidak sesuai dengan grafik.
- Bayi tidak mencapai milestone sesuai usia (misalnya, belum duduk pada usia 9 bulan).
- Tanda gangguan neurologis seperti kelemahan anggota tubuh, kurang responsif terhadap stimulus.

G. Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang Bayi

1. Identifikasi Keterlambatan Motorik atau Gangguan Koordinasi

Keterlambatan motorik merupakan kondisi ketika bayi tidak mencapai kemampuan motorik yang sesuai usianya.

Tanda-tanda Gangguan Motorik atau Koordinasi:

a. Usia 0–3 bulan:

- Tidak mampu mengangkat kepala saat tengkurap pada usia 3 bulan.
- Tidak ada refleks menggenggam atau refleks lainnya yang normalnya ada.

b. Usia 4–6 bulan:

- Tidak mampu berguling pada usia 6 bulan.
- Tidak mampu duduk dengan bantuan pada usia 6 bulan.
- Gerakan tangan tampak kaku atau tidak simetris.

c. Usia 7–9 bulan:

- Tidak mampu duduk mandiri atau merangkak pada usia 9 bulan.
- Tidak menunjukkan usaha untuk bergerak aktif.

d. Usia 10–12 bulan:

- Belum mampu berdiri dengan bantuan pada usia 12 bulan.
- Tidak menunjukkan perkembangan berjalan selangkah dua langkah meskipun dengan bantuan.

2. Mengenali Tanda-tanda Gangguan Pendengaran atau Penglihatan

Deteksi dini gangguan pendengaran atau penglihatan sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap perkembangan bahasa, sosial, dan kognitif bayi.

Tanda-tanda Gangguan Pendengaran:

- Bayi tidak merespon suara keras atau tidak terkejut oleh suara yang tiba-tiba hingga usia 3 bulan.
- Bayi tidak menoleh ke arah sumber suara hingga usia 6 bulan.
- Tidak mengoceh atau tidak bereaksi terhadap suara orang tua pada usia 9 bulan.
- Tidak merespon panggilan namanya pada usia 10–12 bulan.

Tanda-tanda Gangguan Penglihatan:

- Mata bayi tidak mengikuti benda atau wajah bergerak hingga usia 3 bulan.
- Bayi tampak tidak tertarik terhadap objek yang ditempatkan di depannya pada usia 4–6 bulan.
- Mata bayi sering terlihat menyipit, juling, atau bola mata bergerak tidak normal.
- Tidak meraih atau mengambil objek dengan koordinasi mata-tangan yang tepat pada usia 7–9 bulan.

3. Mengenali Gangguan Bahasa dan Sosial pada Bayi Usia Dini

Perkembangan bahasa dan sosial bayi yang optimal merupakan indikator penting dari perkembangan neurologis yang sehat.

Tanda-tanda Gangguan Bahasa:

- Tidak mengoceh (babbling) atau membuat suara vokal sederhana hingga usia 6 bulan.
- Tidak meniru suara sederhana atau tidak mencoba berbicara pada usia 9 bulan.
- Tidak mengucapkan kata sederhana seperti "mama" atau "papa" pada usia 12 bulan.

Tanda-tanda Gangguan Sosial:

- Tidak menunjukkan senyum sosial hingga usia 3 bulan.
- Tidak menunjukkan ketertarikan terhadap interaksi sosial hingga usia 6 bulan.
- Tidak meniru gerakan sederhana seperti melambai atau bertepuk tangan pada usia 9 bulan.
- Tidak menunjukkan keterikatan emosional dengan pengasuh utama pada usia 12 bulan.

Langkah-langkah yang Harus Diambil Bidan dalam Deteksi Dini

- Melakukan pemantauan rutin tumbuh kembang bayi.

- Menggunakan alat bantu seperti checklist milestone perkembangan.
- Memberikan edukasi kepada orang tua tentang tanda-tanda gangguan tumbuh kembang.
- Merujuk segera ke ahli spesialis jika menemukan tanda-tanda gangguan tumbuh kembang.

4. Intervensi Dini dan Dukungan

Intervensi yang tepat waktu dan efektif sangat penting untuk meminimalisir dampak gangguan tumbuh kembang:

- Terapi Fisik: untuk gangguan motorik dan koordinasi.
- Terapi Wicara: untuk gangguan bahasa.
- Intervensi Audiologis dan Oftalmologis: untuk gangguan pendengaran dan penglihatan.
- Terapi Perilaku dan Sosial: untuk gangguan sosial dan emosional.

H. Praktik

Tujuan Praktik:

Mahasiswa mampu melaksanakan pemantauan tumbuh kembang bayi secara komprehensif, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan perkembangan pada bayi usia 0–12 bulan.

Kompetensi yang Diharapkan:

1. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran antropometri (berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala bayi) secara akurat.
2. Mahasiswa mampu menggunakan grafik WHO atau Kartu Menuju Sehat (KMS) untuk evaluasi tumbuh kembang bayi.
3. Mahasiswa mampu mengamati milestone perkembangan bayi sesuai usianya.
4. Mahasiswa mampu memberikan konseling perkembangan kepada orang tua.
5. Mahasiswa mampu mendeteksi dini gangguan tumbuh kembang pada bayi.

Alat dan Bahan:

- Timbangan bayi (digital/manual)
- Infantometer (pengukur panjang badan bayi)
- Pita pengukur lingkar kepala
- Grafik pertumbuhan WHO atau KMS
- Buku catatan perkembangan bayi
- Checklist milestone perkembangan bayi

Prosedur Praktik:

1. Pengukuran Antropometri
 - Cuci tangan sebelum melakukan pengukuran.
 - Timbang bayi tanpa pakaian atau dengan pakaian seminimal mungkin.
 - Ukur panjang badan bayi menggunakan infantometer dalam posisi bayi berbaring telentang, kepala dan tumit sejajar.
 - Ukur lingkar kepala bayi dengan pita ukur lentur di titik terbesar lingkar kepala.
 - Catat hasil pengukuran dengan teliti.
2. Penggunaan Grafik WHO atau KMS
 - Plot hasil pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala bayi ke dalam grafik WHO atau KMS.
 - Analisis tren pertumbuhan bayi berdasarkan grafik.
 - Diskusikan hasilnya dengan orang tua dan jelaskan makna grafik tersebut.
3. Observasi Milestone Perkembangan
 - Lakukan observasi terhadap kemampuan motorik kasar, motorik halus, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional bayi.
 - Gunakan checklist perkembangan untuk memastikan bayi mencapai milestone sesuai usianya.
 - Catat pencapaian milestone secara teratur setiap bulan.
4. Konseling Perkembangan kepada Orang Tua
 - Sampaikan hasil pengukuran antropometri dan observasi perkembangan secara jelas kepada orang tua.
 - Berikan informasi mengenai tahapan perkembangan bayi sesuai usia.
 - Edukasi orang tua tentang stimulasi tumbuh kembang yang sesuai dengan usia bayi.
 - Berikan informasi mengenai tanda-tanda peringatan atau gangguan tumbuh kembang yang harus diperhatikan orang tua.
5. Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang
 - Perhatikan bayi yang menunjukkan tanda-tanda keterlambatan motorik atau koordinasi.
 - Evaluasi respons bayi terhadap suara atau benda untuk deteksi gangguan pendengaran dan penglihatan.
 - Observasi kemampuan bahasa dan interaksi sosial bayi.
 - Jika ditemukan tanda-tanda gangguan, segera konsultasikan atau rujuk ke tenaga kesehatan yang berkompeten.

Evaluasi Praktik:

Mahasiswa dinilai berdasarkan ketepatan pengukuran antropometri, kemampuan menggunakan grafik WHO/KMS, ketelitian observasi milestone perkembangan, kualitas konseling yang diberikan, serta kepekaan dalam mendeteksi dini gangguan tumbuh kembang.

Penugasan:

Mahasiswa diwajibkan membuat laporan praktik yang mencakup:

- Hasil pengukuran antropometri dan plot grafik WHO atau KMS.
- Hasil observasi milestone perkembangan.
- Catatan hasil konseling yang diberikan kepada orang tua.
- Evaluasi deteksi dini gangguan tumbuh kembang bayi serta rekomendasi tindakan lanjut.

I. Tugas**Tugas 1: Observasi dan Analisis Grafik Pertumbuhan Bayi**

- Pilih seorang bayi usia 0–12 bulan di lingkungan sekitar Anda.
- Lakukan pengukuran antropometri (berat badan, panjang badan, lingkar kepala).
- Catat dan plot hasil pengukuran pada grafik pertumbuhan WHO atau Kartu Menuju Sehat (KMS).
- Buat analisis singkat tentang status pertumbuhan bayi berdasarkan grafik tersebut.

Tugas 2: Milestone Perkembangan Bayi

- Pilih bayi berusia antara 0–12 bulan dan lakukan observasi langsung.
- Catat pencapaian milestone motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, dan emosional bayi.
- Bandingkan hasil observasi dengan milestone standar berdasarkan usia bayi.
- Buat laporan hasil observasi beserta rekomendasi stimulasi tambahan jika diperlukan.

Tugas 3: Penyusunan Materi Edukasi untuk Orang Tua

- Buat materi edukasi sederhana tentang pentingnya pemantauan tumbuh kembang bayi.
- Materi harus mencakup indikator pertumbuhan normal, milestone perkembangan bayi, dan tanda-tanda gangguan tumbuh kembang yang perlu diwaspadai.
- Sajikan materi dalam bentuk brosur atau leaflet yang menarik dan mudah dipahami.

Tugas 4: Studi Kasus Gangguan Tumbuh Kembang Bayi

- Analisis sebuah studi kasus bayi yang mengalami keterlambatan motorik atau gangguan bahasa.
- Jelaskan tanda-tanda gangguan yang terlihat dalam kasus tersebut.
- Berikan usulan langkah-langkah intervensi dini yang sebaiknya dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan.

Tugas 5: Praktik Konseling Perkembangan kepada Orang Tua

- Lakukan simulasi praktik konseling perkembangan bayi dengan rekan sekelas sebagai orang tua bayi.
- Jelaskan hasil pemantauan tumbuh kembang, milestone yang dicapai, serta stimulasi yang diperlukan.
- Rekam proses konseling tersebut dan buat laporan reflektif mengenai kelebihan dan kekurangan dalam komunikasi serta saran perbaikan.

J. Soal Kasus Kebidanan

Soal 1:

Seorang bayi perempuan berusia 3 bulan dibawa ibunya ke klinik. Dari hasil observasi, bayi belum mampu mengangkat kepala saat posisi tengkurap.

Apa yang harus segera dilakukan bidan dalam kondisi ini?

- A. Memberikan susu formula tambahan
- B. Melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan memberikan stimulasi
- C. Memberikan vitamin penambah energi
- D. Menyarankan istirahat lebih banyak
- E. Memberikan terapi wicara dini

Soal 2:

Seorang ibu mengeluhkan bahwa bayinya yang berusia 8 bulan belum mampu duduk mandiri tanpa bantuan.

Berdasarkan standar milestone perkembangan, apakah tindakan yang tepat untuk dilakukan bidan?

- A. Memberikan rujukan ke ahli fisioterapi
- B. Menyarankan latihan motorik kasar lebih intensif di rumah
- C. Memberikan vitamin penambah nafsu makan
- D. Menyarankan mengganti susu formula
- E. Mengajarkan bayi untuk berjalan langsung

Soal 3:

Seorang bayi laki-laki berusia 5 bulan dibawa ke fasilitas kesehatan dengan keluhan tidak merespon saat dipanggil namanya dan jarang menoleh ke arah sumber suara.

Apa kemungkinan gangguan yang dialami oleh bayi tersebut?

- A. Gangguan motorik halus
- B. Gangguan pendengaran
- C. Gangguan pertumbuhan fisik
- D. Gangguan pola tidur
- E. Gangguan emosi sosial

Soal 4:

Seorang bayi perempuan berusia 11 bulan belum mampu berdiri atau berjalan meskipun dengan bantuan. Bayi juga terlihat sering kesulitan meraih benda-benda kecil di sekitarnya.

Apa tindakan terbaik yang dilakukan bidan?

- A. Menunggu hingga bayi berusia 18 bulan
- B. Memberikan vitamin khusus perkembangan motorik
- C. Melakukan pemeriksaan mendalam terkait perkembangan motorik kasar dan halus
- D. Menyarankan bayi segera masuk daycare
- E. Memberikan edukasi tentang pola makan bayi

Soal 5:

Seorang ibu membawa bayinya berusia 7 bulan ke bidan karena bayi belum mengoceh (babbling) sama sekali, dan tidak ada reaksi ketika mendengar suara orang tua.

Apa langkah awal yang paling tepat dilakukan oleh bidan?

- A. Menyarankan pemeriksaan ke dokter spesialis anak atau THT
- B. Memberikan MPASI lebih dini
- C. Mengajarkan bayi bicara lebih sering di rumah
- D. Mengubah pola tidur bayi
- E. Mengurangi stimulus suara di sekitar bayi

Kunci Jawaban:

1. Jawaban: B

Pembahasan: Bayi usia 3 bulan seharusnya telah mampu mengangkat kepala saat tengkurap. Ketidakmampuan ini bisa menandakan keterlambatan perkembangan motorik. Bidan perlu melakukan pemeriksaan lanjutan dan segera memberikan stimulasi yang sesuai agar keterlambatan ini tidak semakin bertambah.

2. Jawaban: A

Pembahasan: Pada usia 7–9 bulan, bayi seharusnya sudah mampu duduk mandiri tanpa bantuan. Jika bayi belum mencapai milestone ini pada usia 8 bulan, maka harus segera dirujuk untuk pemeriksaan dan intervensi lebih lanjut seperti fisioterapi.

3. Jawaban: B

Pembahasan: Pada usia 4–6 bulan, bayi seharusnya sudah mampu bereaksi terhadap suara, termasuk suara orang tua atau suara keras lainnya. Ketidakmampuan bayi untuk bereaksi terhadap suara mengindikasikan kemungkinan adanya gangguan pendengaran yang perlu segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

4. Jawaban: C

Pembahasan: Bayi usia 10–12 bulan biasanya sudah mulai mampu berdiri dan berjalan dengan bantuan serta mengambil benda kecil dengan ibu jari dan telunjuk. Keterlambatan dalam hal ini menunjukkan adanya potensi gangguan perkembangan motorik kasar dan halus yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan intervensi dini.

5. Jawaban: A

Pembahasan: Bayi usia 7 bulan seharusnya sudah mengoceh secara aktif dan bereaksi terhadap suara familiar. Ketidakmampuan ini mungkin merupakan tanda awal gangguan bahasa atau pendengaran. Bidan harus segera merujuk bayi untuk pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis anak atau THT agar diagnosis dan intervensi dini dapat dilakukan.

K. Soal OSCE

Skenario Kasus

Anda seorang bidan yang bertugas di klinik kesehatan anak dan menerima kunjungan ibu Ani yang membawa bayi perempuannya yang berusia 9 bulan untuk melakukan pemeriksaan tumbuh kembang rutin. Ibu Ani mengatakan bayi mulai duduk sendiri tetapi belum merangkak dan belum terlihat ingin bergerak aktif. Ia juga khawatir dengan pola makan anaknya yang menurutnya kurang teratur.

Tugas Peserta

1. Lakukan anamnesis singkat kepada ibu terkait tumbuh kembang bayi.
2. Lakukan pengukuran antropometri bayi (berat badan, panjang badan, lingkar kepala).
3. Plot hasil pengukuran ke grafik KMS dan interpretasikan hasilnya.
4. Lakukan observasi singkat milestone perkembangan bayi.
5. Berikan konseling singkat kepada ibu tentang perkembangan bayi yang normal pada usia 9 bulan, pola makan yang baik, serta stimulasi motorik kasar dan halus yang tepat.

Tugas Penguji

1. Mengamati dan menilai keterampilan peserta dalam melakukan anamnesis, pengukuran antropometri, dan plotting grafik KMS.
2. Mengamati keterampilan peserta dalam observasi milestone perkembangan bayi.
3. Menilai kemampuan komunikasi peserta saat memberikan konseling kepada ibu.
4. Mengisi rubrik penilaian yang telah disediakan secara objektif dan terstruktur.

Tugas Pasien Simulasi

- Berperan sebagai ibu Ani yang membawa bayi usia 9 bulan.
- Menjelaskan bahwa bayi belum merangkak, pola makan belum teratur, dan tampak cemas mengenai perkembangan anaknya.
- Menjawab pertanyaan peserta dengan informasi yang telah diskenariokan.

Alat dan Bahan

- Boneka bayi simulasi
- Timbangan bayi (manual atau digital)
- Infantometer
- Pita ukur lingkar kepala
- Grafik Kartu Menuju Sehat (KMS)
- Alat tulis (pena atau pensil)

Rubrik Penilaian

No	Aspek yang Dinilai	Nilai Maksimal	Nilai Diperoleh
1	Anamnesis Tumbuh Kembang	15	
	Menanyakan keluhan ibu secara jelas dan lengkap.	5	
	Menanyakan pola makan bayi secara tepat.	5	
	Menanyakan milestone motorik bayi secara tepat.	5	
2	Pengukuran Antropometri dan Plotting KMS	30	
	Mengukur berat badan dengan teknik benar.	10	
	Mengukur panjang badan dengan teknik benar.	10	
	Mengukur lingkar kepala dengan teknik benar.	5	
	Plotting hasil di grafik KMS secara akurat.	5	
3	Observasi Milestone Perkembangan Bayi	20	
	Observasi perkembangan motorik kasar dengan benar.	10	
	Observasi perkembangan motorik halus dengan benar.	10	
4	Konseling Tumbuh Kembang Bayi kepada Ibu	30	
	Memberikan informasi milestone normal usia 9 bulan.	10	
	Memberikan edukasi pola makan yang baik.	10	
	Memberikan edukasi stimulasi motorik yang tepat.	10	
5	Komunikasi dan Sikap Profesional	5	
	Berkomunikasi dengan efektif, jelas, dan sopan.	3	
	Menunjukkan empati dan perhatian kepada ibu bayi.	2	
	TOTAL NILAI	100	

Catatan:

Peserta dinyatakan kompeten jika memperoleh nilai minimal 75 dari total nilai maksimal 100.

Bab 3

Perkembangan Balita (1-5 Tahun)

A. Pendahuluan

Perkembangan balita usia 1–5 tahun merupakan periode kritis dalam menentukan kualitas tumbuh kembang anak secara fisik, motorik, sosial, emosi, bahasa, dan kognitif. Pemantauan dan deteksi dini terhadap kemungkinan gangguan tumbuh kembang sangat penting agar intervensi dapat segera diberikan. Bidan dan tenaga kesehatan memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan optimal balita melalui berbagai pendekatan stimulasi dan edukasi kepada orang tua.

B. Capaian Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu menguasai teori dan keterampilan dalam melakukan pemantauan, deteksi dini, serta penatalaksanaan tumbuh kembang balita usia 1–5 tahun secara holistik sesuai standar profesi kebidanan.

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik tumbuh kembang balita, memahami perkembangan fisik, motorik kasar dan halus, sosial, emosi, bahasa, serta kognitif balita usia 1–5 tahun, melakukan pengukuran tumbuh kembang berdasarkan grafik pertumbuhan WHO/NCHS, serta melakukan deteksi dini gangguan tumbuh kembang.

3. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- Menjelaskan karakteristik tumbuh kembang balita usia 1–5 tahun.
- Mendeskripsikan perkembangan fisik, motorik kasar, dan motorik halus balita.

- c. Menjelaskan perkembangan sosial, emosi, bahasa, dan kognitif balita.
- d. Melakukan pengukuran tumbuh kembang balita dengan grafik WHO/NCHS.
- e. Melakukan deteksi dini terhadap gangguan tumbuh kembang balita.

C. Karakteristik Tumbuh Kembang Balita

1. Pertumbuhan Fisik

Pada masa balita, pertumbuhan fisik anak relatif lebih lambat dibandingkan masa bayi, namun tetap stabil. Secara umum, berat badan anak bertambah sekitar 2–3 kg per tahun, dan tinggi badan bertambah sekitar 5–7 cm per tahun. Perubahan ini mencerminkan peningkatan massa otot, kekuatan tulang, dan koordinasi tubuh yang lebih baik.



Gambar 3.1 Pengukuran Tinggi Badan

2. Perkembangan Motorik

a. Motorik Kasar



Gambar 3.2 Bayi Mendorong Walker

Pada usia balita, anak menunjukkan peningkatan keterampilan motorik kasar, seperti:

- Berjalan dengan stabil pada usia sekitar 1–2 tahun.
- Berlari, melompat, dan naik-turun tangga dengan bantuan pada usia 2–3 tahun.
- Mengayuh sepeda roda tiga, melompat dengan satu kaki, dan berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik pada usia 3–4 tahun.
- Berjalan mundur, melompat jauh, dan naik-turun tangga secara mandiri pada usia 4–5 tahun.

b. Motorik Halus

Perkembangan motorik halus juga mengalami kemajuan pesat, seperti:

- Menyusun balok dan mengambil benda kecil dengan telunjuk dan ibu jari (pincer grasp) pada usia 1–2 tahun.
- Menggambar garis lurus dan lingkaran sederhana, menggunakan sendok secara mandiri pada usia 2–3 tahun.
- Menggunting dengan gunting anak, menggambar bentuk dasar seperti kotak, dan mulai berpakaian sendiri pada usia 3–4 tahun.
- Menulis huruf sederhana, menggambar orang dengan detail sederhana, dan makan dengan peralatan secara mandiri pada usia 4–5 tahun.

•

3. Perkembangan Bahasa



Gambar 3.3 Belajar Membaca

Bahasa menjadi karakteristik utama perkembangan balita, dengan tahap perkembangan sebagai berikut:

- Usia 1–2 tahun: mampu mengucapkan kata-kata tunggal dan mulai menyusun dua kata seperti "mau susu".
- Usia 2–3 tahun: mulai menggunakan kalimat sederhana terdiri dari tiga hingga lima kata, serta bertanya "apa" dan "kenapa".
- Usia 3–4 tahun: berbicara dalam kalimat kompleks, dapat bercerita sederhana, dan memahami perintah yang lebih rumit.
- Usia 4–5 tahun: mampu bercerita lebih jelas, memahami dan menggunakan kalimat lengkap, serta mampu menjelaskan konsep sederhana.

4. Perkembangan Sosial dan Emosional



Gambar 3.4 Bayi Bermain Bersama

Balita menunjukkan karakteristik perkembangan sosial-emosional yang khas, meliputi:

- Usia 1–2 tahun: menunjukkan ketertarikan bermain bersama teman sebaya secara paralel (bermain berdampingan tanpa interaksi langsung).
- Usia 2–3 tahun: mulai bermain kooperatif dengan teman sebaya, berbagi mainan, namun masih sering menunjukkan emosi yang kuat seperti tantrum.
- Usia 3–4 tahun: menunjukkan empati, mampu mengenali emosi orang lain, lebih kooperatif dalam permainan kelompok.
- Usia 4–5 tahun: memiliki kontrol emosional yang lebih baik, mampu mengikuti aturan permainan, dan membentuk persahabatan sederhana.

5. Perkembangan Kognitif

Perkembangan kognitif balita mencerminkan peningkatan kemampuan berpikir, belajar, dan memahami dunia sekitar:

- Usia 1–2 tahun: memahami konsep benda permanen, mulai menggunakan benda sesuai fungsinya.
- Usia 2–3 tahun: mulai mengenal warna dasar, memahami konsep jumlah sederhana seperti "satu" atau "banyak".
- Usia 3–4 tahun: dapat mengenal bentuk dasar, memahami konsep waktu sederhana seperti "pagi" dan "malam".
- Usia 4–5 tahun: mulai memahami angka sederhana, mampu mengikuti arahan kompleks, dan mengenal simbol atau huruf tertentu.

6. Strategi Stimulasi Optimal untuk Balita

- Stimulasi fisik: mengajak bermain aktif di luar ruangan.
- Stimulasi motorik halus: menyediakan alat-alat menggambar, menyusun balok, atau puzzle.
- Stimulasi bahasa: sering berbicara dengan kalimat jelas, membaca buku cerita.
- Stimulasi sosial-emosional: menyediakan kesempatan bermain bersama teman sebaya, memberikan penguatan positif terhadap perilaku baik.
- Stimulasi kognitif: memberikan permainan edukatif yang merangsang kemampuan berpikir dan memecahkan masalah.

7. Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang Balita

- Perhatikan keterlambatan atau gangguan dalam pencapaian milestone fisik, motorik, bahasa, sosial, emosional, atau kognitif.
- Segera lakukan konsultasi ke ahli kesehatan jika ditemukan tanda-tanda gangguan tumbuh kembang seperti keterlambatan bicara, kesulitan interaksi sosial, atau gangguan koordinasi motorik.

D. Perkembangan Fisik dan Motorik

1. Perkembangan Fisik Balita dan Anak Prasekolah

Pertumbuhan fisik selama periode balita (1–5 tahun) dan prasekolah (3–5 tahun) menunjukkan ciri khas berupa peningkatan berat badan dan tinggi badan yang stabil, serta perkembangan proporsi tubuh yang lebih seimbang.

Tahapan Pertumbuhan Fisik:

- Usia 1–2 tahun: Berat badan bertambah sekitar 2,5 kg per tahun, tinggi bertambah sekitar 10–12 cm.
- Usia 2–3 tahun: Pertumbuhan melambat dengan penambahan berat badan sekitar 2 kg per tahun, tinggi bertambah sekitar 7–8 cm.
- Usia 3–5 tahun: Berat badan bertambah sekitar 2–3 kg per tahun, tinggi badan bertambah sekitar 6–7 cm.

2. Perkembangan Motorik Kasar

Motorik kasar melibatkan otot-otot besar yang memungkinkan anak melakukan gerakan tubuh yang kompleks.

Tahapan Perkembangan Motorik Kasar:

- a. Usia 1–2 tahun:
 - Berjalan tanpa bantuan
 - Mulai berlari dengan langkah pendek
 - Memanjat tangga dengan bantuan
- b. Usia 2–3 tahun:
 - Berlari dengan lebih stabil
 - Melompat dengan kedua kaki
 - Menendang bola dengan keseimbangan terbatas
- c. Usia 3–4 tahun:
 - Melompat dengan satu kaki
 - Mengayuh sepeda roda tiga
 - Menangkap bola dengan kedua tangan
- d. Usia 4–5 tahun:
 - Melompat jauh sekitar 30–40 cm
 - Menari mengikuti irama
 - Berdiri dengan satu kaki selama 5 detik atau lebih

3. Perkembangan Motorik Halus

Motorik halus berkaitan dengan koordinasi otot kecil seperti jari-jari tangan, yang penting untuk aktivitas sehari-hari seperti makan, berpakaian, dan menulis.

Tahapan Perkembangan Motorik Halus:

- a. Usia 1–2 tahun:
 - Menggunakan ibu jari dan telunjuk untuk mengambil benda kecil
 - Menyusun dua hingga empat balok
 - Menggunakan sendok dengan bantuan
- b. Usia 2–3 tahun:
 - Menggambar garis lurus dan lingkaran sederhana
 - Menggunakan sendok dan garpu secara mandiri
 - Menyusun enam hingga delapan balok
- c. Usia 3–4 tahun:
 - Menggambar bentuk dasar seperti lingkaran, kotak, dan garis lurus
 - Menggunakan gunting anak untuk memotong kertas sederhana
 - Mulai berpakaian sendiri dengan sedikit bantuan
- d. Usia 4–5 tahun:
 - Menulis huruf atau angka sederhana
 - Menggambar manusia dengan beberapa detail sederhana
 - Menggunakan alat tulis dengan pegangan tripod secara stabil

4. Strategi Stimulasi Motorik Kasar dan Halus

Stimulasi yang tepat sangat penting untuk mendukung perkembangan motorik kasar dan halus pada balita dan anak prasekolah:

- a. Stimulasi Motorik Kasar:
 - Bermain lempar tangkap bola
 - Menyediakan kesempatan berlari, melompat, dan memanjat dengan pengawasan
 - Mengajak bermain sepeda roda tiga atau sepeda roda dua dengan roda bantu
- b. Stimulasi Motorik Halus:
 - Bermain puzzle atau menyusun balok
 - Menggambar, mewarnai, dan melukis
 - Kegiatan prakarya sederhana seperti memotong, menempel, dan meronce

5. Deteksi Dini Gangguan Motorik

Deteksi dini sangat penting untuk mengatasi gangguan motorik sejak awal. Beberapa tanda yang perlu diperhatikan adalah:

- Balita usia 18 bulan belum bisa berjalan.
- Anak usia 3 tahun kesulitan menggunakan sendok atau tidak mampu menggambar garis lurus.
- Anak usia 4 tahun tidak mampu melompat atau kesulitan berlari.

E. Perkembangan Sosial, Emosi, Bahasa, dan Kognitif

1. Perkembangan Sosial Balita

Perkembangan sosial merujuk pada kemampuan anak untuk berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan sosialnya.

Tahapan Perkembangan Sosial:

- a. Usia 1–2 tahun:
 - Bermain paralel (bermain di dekat anak lain tanpa interaksi langsung)
 - Meniru perilaku orang dewasa
 - Mulai menyadari keberadaan orang lain
- b. Usia 2–3 tahun:
 - Bermain kooperatif sederhana dengan teman sebaya
 - Mulai berbagi mainan dengan bantuan
 - Mengikuti instruksi sederhana dalam kegiatan sosial
- c. Usia 3–4 tahun:
 - Bermain secara kooperatif dalam kelompok kecil
 - Menunjukkan empati kepada teman yang sedih atau terluka
 - Memahami konsep bergiliran dalam permainan
- d. Usia 4–5 tahun:
 - Menjalinkan persahabatan sederhana dengan teman sebaya
 - Mampu berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dengan lebih baik
 - Memahami dan mengikuti aturan sosial sederhana

2. Perkembangan Emosi Balita

Perkembangan emosional adalah kemampuan anak dalam mengenali, memahami, dan mengelola emosi dirinya serta berempati terhadap orang lain.

Tahapan Perkembangan Emosional:

- a. Usia 1–2 tahun:
 - Menunjukkan emosi dasar seperti senang, marah, takut, dan sedih dengan jelas
 - Mudah mengalami tantrum akibat kesulitan mengontrol emosi
- b. Usia 2–3 tahun:
 - Mulai menunjukkan kontrol emosi yang lebih baik, walaupun masih sering tantrum
 - Mulai mengenali emosi orang lain
- c. Usia 3–4 tahun:
 - Menunjukkan empati yang nyata terhadap perasaan orang lain
 - Mulai mampu mengungkapkan perasaan dengan kata-kata
- d. Usia 4–5 tahun:
 - Menunjukkan kontrol emosi yang jauh lebih baik
 - Memiliki pemahaman yang jelas mengenai emosi diri dan orang lain
 - Menyelesaikan konflik kecil secara verbal

3. Perkembangan Bahasa Balita

Kemampuan bahasa berkembang pesat selama masa balita, memungkinkan anak berkomunikasi secara efektif.

Tahapan Perkembangan Bahasa:

- a. Usia 1–2 tahun:
 - Menggunakan kata tunggal dan frasa dua kata sederhana
 - Mulai menggunakan sekitar 50 kata
- b. Usia 2–3 tahun:
 - Mampu membentuk kalimat pendek yang terdiri dari 3–4 kata
 - Mulai banyak bertanya dengan kata "apa" dan "kenapa"
- c. Usia 3–4 tahun:
 - Menggunakan kalimat lengkap yang terdiri dari 5–6 kata
 - Mulai bercerita tentang pengalaman pribadi sederhana
- d. Usia 4–5 tahun:
 - Berbicara dengan kalimat kompleks, mampu bercerita secara rinci
 - Menggunakan kosa kata lebih dari 1.000 kata
 - Memahami perintah kompleks dan menggunakan bahasa dalam konteks sosial yang tepat

4. Perkembangan Kognitif Balita

Perkembangan kognitif melibatkan cara anak berpikir, belajar, memahami, dan memecahkan masalah.

Tahapan Perkembangan Kognitif:

a. Usia 1–2 tahun:

- Memahami konsep benda permanen (benda masih ada meski tidak terlihat)
- Menunjukkan eksplorasi sensorik aktif terhadap lingkungan

b. Usia 2–3 tahun:

- Mulai mengenali warna dan bentuk sederhana
- Memahami konsep jumlah sederhana seperti "satu" atau "banyak"

c. Usia 3–4 tahun:

- Memahami konsep waktu sederhana seperti "sekarang", "nanti", "kemarin"
- Dapat memecahkan masalah sederhana seperti menyusun puzzle

d. Usia 4–5 tahun:

- Memahami angka sederhana dan mulai menghitung benda
- Mampu mengikuti arahan lebih kompleks dalam permainan

5. Strategi Stimulasi Perkembangan

a. Stimulasi Sosial dan Emosional:

- Mengajak anak bermain kelompok dan permainan bergiliran
- Melatih empati melalui cerita dan contoh nyata

b. Stimulasi Bahasa:

- Membaca buku cerita bersama secara rutin
- Mengajak berdiskusi mengenai aktivitas sehari-hari

c. Stimulasi Kognitif:

- Bermain puzzle, permainan mencocokkan bentuk dan warna
- Memberikan kesempatan eksplorasi lingkungan secara aktif dan aman

6. Deteksi Dini Gangguan Perkembangan

Deteksi dini sangat penting, perhatikan tanda-tanda berikut:

- Balita tidak melakukan kontak mata atau minim interaksi sosial
- Keterlambatan bicara signifikan pada usia 3 tahun
- Kesulitan dalam mengikuti arahan sederhana atau tidak bisa memahami instruksi sederhana di usia 4 tahun

F. Pengukuran Tumbuh Kembang Berdasarkan Grafik WHO/NCHS

1. Pentingnya Pemantauan Pertumbuhan Balita

Pemantauan pertumbuhan secara teratur penting karena:

- Memastikan bahwa balita mengalami pertumbuhan yang optimal sesuai usia.
- Mengidentifikasi gangguan pertumbuhan seperti stunting, wasting, obesitas secara dini.
- Menjadi dasar intervensi nutrisi dan kesehatan yang tepat.
- Memberikan informasi objektif kepada orang tua dan tenaga kesehatan mengenai status kesehatan anak.

2. Indikator Utama dalam Grafik Pertumbuhan

Dalam grafik pertumbuhan WHO/NCHS, beberapa indikator penting yang digunakan yaitu:

a. Berat Badan menurut Umur (BB/U)

Indikator ini menunjukkan pertumbuhan berat badan anak sesuai usia yang mencerminkan status gizi anak:

- Normal jika berada antara -2SD hingga +2SD.
- Di bawah -2SD menandakan gizi kurang.
- Di atas +2SD menandakan risiko kelebihan berat badan.

b. Tinggi/Panjang Badan menurut Umur (TB/U)

Indikator ini menunjukkan pertumbuhan tinggi badan anak berdasarkan umur yang mencerminkan pertumbuhan linear anak:

- Normal jika berada antara -2SD hingga +2SD.
- Di bawah -2SD menunjukkan kemungkinan stunting (pertumbuhan terhambat).
- Di atas +2SD menunjukkan tinggi badan lebih dari rata-rata.

c. Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB)

Indikator ini mencerminkan proporsi berat terhadap tinggi badan yang dapat mendeteksi wasting (kurus akut) atau obesitas:

- Normal jika berada antara -2SD hingga +2SD.
- Di bawah -2SD menandakan wasting.
- Di atas +2SD menunjukkan risiko obesitas.

d. Lingkar Kepala menurut Umur (LK/U)

Lingkar kepala digunakan untuk mengukur pertumbuhan otak anak:

- Normal jika berada antara -2SD hingga +2SD.
- Di bawah -2SD atau di atas +2SD memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

3. Langkah-langkah Melakukan Pengukuran

- Pengukuran Berat Badan: Menggunakan timbangan digital atau manual yang akurat.
- Pengukuran Tinggi/Panjang Badan: Menggunakan infantometer untuk anak di bawah 2 tahun (posisi berbaring), dan stadiometer untuk anak di atas 2 tahun (posisi berdiri).
- Pengukuran Lingkar Kepala: Menggunakan pita ukur fleksibel yang melingkari kepala melalui bagian terlebar (oksipital).

4. Plotting Data pada Grafik Pertumbuhan

- Catat hasil pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala.
- Temukan usia anak pada grafik dan plot data pada titik yang sesuai.
- Evaluasi status pertumbuhan anak berdasarkan posisi titik tersebut terhadap garis median atau standar deviasi (SD).

5. Interpretasi Hasil Pengukuran

- Pertumbuhan Optimal: Titik plot berada dalam kisaran $-2SD$ hingga $+2SD$, dengan pola konsisten mengikuti kurva pertumbuhan.
- Peringatan Dini: Titik plot berada di dekat garis $-2SD$ atau $+2SD$ atau menunjukkan tren pertumbuhan yang stagnan atau menurun drastis.
- Tindakan Segera: Titik plot keluar dari batas $-2SD$ atau $+2SD$ memerlukan tindakan pemeriksaan lanjutan dan intervensi nutrisi serta kesehatan segera.

6. Tindak Lanjut dan Intervensi

Jika ditemukan tanda gangguan pertumbuhan:

- Konsultasi gizi dengan ahli gizi atau tenaga kesehatan.
- Evaluasi pola makan dan aktivitas anak.
- Edukasi keluarga mengenai pola asuh gizi yang baik.
- Merujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan jika diperlukan.

G. Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang

1. Pengertian Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang

Deteksi dini gangguan tumbuh kembang adalah proses identifikasi awal terhadap kemungkinan adanya keterlambatan atau kelainan dalam aspek pertumbuhan (fisik) maupun perkembangan (motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional) pada anak, yang dilakukan secara sistematis, teratur, dan menggunakan instrumen baku. Deteksi

dini bertujuan agar gangguan tersebut dapat segera ditangani secara optimal sebelum semakin kompleks.

2. Tanda-Tanda Awal Gangguan Tumbuh Kembang Balita

Setiap gangguan tumbuh kembang memiliki tanda-tanda spesifik yang harus diwaspadai:

- a. Gangguan Perkembangan Motorik
 - Usia 12 bulan belum mampu berdiri walaupun dengan bantuan.
 - Usia 18 bulan belum mampu berjalan sendiri.
 - Usia 24 bulan belum mampu naik tangga dengan bantuan.
 - Gerakan tubuh asimetris atau tidak seimbang, seperti dominasi satu sisi tubuh.
- b. Gangguan Perkembangan Bahasa
 - Tidak mampu menyebut kata sederhana pada usia 18 bulan.
 - Belum mampu mengucapkan dua kata sederhana pada usia 24 bulan.
 - Tidak menunjukkan respons terhadap instruksi sederhana.
 - Kesulitan memahami atau mengekspresikan bahasa dibandingkan anak seusianya.
- c. Gangguan Perkembangan Kognitif
 - Tidak tertarik mengeksplorasi benda-benda baru.
 - Tidak mampu mengenal fungsi benda sederhana (misalnya sendok, gelas).
 - Kesulitan mengikuti arahan atau instruksi sederhana.
 - Lambat dalam mempelajari konsep baru seperti warna, angka, atau bentuk.
- d. Gangguan Perkembangan Sosial-Emosional
 - Tidak menunjukkan interaksi sosial, cenderung menarik diri atau agresif.
 - Tidak mampu bermain dengan teman sebaya atau tidak tertarik pada interaksi sosial.
 - Kesulitan mengenali atau mengontrol emosi, sering tantrum berlebihan atau agresif.
 - Tidak memiliki keterikatan emosional yang kuat dengan pengasuh utama.

3. Metode Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang Balita

Untuk mendeteksi gangguan tumbuh kembang secara efektif dan tepat waktu, metode berikut ini sering digunakan oleh tenaga kesehatan:

- a. Penggunaan Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan (KPSP)
KPSP digunakan pada anak usia 3 bulan hingga 72 bulan untuk mengetahui apakah perkembangan anak sesuai dengan usia atau mengalami keterlambatan. Kuesioner ini mudah diterapkan di Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya.
- b. Denver Developmental Screening Test II (DDST II)
DDST II merupakan instrumen standar internasional yang mengevaluasi empat aspek penting: personal-sosial, motorik kasar, motorik halus, dan bahasa. DDST II digunakan pada anak usia 0–6 tahun dan memberikan gambaran lengkap tentang pencapaian milestone anak dibandingkan anak seusianya.
- c. Observasi Klinis
Observasi langsung oleh tenaga kesehatan terhadap anak saat bermain atau berinteraksi dengan lingkungan sekitar memberikan informasi penting tentang kemampuan anak dalam aspek fisik, motorik, sosial, emosi, dan kognitif.

4. Wawancara dan Konseling Orang Tua

Orang tua adalah informan utama mengenai tumbuh kembang anak. Wawancara mendalam terkait perilaku anak sehari-hari, kebiasaan, atau respon terhadap lingkungan, dapat menjadi dasar kuat dalam deteksi dini gangguan perkembangan.

Langkah-Langkah Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang Balita

Berikut langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mendeteksi gangguan tumbuh kembang balita secara optimal:

- a. Lakukan anamnesis mendalam terhadap orang tua terkait riwayat kehamilan, persalinan, kelahiran, nutrisi, dan perkembangan anak sebelumnya.
- b. Observasi langsung terhadap perilaku dan aktivitas anak, terutama interaksi sosial, motorik, bahasa, dan emosi.
- c. Pengisian kuesioner KPSP atau instrumen deteksi dini lainnya secara rutin.
- d. Gunakan DDST II secara berkala minimal satu kali setiap 6 bulan.
- e. Edukasi orang tua tentang pentingnya pemantauan rutin dan tanda-tanda bahaya perkembangan.
- f. Rujuk ke spesialis (dokter anak, neurolog anak, psikolog anak) jika ditemukan tanda-tanda gangguan perkembangan signifikan.

5. Intervensi Dini untuk Gangguan Tumbuh Kembang Balita

Bila ditemukan gangguan tumbuh kembang pada anak, intervensi dini harus segera dilakukan, di antaranya:

- Terapi Fisik: Mengatasi gangguan motorik kasar atau halus.
- Terapi Wicara: Untuk gangguan bahasa dan komunikasi.
- Terapi Okupasi: Membantu anak agar lebih mandiri dalam aktivitas sehari-hari.
- Terapi Perilaku: Membantu anak dalam aspek sosial dan emosional, meningkatkan keterampilan sosial, serta mengelola emosi.
- Konseling Orang Tua: Memberikan informasi, dukungan, dan pelatihan kepada orang tua tentang cara menangani anak dengan gangguan perkembangan.

6. Peran Bidan dan dalam Deteksi Dini

Tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat memainkan peran penting dalam deteksi dini gangguan tumbuh kembang balita melalui:

- Melakukan skrining secara berkala di fasilitas kesehatan.
- Memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pentingnya pemantauan perkembangan secara rutin.
- Melakukan rujukan tepat waktu ke fasilitas spesialis jika ditemukan keterlambatan tumbuh kembang.
- Memberikan konseling dan dukungan emosional kepada orang tua selama proses identifikasi maupun intervensi dini.

H. Praktik

Pemantauan dan Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita (1–5 Tahun)

1. Tujuan Praktik

Setelah melakukan praktik ini, mahasiswa kebidanan diharapkan mampu:

- a. Melakukan pemantauan tumbuh kembang balita secara sistematis sesuai standar grafik pertumbuhan WHO/NCHS.
- b. Mengidentifikasi tanda-tanda gangguan tumbuh kembang secara dini.
- c. Melakukan edukasi yang efektif tentang stimulasi tumbuh kembang kepada orang tua balita.

2. Alat dan Bahan

- a. Timbangan balita digital/manual
- b. Stadiometer/Infantometer
- c. Pita ukur lingkar kepala
- d. Grafik pertumbuhan WHO/NCHS

- e. Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan (KPSP)
- f. Formulir observasi perkembangan balita
- g. Alat permainan edukatif (puzzle, balok, buku cerita sederhana)
- h. Buku catatan kesehatan anak (KIA)

3. Langkah-langkah Praktik

a. Persiapan

- Perkenalkan diri secara sopan kepada orang tua dan anak, jelaskan tujuan praktik.
- Siapkan alat-alat pemeriksaan di tempat yang nyaman.

b. Anamnesis (Wawancara)

- Lakukan wawancara mendalam dengan orang tua tentang riwayat kehamilan, persalinan, dan riwayat kesehatan anak.
- Gali informasi tentang kebiasaan nutrisi, tidur, aktivitas fisik, interaksi sosial, bahasa, dan kognitif balita.
- Tanyakan kepada orang tua tentang pencapaian perkembangan terbaru anak dan kekhawatiran yang mungkin dimiliki.

c. Pengukuran Antropometri

- Berat Badan: timbang balita dengan timbangan digital/manual. Catat hasil dengan ketelitian hingga 0,1 kg.
- Tinggi Badan: ukur tinggi badan dengan infantometer (anak di bawah 2 tahun) atau stadiometer (di atas 2 tahun). Catat dalam sentimeter.
- Lingkar Kepala: ukur lingkar kepala menggunakan pita ukur lentur yang dilingkarkan melalui bagian terlebar kepala (oksipital dan dahi).

d. Plotting Data pada Grafik Pertumbuhan WHO/NCHS

- Plot hasil pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala ke grafik pertumbuhan.
- Interpretasikan hasil:
 - Pertumbuhan normal: data berada antara -2 SD hingga +2 SD.
 - Gangguan pertumbuhan: data di luar batas -2 SD atau +2 SD, perlu evaluasi lebih lanjut.

e. Observasi Perkembangan

- Gunakan Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan (KPSP) sesuai usia anak.
- Observasi langsung anak saat bermain untuk mengamati kemampuan motorik kasar, motorik halus, bahasa, sosial, dan emosional.

- Catat observasi dengan detail pada formulir yang tersedia.
- f. Edukasi Orang Tua
- Berikan edukasi tentang tahapan perkembangan balita sesuai usia.
 - Jelaskan hasil pengukuran tumbuh kembang anak secara jelas dan mudah dimengerti.
 - Berikan informasi tentang stimulasi yang tepat sesuai usia balita:
 - Motorik kasar (contoh: bermain bola, sepeda roda tiga).
 - Motorik halus (contoh: menggambar, meronce, bermain puzzle).
 - Bahasa dan kognitif (contoh: membaca buku, bermain peran sederhana).
 - Sosial-emosional (contoh: bermain bersama teman sebaya, penguatan positif).
- g. Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang
- Jelaskan kepada orang tua tentang tanda-tanda peringatan dini gangguan tumbuh kembang:
 - Keterlambatan bicara
 - Kesulitan interaksi sosial
 - Gangguan motorik kasar dan halus
 - Gangguan emosi dan perilaku yang mencolok
 - Jika ditemukan tanda bahaya, rujuk ke dokter spesialis anak atau klinik tumbuh kembang anak.
- h. Dokumentasi
- Catat semua data hasil pengukuran, observasi, dan edukasi dalam buku catatan kesehatan anak (KIA) atau formulir pemeriksaan tumbuh kembang.
 - Berikan salinan hasil pemeriksaan kepada orang tua dan jelaskan tindakan tindak lanjut.

4. Evaluasi Praktik (Penilaian Keterampilan Mahasiswa)

No.	Aspek Penilaian	Skor (1–5)	Keterangan
1	Kesiapan alat dan kelengkapan praktik		
2	Kemampuan komunikasi interpersonal		
3	Ketepatan pengukuran antropometri		
4	Ketepatan plotting grafik pertumbuhan		
5	Ketelitian observasi perkembangan balita		
6	Kemampuan edukasi tentang stimulasi		
7	Ketepatan deteksi dini gangguan perkembangan		
8	Dokumentasi yang jelas dan rapi		
	Total Skor		

Kriteria Penilaian:

5 = Sangat Baik, 4 = Baik, 3 = Cukup, 2 = Kurang, 1 = Sangat Kurang

Skor Minimal Lulus: 28 dari total 40

5. Tindak Lanjut Hasil Praktik

- Jika ditemukan kelainan tumbuh kembang, berikan rujukan segera ke dokter spesialis anak atau ahli tumbuh kembang anak.
- Jadwalkan pemantauan berkala minimal setiap 3–6 bulan.
- Libatkan orang tua dalam proses pemantauan, edukasi, dan stimulasi tumbuh kembang balita.

6. Dokumentasi dan Pelaporan Praktik

Mahasiswa wajib melaporkan hasil praktik dalam bentuk laporan tertulis sesuai format standar, dilengkapi dengan dokumentasi hasil pengukuran, grafik pertumbuhan, catatan observasi perkembangan, serta dokumentasi edukasi kepada orang tua.

I. Tugas

Tugas 1: Observasi dan Laporan Perkembangan Motorik Kasar dan Halus

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu melakukan observasi langsung dan mendeskripsikan perkembangan motorik kasar dan halus pada balita secara tepat.

Langkah-Langkah:

1. Pilih satu balita berusia 1–5 tahun sebagai objek observasi.
2. Lakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas motorik kasar (berlari, melompat, naik turun tangga) dan motorik halus (menggambar, menyusun balok, menggunakan sendok) balita tersebut.
3. Catat hasil pengamatan secara detail pada lembar observasi.
4. Buat laporan analisis sederhana tentang pencapaian perkembangan motorik balita berdasarkan tahapan yang sesuai usia.

Output Tugas:

Laporan observasi perkembangan motorik balita.

Tugas 2: Studi Kasus Deteksi Dini Gangguan Bahasa pada Balita

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu melakukan deteksi dini dan memberikan rekomendasi intervensi pada gangguan bahasa balita.

Langkah-Langkah:

1. Pilih balita berusia 2–4 tahun dengan dugaan keterlambatan bahasa.
2. Wawancara orang tua untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan bahasa sehari-hari balita.
3. Gunakan instrumen KPSP atau DDST II untuk mengidentifikasi tanda gangguan bahasa.
4. Analisis hasil wawancara dan hasil skrining.
5. Rekomendasikan intervensi dini yang tepat dan buat rencana edukasi kepada orang tua.

Output Tugas:

Laporan studi kasus deteksi dini gangguan bahasa lengkap dengan rekomendasi intervensi.

Tugas 3: Pengukuran Tumbuh Kembang Menggunakan Grafik WHO/NCHS

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu melakukan pengukuran tumbuh kembang balita dan menginterpretasikan hasil sesuai grafik pertumbuhan WHO/NCHS.

Langkah-Langkah:

1. Pilih balita berusia 1–5 tahun.
2. Lakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala secara tepat menggunakan alat yang tersedia.
3. Plot hasil pengukuran pada grafik WHO/NCHS.
4. Interpretasikan hasil pengukuran secara detail.
5. Susun rekomendasi tindakan lanjutan jika terdapat indikasi pertumbuhan kurang optimal.

Output Tugas:

Laporan hasil pengukuran, interpretasi grafik, dan rekomendasi intervensi tumbuh kembang balita.

Tugas 4: Simulasi Edukasi Stimulasi Perkembangan Kognitif dan Sosial-Emosional kepada Orang Tua

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu memberikan edukasi efektif kepada orang tua tentang stimulasi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional balita.

Langkah-Langkah:

1. Siapkan media edukasi (brosur, poster, atau video singkat) tentang stimulasi kognitif, sosial, dan emosional untuk usia balita.
2. Buat skenario simulasi edukasi tentang teknik stimulasi kepada orang tua.
3. Praktikkan simulasi edukasi secara langsung di depan kelas atau dengan kelompok kecil.
4. Evaluasi efektivitas komunikasi dan metode edukasi yang digunakan.
5. Kumpulkan umpan balik dari audiens untuk perbaikan lebih lanjut.

Output Tugas:

Media edukasi, laporan simulasi, serta evaluasi efektivitas penyampaian edukasi.

Tugas 5: Penyusunan Program Intervensi Dini pada Gangguan Tumbuh Kembang Balita

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu menyusun program intervensi dini yang komprehensif berdasarkan identifikasi gangguan tumbuh kembang balita.

Langkah-Langkah:

1. Pilih kasus balita dengan gangguan tumbuh kembang yang telah diidentifikasi melalui observasi atau instrumen skrining.
2. Buatlah analisis mendalam tentang jenis gangguan tumbuh kembang yang dialami.
3. Rancang program intervensi dini yang mencakup:
 - Jenis intervensi (terapi fisik, wicara, okupasi, perilaku).
 - Tujuan intervensi.
 - Langkah-langkah pelaksanaan intervensi.
 - Jadwal pelaksanaan intervensi.
 - Evaluasi kemajuan perkembangan.
4. Buat jadwal pemantauan rutin serta metode evaluasi efektivitas intervensi.
5. Presentasikan hasil program intervensi secara singkat di depan kelas.

Output Tugas:

Laporan program intervensi dini lengkap beserta jadwal pelaksanaan dan metode evaluasi.

J. Soal Kasus Kebidanan

Soal Kasus 1

Seorang anak perempuan berusia 2 tahun dibawa ibunya ke klinik kebidanan untuk konsultasi. Ibunya mengeluh anaknya belum dapat berjalan sendiri tanpa berpegangan, hanya mampu berdiri dan berjalan jika dibantu dengan kedua tangan.

Berdasarkan usia anak tersebut, keterampilan motorik kasar yang seharusnya sudah tercapai adalah:

- A. Melompat dengan kedua kaki
- B. Berjalan tanpa bantuan
- C. Mengayuh sepeda roda tiga
- D. Berdiri satu kaki selama 5 detik
- E. Melompat jauh sekitar 30 cm

Soal Kasus 2

Seorang anak laki-laki berusia 3 tahun datang bersama ibunya ke Posyandu. Ibu menyampaikan bahwa anaknya belum bisa berbicara dalam kalimat sederhana, hanya mampu menyebut kata tunggal.

Berdasarkan usia anak, kemampuan bahasa yang diharapkan sudah dicapai anak adalah:

- A. Menggunakan frasa dua kata sederhana
- B. Menggunakan kalimat pendek 3–4 kata
- C. Berbicara dalam kalimat kompleks 5–6 kata
- D. Menjelaskan konsep sederhana dengan jelas
- E. Bertanya "apa" dan "kenapa" secara berulang

Soal Kasus 3

Seorang anak perempuan berusia 4 tahun datang ke klinik kebidanan bersama orang tuanya. Saat dilakukan observasi, anak tampak sulit dalam aktivitas motorik halus seperti menggambar bentuk dasar dan memegang pensil dengan benar.

Aktivitas motorik halus yang seharusnya sudah dikuasai anak usia 4 tahun adalah:

- A. Menyusun 2–4 balok
- B. Menggunakan sendok dengan bantuan
- C. Menggambar garis lurus sederhana
- D. Menggambar bentuk dasar seperti lingkaran atau kotak
- E. Menggunakan gunting anak untuk memotong kertas kompleks

Soal Kasus 4

Seorang anak laki-laki berusia 3 tahun sering mengalami tantrum dan kesulitan dalam bermain bersama teman-temannya. Saat di Posyandu, bidan mengobservasi bahwa anak cenderung bermain sendiri dan belum mampu berbagi mainan atau mengikuti aturan permainan sederhana.

Berdasarkan usia, perkembangan sosial-emosional yang seharusnya sudah tercapai adalah:

- A. Bermain paralel tanpa interaksi
- B. Bermain kooperatif sederhana dan mulai berbagi
- C. Menunjukkan empati secara jelas kepada teman
- D. Memahami konsep bergiliran secara baik
- E. Menjalin persahabatan sederhana dengan teman

Soal Kasus 5

Seorang anak perempuan berusia 3 tahun 6 bulan datang ke Posyandu bersama ibunya. Bidan melakukan pengukuran tinggi badan dan mendapatkan hasil plot grafik WHO/NCHS berada di bawah garis -2SD.

Berdasarkan interpretasi hasil pengukuran, kondisi ini menunjukkan bahwa anak mengalami:

- A. Pertumbuhan optimal
- B. Risiko obesitas
- C. Stunting (pertumbuhan terhambat)
- D. Wasting (kurus akut)
- E. Risiko kelebihan berat badan

Kunci Jawaban:

1. Kunci Jawaban: B (Berjalan tanpa bantuan)

Pembahasan:

Berdasarkan milestone perkembangan motorik kasar, pada usia 1–2 tahun, balita seharusnya sudah mampu berjalan secara mandiri tanpa bantuan. Jika anak usia 2 tahun belum mampu berjalan sendiri, maka hal ini merupakan tanda keterlambatan perkembangan motorik kasar yang memerlukan evaluasi dan intervensi dini.

2. Kunci Jawaban: B (Menggunakan kalimat pendek 3–4 kata)

Pembahasan:

Pada usia 2–3 tahun, balita diharapkan sudah mampu berbicara menggunakan kalimat pendek yang terdiri dari 3 hingga 4 kata. Jika anak usia 3 tahun masih hanya mampu menyebutkan kata tunggal, maka hal ini termasuk keterlambatan perkembangan bahasa yang membutuhkan deteksi dini dan intervensi segera.

3. Kunci Jawaban: D (Menggambar bentuk dasar seperti lingkaran atau kotak)

Pembahasan:

Pada usia 3–4 tahun, balita diharapkan sudah mampu menggambar bentuk dasar seperti lingkaran, kotak, dan garis lurus secara jelas. Jika anak usia 4 tahun kesulitan melakukan aktivitas ini, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut dan intervensi stimulasi motorik halus segera.

4. Kunci Jawaban: B (Bermain kooperatif sederhana dan mulai berbagi)

Pembahasan:

Pada usia 2–3 tahun, balita seharusnya sudah mulai bermain kooperatif secara sederhana, mulai berbagi mainan, dan mulai bisa mengikuti instruksi sederhana dalam permainan sosial. Jika anak usia 3 tahun belum mampu bermain kooperatif dan berbagi, maka ini merupakan tanda gangguan perkembangan sosial-emosional yang memerlukan perhatian khusus.

5. Kunci Jawaban: C (Stunting atau pertumbuhan terhambat)

Pembahasan:

Jika tinggi badan menurut umur berada di bawah garis -2SD pada grafik WHO/NCHS, maka anak tersebut mengalami kondisi stunting atau pertumbuhan linear yang terhambat. Stunting adalah indikator kurang gizi kronis yang membutuhkan tindakan intervensi gizi dan pemantauan lebih lanjut.

K. Soal OSCE dan Rubrik Penilaian

Skenario Kasus:

Anda adalah seorang bidan di Posyandu. Seorang ibu membawa anaknya bernama Ananda (usia 3 tahun) untuk pemeriksaan rutin. Ibu merasa khawatir karena Ananda belum mampu berbicara dalam kalimat pendek seperti teman sebayanya. Ananda juga tampak kurang berminat untuk bermain dengan anak-anak lain dan sering bermain sendiri. Ananda mampu berjalan dan berlari dengan stabil, tetapi masih kesulitan menggunakan sendok sendiri dan kesulitan menggambar lingkaran sederhana.

Saat ini, ibu datang untuk konsultasi dan pemeriksaan perkembangan Ananda.

Tugas Peserta:

1. Lakukan anamnesis kepada ibu mengenai perkembangan Ananda dengan menggunakan Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan (KPSP).
2. Lakukan pemeriksaan sederhana kemampuan motorik halus, motorik kasar, sosial, bahasa, dan kognitif pada Ananda.
3. Jelaskan hasil pemeriksaan dan interpretasi perkembangan Ananda kepada ibu.
4. Berikan edukasi singkat kepada ibu mengenai stimulasi yang tepat berdasarkan hasil pemeriksaan dan deteksi dini yang telah dilakukan.
5. Lakukan rujukan apabila ditemukan indikasi keterlambatan perkembangan.

Tugas Penguji:

1. Mengobservasi proses komunikasi peserta dengan ibu dan balita.
2. Memberikan skor berdasarkan rubrik penilaian OSCE.
3. Menanyakan minimal satu pertanyaan klarifikasi jika diperlukan setelah peserta selesai melakukan edukasi.

Tugas Pasien Simulasi:

1. Ibu pasien simulasi:

- Bersikap kooperatif.
- Menjawab pertanyaan sesuai dengan skenario:
 - Anak belum mampu berbicara dalam kalimat pendek (hanya kata tunggal).
 - Kesulitan menggunakan sendok sendiri.
 - Kesulitan menggambar lingkaran sederhana.
 - Jarang bermain dengan teman sebaya, lebih sering bermain sendiri.
 - Motorik kasar seperti berjalan dan berlari baik.

2. Anak pasien simulasi (bila tersedia atau berupa boneka balita):

- Merespons pemeriksaan motorik kasar (berjalan, berdiri satu kaki).

- Menunjukkan kesulitan pada pemeriksaan motorik halus (memegang pensil/sendok).
- Bersikap diam dan kurang interaktif secara sosial.

Alat yang Diperlukan:

- Kuesioner Pra-Skrining Perkembangan (KPSP)
- Alat tulis (pensil, kertas kosong)
- Alat peraga permainan sederhana (bola kecil, puzzle, balok)
- Sendok plastik dan piring kecil (simulasi makan)

RUBRIK PENILAIAN OSCE

No	Komponen Penilaian	Nilai Maksimal	Skor Peserta
1	Anamnesis Tumbuh Kembang:	(20 poin)	
	- Menggunakan KPSP secara tepat	10	
	- Menggali informasi secara detail	10	
2	Pemeriksaan Tumbuh Kembang:	(25 poin)	
	- Motorik Kasar (berjalan, berdiri satu kaki)	5	
	- Motorik Halus (menggambar, memegang sendok)	5	
	- Bahasa (kemampuan bicara, kalimat sederhana)	5	
	- Sosial-emosional (interaksi, bermain)	5	
	- Kognitif (merespons instruksi sederhana)	5	
3	Interpretasi Hasil Pemeriksaan:	(20 poin)	
	- Menjelaskan hasil secara jelas dan akurat	10	
	- Menyampaikan kemungkinan gangguan perkembangan	10	
4	Edukasi kepada Orang Tua:	(20 poin)	
	- Memberikan informasi stimulasi yang tepat	10	
	- Memberikan edukasi deteksi dini dan tanda bahaya perkembangan	10	
5	Rujukan dan Tindak Lanjut:	(10 poin)	
	- Menjelaskan indikasi rujukan dengan jelas	5	
	- Mengarahkan rujukan ke fasilitas yang tepat	5	
6	Komunikasi Profesional:	(5 poin)	
	- Bahasa jelas, empati, sopan santun	5	
	TOTAL SKOR MAKSIMAL	100	TOTAL

Kriteria Kelulusan:

- **≥80–100** : Sangat kompeten
- **70–79** : Kompeten
- **60–69** : Cukup kompeten (perlu bimbingan)
- **<60** : Belum kompeten (perlu remedial)

Contoh Kunci Jawaban Standar untuk Penguji:**Interpretasi kasus:**

- Balita usia 3 tahun seharusnya mampu berbicara dalam kalimat pendek (3–4 kata), bermain kooperatif sederhana, mampu menggambar bentuk dasar, dan makan sendiri menggunakan sendok secara mandiri.
- Kasus ini menunjukkan indikasi keterlambatan perkembangan bahasa, motorik halus, sosial-emosional.

Intervensi dan edukasi:

- Menjelaskan kepada ibu bahwa anak menunjukkan tanda keterlambatan perkembangan bahasa, motorik halus, dan sosial-emosional.
- Menyarankan stimulasi bahasa dengan bercerita, membaca buku cerita, dan interaksi verbal intensif.
- Memberikan stimulasi motorik halus dengan aktivitas menggambar, mewarnai, menggunakan sendok, dan menyusun puzzle.
- Memberikan stimulasi sosial-emosional dengan mengajak bermain bersama teman sebaya secara rutin.
- Menyarankan ibu untuk segera membawa anak ke dokter spesialis anak atau psikolog anak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Rujukan:

Anak perlu dirujuk ke dokter spesialis anak atau psikolog anak untuk evaluasi perkembangan lebih lanjut dan mendapatkan intervensi yang tepat.

Bab 4

Perkembangan Anak Prasekolah (3-6 Tahun)

A. Pendahuluan

Masa prasekolah (3–6 tahun) merupakan periode kritis dalam perkembangan anak. Pada masa ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan pesat baik fisik, motorik, kognitif, bahasa, emosi, maupun sosial. Pemantauan serta stimulasi yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan perkembangan anak agar mampu beradaptasi dan tumbuh secara optimal. Sebagai tenaga kesehatan, khususnya bidan, memiliki peran strategis dalam mendukung proses tumbuh kembang ini melalui deteksi dini, edukasi, dan intervensi dini.

B. Capaian Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Mahasiswa mampu memahami dan mengaplikasikan teori serta keterampilan terkait perkembangan anak prasekolah dalam praktik kebidanan sesuai standar profesi, dengan pendekatan yang holistik, integratif, dan berorientasi pada kebutuhan tumbuh kembang anak secara optimal.

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Mahasiswa mampu melakukan pemantauan, stimulasi, edukasi, dan deteksi dini terhadap perkembangan anak usia prasekolah (3–6 tahun), mencakup aspek fisik, motorik, kognitif, bahasa, emosi, dan sosial secara komprehensif dan efektif sesuai dengan standar kompetensi profesi bidan.

3. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

- a. Mahasiswa mampu menjelaskan secara rinci karakteristik umum pertumbuhan dan perkembangan anak usia prasekolah (3–6 tahun).
- b. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan aspek-aspek perkembangan fisik, motorik kasar dan halus, kognitif, bahasa, emosi, serta sosial pada anak usia prasekolah.
- c. Mahasiswa mampu menjelaskan peran dan tanggung jawab bidan dalam stimulasi perkembangan optimal anak usia prasekolah melalui edukasi kepada keluarga.
- d. Mahasiswa mampu melaksanakan deteksi dini secara efektif terhadap gangguan atau keterlambatan perkembangan pada anak prasekolah menggunakan instrumen skrining yang terstandar (misalnya Denver II), serta merencanakan intervensi yang tepat dan merujuk ke tenaga ahli bila diperlukan.

C. Karakteristik Pertumbuhan dan Perkembangan Anak Prasekolah

Masa prasekolah (usia 3–6 tahun) adalah tahap penting di mana pertumbuhan fisik anak cenderung stabil namun perkembangan aspek lain seperti kognitif, sosial, dan emosional mengalami kemajuan yang sangat pesat. Anak prasekolah secara alami mulai memperlihatkan rasa ingin tahu yang besar, sering bertanya tentang berbagai hal, serta menunjukkan keinginan kuat untuk mengeksplorasi lingkungannya secara mandiri. Mereka mulai mampu memahami aturan sederhana yang diberikan oleh orang dewasa dan mulai mengembangkan kemampuan untuk mengikuti aturan tersebut secara konsisten.

1. Perkembangan Fisik dan Motorik

Perkembangan fisik dan motorik pada masa prasekolah berlangsung signifikan dan mencerminkan kemajuan yang penting dalam kemampuan anak untuk berinteraksi dengan lingkungan.

a. Perkembangan Fisik

Pertumbuhan fisik anak prasekolah umumnya stabil namun konsisten. Berat badan anak pada usia ini bertambah sekitar 2–3 kg per tahun, sedangkan tinggi badan meningkat sekitar 5–7 cm per tahun. Pada tahap ini, struktur tubuh anak juga mengalami perubahan dengan proporsi tubuh yang lebih seimbang dibanding masa bayi dan balita. Lengan dan kaki menjadi lebih panjang, serta tubuh secara keseluruhan menjadi lebih ramping. Perubahan fisik ini memungkinkan anak lebih bebas dan nyaman dalam melakukan berbagai aktivitas fisik.

b. Perkembangan Motorik Kasar

Kemampuan motorik kasar berkembang sangat pesat pada masa prasekolah. Keterampilan ini melibatkan kelompok otot besar yang memungkinkan anak melakukan berbagai aktivitas fisik secara lebih dinamis dan terkoordinasi.



Gambar 4.1 Bayi Sedang Menaiki Tangga

Contoh keterampilan motorik kasar yang berkembang pesat antara lain:

- Berlari: Anak semakin mampu berlari dengan kecepatan dan koordinasi yang lebih baik.
- Melompat: Anak mampu melompat baik dengan dua kaki maupun satu kaki secara bergantian.
- Bersepeda: Kemampuan mengayuh sepeda dengan roda tambahan atau bahkan tanpa bantuan semakin terampil.
- Menjaga keseimbangan: Anak mulai mampu berdiri dengan satu kaki, berjalan di atas garis lurus, atau bahkan berjalan mundur dengan baik.

Perkembangan motorik kasar yang optimal memerlukan stimulasi melalui permainan fisik yang aman dan bervariasi seperti bermain bola, bersepeda, lompat tali, atau aktivitas permainan lainnya yang dapat dilakukan secara rutin.

c. Perkembangan Motorik Halus

Motorik halus melibatkan kemampuan koordinasi dan kontrol gerakan otot-otot kecil di tangan dan jari-jari anak. Pada masa prasekolah, perkembangan motorik halus menjadi semakin baik dan detail, dengan contoh sebagai berikut:

- Menggambar bentuk sederhana: Anak mulai mampu menggambar lingkaran, kotak, garis lurus, serta figur sederhana seperti wajah manusia atau hewan.

- Memegang alat tulis dengan benar: Anak mulai menggunakan alat tulis dengan pegangan tripod yang lebih efisien, membantu mereka menulis dan menggambar secara lebih akurat.
- Menulis huruf atau angka: Anak prasekolah mulai mampu menyalin atau bahkan menulis beberapa huruf alfabet serta angka.

Perkembangan motorik halus juga penting dalam mendukung keterampilan kehidupan sehari-hari, seperti mengancingkan pakaian, membuka tutup botol, dan mengikat tali sepatu. Aktivitas seperti menggambar, mewarnai, menyusun puzzle, bermain plastisin, serta aktivitas lain yang memerlukan ketepatan dan koordinasi tangan-jari sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan ini.

2. Perkembangan Kognitif Anak Prasekolah (3–6 Tahun)



Gambar 4.2 Anak Sedang Menyusun Puzzle

Perkembangan kognitif merupakan perkembangan kemampuan berpikir anak dalam memahami dan memproses informasi serta menyelesaikan masalah. Masa prasekolah, khususnya usia 3–6 tahun, menjadi periode yang sangat penting karena anak mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek kognitif, termasuk tahap berpikir simbolik, kemampuan pemecahan masalah sederhana, serta pemahaman terhadap konsep dasar seperti warna, angka, bentuk, dan waktu.

a. Tahap Berpikir Simbolik yang Pesat

Pada masa prasekolah, anak berada dalam tahap praoperasional, menurut teori perkembangan kognitif Piaget. Salah satu karakteristik utama tahap ini adalah perkembangan pesat dalam berpikir simbolik. Berpikir simbolik berarti anak

mampu menggunakan simbol, objek, atau tindakan untuk mewakili sesuatu yang tidak ada di hadapannya secara langsung.

Contoh dari perkembangan berpikir simbolik ini antara lain:

- Permainan peran (*role play*): Anak mulai berpura-pura menjadi tokoh tertentu seperti dokter, guru, atau superhero, bahkan mampu memerankan situasi tertentu yang pernah dilihat atau dialaminya.
- Permainan pura-pura (*pretend play*): Anak dapat menggunakan benda sebagai pengganti benda lain, misalnya kursi sebagai mobil atau balok sebagai telepon.
- Menggambar representasi simbolik: Anak mulai mampu menggambar objek atau situasi dengan simbol-simbol sederhana, seperti lingkaran untuk kepala, garis untuk tubuh, yang menunjukkan mereka mampu memahami konsep abstrak sederhana bahwa gambar tersebut mewakili objek nyata.

Kemampuan berpikir simbolik ini merupakan dasar penting bagi perkembangan lebih lanjut, seperti kemampuan memahami konsep angka, huruf, dan hubungan sebab-akibat.

b. Kemampuan Pemecahan Masalah Sederhana

Pada usia prasekolah, kemampuan anak dalam pemecahan masalah mulai berkembang secara signifikan. Anak mulai dapat menggunakan logika sederhana dan penalaran untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, terutama melalui proses eksplorasi, pengamatan, serta eksperimen yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Contoh nyata kemampuan pemecahan masalah sederhana pada anak prasekolah, antara lain:

- Permainan puzzle: Anak mampu mencari dan mencocokkan potongan puzzle dengan benar, yang menunjukkan kemampuan mengenali pola, bentuk, dan ukuran.
- Eksperimen sederhana: Anak mampu menemukan solusi dari persoalan sederhana, misalnya mengambil mainan yang terjatuh di bawah meja dengan menggunakan tongkat atau benda panjang lainnya.
- Klasifikasi sederhana: Anak mulai mampu mengelompokkan benda berdasarkan warna, bentuk, atau ukuran yang sama.

Proses ini menunjukkan bahwa anak sudah mulai mampu berpikir secara sistematis meskipun masih dalam lingkup yang sederhana.

c. Pengenalan Konsep Dasar Warna, Angka, Bentuk, dan Konsep Waktu

Selama masa prasekolah, anak mulai mampu mengenali dan memahami konsep-konsep dasar yang esensial dalam kehidupan sehari-hari, seperti:

- Warna: Anak pada usia ini mampu mengidentifikasi berbagai warna dasar seperti merah, biru, kuning, hijau, dan sebagainya. Mereka juga mulai mampu mengelompokkan objek berdasarkan warna tertentu.
- Angka: Anak mulai memahami angka dasar dan mampu menghitung secara sederhana, misalnya menghitung jumlah mainan atau makanan yang mereka miliki (biasanya angka 1 hingga 10).
- Bentuk geometris: Anak mampu mengenal bentuk dasar seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan persegi panjang serta dapat membedakan satu bentuk dengan bentuk lainnya.
- Konsep waktu sederhana: Anak prasekolah mulai mengenali dan menggunakan istilah waktu sederhana seperti "kemarin", "sekarang", dan "besok". Mereka mulai memahami konsep waktu secara bertahap, meskipun pemahaman mengenai durasi masih belum sepenuhnya akurat.

3. Perkembangan Bahasa Anak Prasekolah (3–6 Tahun)

Masa prasekolah adalah periode penting dalam perkembangan bahasa anak. Pada usia ini, kemampuan anak dalam menggunakan dan memahami bahasa mengalami kemajuan signifikan yang menjadi fondasi penting bagi komunikasi, interaksi sosial, serta pencapaian akademik di masa depan.



Gambar 4.3 Anak Sedang Bernyanyi Bersama Teman

a. Peningkatan Kosakata yang Signifikan

Pada usia 3 hingga 6 tahun, kosakata anak berkembang sangat pesat. Jika pada usia 3 tahun, rata-rata kosakata anak sekitar 900 kata, maka pada usia 5 hingga 6 tahun, jumlah kosakata tersebut bertambah secara signifikan hingga mencapai lebih dari 2.500 kata. Pertambahan kosakata ini terjadi karena anak secara aktif menyerap informasi dari lingkungan sekitarnya, baik dari percakapan sehari-hari dengan orang tua, keluarga, teman sebaya, guru, maupun melalui media seperti buku cerita, televisi, dan permainan edukatif.

Anak prasekolah juga mulai mampu menggunakan kata-kata secara lebih akurat, termasuk memahami arti kata secara kontekstual. Mereka mulai memahami perbedaan arti kata-kata yang memiliki arti mirip atau berlawanan, seperti “besar-kecil,” “panjang-pendek,” dan mampu mengaplikasikannya dengan tepat dalam percakapan sehari-hari.

b. Perkembangan Keterampilan Komunikasi Verbal

Kemampuan komunikasi verbal anak prasekolah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Mereka tidak hanya mampu mengucapkan kata-kata, tetapi juga mulai mampu menyusun kata-kata tersebut menjadi kalimat yang kompleks dan jelas.

Kemampuan ini mencakup:

- Menggunakan kalimat yang lebih panjang dan rumit: Anak mulai mampu merangkai kalimat yang terdiri dari lima hingga tujuh kata atau bahkan lebih. Mereka juga mulai menggunakan kata penghubung seperti “dan,” “karena,” serta mulai mampu menggunakan berbagai bentuk kalimat seperti pernyataan, pertanyaan, dan perintah dengan jelas.
- Mengungkapkan perasaan, ide, dan keinginan secara jelas: Anak prasekolah dapat menjelaskan apa yang mereka rasakan atau pikirkan dengan cara yang mudah dipahami oleh orang lain. Mereka juga mulai dapat menyampaikan ide secara lebih detail dan spesifik.
- Kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan: Anak mampu mengajukan berbagai pertanyaan secara aktif, mulai dari pertanyaan sederhana seperti “apa itu?” hingga pertanyaan kompleks seperti “mengapa ini terjadi?”. Mereka juga semakin mampu menjawab pertanyaan dari orang lain dengan jelas dan relevan.

c. Kemampuan Menceritakan Kembali dan Mengikuti Instruksi Multi-langkah

Pada masa prasekolah, anak mulai menunjukkan kemampuan penting dalam menceritakan kembali cerita pendek atau kejadian yang mereka alami. Kemampuan ini meliputi:

- Menceritakan kembali cerita secara runtut: Anak dapat mengingat dan menyampaikan kembali urutan peristiwa dalam cerita yang didengar atau dialami secara sederhana namun terstruktur.
- Memahami alur cerita dan karakter: Mereka mulai mampu memahami alur cerita dasar (awal, tengah, akhir) dan karakter utama dalam cerita yang disampaikan. Anak juga bisa menjelaskan cerita dengan menggunakan kata-kata yang sederhana namun jelas.

Selain itu, anak prasekolah juga mulai mampu mengikuti instruksi yang terdiri dari beberapa langkah sekaligus (multi-langkah), misalnya “Ambilkan bola merah di rak, lalu letakkan di meja, dan duduk kembali di kursi.” Kemampuan ini menunjukkan bahwa anak tidak hanya memahami makna setiap kata secara individual tetapi juga mampu mengingat urutan dan mengikuti instruksi secara akurat.

4. Perkembangan Emosi dan Sosial Anak Prasekolah (3–6 Tahun)

Perkembangan emosi dan sosial pada masa prasekolah (usia 3–6 tahun) merupakan tahapan penting yang mempengaruhi kemampuan anak dalam berinteraksi dengan lingkungan dan orang di sekitarnya. Perkembangan pada aspek ini mencakup kemampuan mengelola emosi, memahami perasaan diri sendiri dan orang lain, serta keterampilan dalam menjalin hubungan sosial yang positif.

a. Kemampuan Regulasi Emosi dan Mengungkapkan Perasaan

Pada usia prasekolah, anak mulai menunjukkan peningkatan signifikan dalam regulasi emosi, yaitu kemampuan untuk mengelola, mengontrol, dan mengekspresikan emosi secara tepat. Perkembangan regulasi emosi ditandai dengan:

- Ekspresi Emosi yang Tepat: Anak mulai mampu mengidentifikasi dan menyampaikan perasaan mereka dengan lebih akurat. Misalnya, mereka bisa mengungkapkan secara verbal bahwa mereka merasa senang, sedih, marah, atau takut.
- Kontrol Terhadap Emosi: Anak mulai mampu mengelola emosi negatif seperti kemarahan atau kekecewaan secara lebih baik dibandingkan ketika masih

balita. Mereka bisa menenangkan diri sendiri atau menggunakan strategi sederhana, seperti meminta bantuan orang dewasa atau mengalihkan perhatian ke aktivitas lain.

- **Pemahaman Terhadap Emosi Orang Lain:** Anak prasekolah mulai memahami bahwa orang lain juga memiliki perasaan yang berbeda-beda. Mereka mulai bisa mengenali ekspresi wajah atau bahasa tubuh orang lain yang menggambarkan perasaan tertentu, misalnya memahami bahwa seseorang sedang sedih atau senang.

b. Interaksi Sosial yang Meningkat dan Bermain Kooperatif

Anak prasekolah mulai menunjukkan peningkatan kemampuan dalam interaksi sosial. Pada tahap ini, mereka mulai terlibat dalam berbagai bentuk interaksi yang lebih kompleks dan terorganisir dengan teman sebaya.

Karakteristik interaksi sosial yang berkembang pada masa ini antara lain:

- **Bermain Kooperatif:** Anak mulai bermain dalam kelompok kecil secara terkoordinasi, seperti bermain peran (role-play), permainan papan (board games) sederhana, atau aktivitas bermain kelompok yang memiliki aturan dasar. Dalam bermain kooperatif, anak belajar untuk berbagi peran, bergiliran, dan mengikuti aturan yang disepakati bersama.
- **Berbagi Mainan dan Benda:** Pada usia ini, anak mulai memahami pentingnya berbagi mainan atau barang dengan teman-temannya. Meskipun masih ada tantangan, mereka mulai lebih mampu mengontrol keinginan untuk memiliki sesuatu secara eksklusif dan mulai mengembangkan perilaku berbagi.
- **Memahami Konsep Persahabatan:** Anak prasekolah mulai menunjukkan minat yang besar dalam menjalin hubungan pertemanan. Mereka mulai memiliki teman dekat tertentu yang dianggap spesial dan penting bagi mereka. Anak mulai memahami konsep persahabatan sederhana, seperti saling membantu, bersikap ramah, serta menikmati kebersamaan.

c. Perilaku Empati dan Adaptasi Sosial yang Lebih Baik

Salah satu aspek penting dari perkembangan emosi dan sosial pada anak prasekolah adalah munculnya perilaku empati dan kemampuan adaptasi sosial yang semakin baik. Hal ini ditandai dengan beberapa kemampuan berikut:

- **Empati:** Anak mulai mampu merasakan dan memahami perasaan orang lain serta menunjukkan respon yang sesuai terhadap situasi emosional orang lain. Misalnya, jika teman menangis, anak prasekolah dapat menunjukkan

kepedulian dengan mencoba menenangkan, menghibur, atau memanggil bantuan dari orang dewasa.

- **Adaptasi Sosial:** Anak pada masa prasekolah mulai mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas di luar keluarga inti, seperti di sekolah, tempat bermain, atau lingkungan masyarakat. Mereka mulai memahami norma dan aturan sosial sederhana serta dapat menyesuaikan perilaku mereka dengan tuntutan sosial di lingkungan tersebut.
- **Mengatasi Konflik Sosial:** Pada tahap ini, anak juga mulai belajar mengelola konflik secara sederhana. Mereka dapat menyelesaikan perselisihan dengan bimbingan atau bantuan minimal dari orang dewasa, menggunakan strategi seperti negosiasi sederhana atau meminta maaf setelah bertengkar.

D. Peran Bidan dalam Stimulasi Perkembangan Anak Prasekolah (3–6 Tahun)

Bidan memiliki posisi strategis dalam mendukung tumbuh kembang anak usia prasekolah (3–6 tahun). Pada tahap ini, stimulasi yang tepat sangat penting untuk mengoptimalkan berbagai aspek perkembangan anak, seperti fisik, motorik, kognitif, bahasa, emosi, dan sosial. Bidan berperan penting dalam memberikan edukasi kepada orang tua mengenai cara-cara efektif untuk menstimulasi anak, memberikan dukungan emosional dan sosial, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan perkembangan.

1. Pentingnya Stimulasi Sesuai Tahapan Perkembangan Anak

Bidan bertanggung jawab memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya stimulasi yang disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak prasekolah. Stimulasi yang sesuai tahapan perkembangan dapat membantu anak mencapai tonggak perkembangan secara optimal. Bidan perlu mengedukasi orang tua bahwa setiap tahap perkembangan anak memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Sebagai contoh:

- **Usia 3–4 tahun:** Stimulasi bisa berupa permainan sederhana seperti menyusun puzzle, mengenal bentuk dasar, bermain bola, melompat, atau kegiatan yang melatih kemandirian seperti makan sendiri dan berpakaian sendiri.
- **Usia 4–5 tahun:** Anak mulai diperkenalkan dengan aktivitas yang lebih kompleks, seperti permainan peran, menggambar objek sederhana, bermain sepeda, dan

kegiatan yang membutuhkan interaksi kelompok untuk mendukung kemampuan sosial.

- **Usia 5–6 tahun:** Orang tua diarahkan untuk memberikan aktivitas yang lebih menantang secara kognitif dan fisik, seperti permainan angka dan huruf, menyusun cerita pendek, permainan motorik kompleks (melompat tali, senam sederhana), serta permainan yang mengajarkan empati dan kerja sama.

2. Teknik Bermain yang Mendukung Perkembangan Motorik dan Kognitif

Bidan perlu memberikan panduan dan edukasi kepada orang tua tentang teknik bermain yang efektif dalam mendukung perkembangan motorik dan kognitif anak prasekolah, antara lain:

- **Motorik Kasar:** Bidan bisa menyarankan permainan seperti berlari, lompat tali, bersepeda, bermain bola, menari, dan aktivitas fisik lainnya yang melibatkan gerakan tubuh secara luas untuk membantu anak mengembangkan koordinasi tubuh, keseimbangan, serta kekuatan otot.
- **Motorik Halus:** Aktivitas yang disarankan bidan antara lain menggambar, mewarnai, merangkai manik-manik, menyusun puzzle, atau menggunakan plastisin. Aktivitas ini membantu meningkatkan koordinasi tangan-mata, ketepatan gerakan, serta kesiapan untuk menulis.
- **Perkembangan Kognitif:** Bidan bisa merekomendasikan permainan edukatif yang melatih kemampuan berpikir simbolik, seperti permainan peran, permainan mencocokkan bentuk dan warna, permainan sederhana berhitung dan mengenal angka, serta aktivitas bercerita yang menstimulasi imajinasi anak.

3. Memberikan Dukungan Emosional dan Sosial Melalui Interaksi Positif Sehari-hari

Bidan memiliki peran untuk menekankan kepada orang tua pentingnya menciptakan lingkungan sosial dan emosional yang positif bagi anak prasekolah. Dukungan ini mencakup:

- **Interaksi Positif Sehari-hari:** Mengajarkan orang tua untuk memberikan respons yang hangat, empati, dan mendukung secara konsisten dalam interaksi sehari-hari dengan anak. Contoh sederhana adalah mendengarkan anak secara aktif, memberikan pujian yang tulus atas usaha anak, serta menunjukkan kasih sayang secara terbuka.

- **Membantu Anak Mengelola Emosi:** Bidan dapat memberikan edukasi tentang cara efektif untuk mengajarkan anak mengenali dan mengelola emosi mereka. Orang tua diajarkan untuk membimbing anak dalam mengungkapkan perasaan dengan cara yang tepat serta mengatasi frustrasi atau kemarahan secara positif.
- **Meningkatkan Keterampilan Sosial:** Orang tua diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya melalui berbagai aktivitas bermain, serta mengajarkan konsep berbagi, bergiliran, dan memahami aturan bermain secara kooperatif.

4. Menyusun Rencana Intervensi Dini Bila Ditemukan Gangguan atau Keterlambatan Perkembangan

Salah satu peran penting bidan adalah melakukan pemantauan rutin terhadap tumbuh kembang anak untuk mendeteksi dini gangguan atau keterlambatan perkembangan. Jika ditemukan tanda-tanda tersebut, bidan harus:

- **Melakukan Skrining Perkembangan:** Menggunakan instrumen yang terstandar seperti Denver II untuk mengidentifikasi keterlambatan perkembangan pada tahap awal.
- **Menginformasikan Orang Tua:** Menjelaskan secara jelas dan mendukung kepada orang tua mengenai kondisi perkembangan anak serta pentingnya intervensi dini.
- **Menyusun Rencana Intervensi:** Bekerja sama dengan orang tua untuk membuat rencana stimulasi tambahan atau intervensi khusus yang dapat dilakukan di rumah maupun bekerja sama dengan tenaga kesehatan atau spesialis lainnya.
- **Melakukan Rujukan yang Tepat:** Jika gangguan atau keterlambatan dianggap cukup serius, bidan perlu merujuk anak kepada spesialis anak atau ahli perkembangan anak agar mendapatkan penanganan lebih lanjut secara optimal.

E. Deteksi Dini Gangguan Perkembangan Anak Prasekolah (3–6 Tahun)

Deteksi dini terhadap gangguan perkembangan merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa anak prasekolah (usia 3–6 tahun) dapat mencapai perkembangan optimal di berbagai aspek, seperti fisik, motorik, kognitif, bahasa, emosi, dan sosial. Deteksi dini memungkinkan intervensi segera dilakukan, sehingga dapat mengurangi risiko gangguan perkembangan yang lebih serius di kemudian hari. Terdapat beberapa metode dan pendekatan yang digunakan dalam proses deteksi dini ini, yaitu penggunaan instrumen skrining, observasi langsung, serta konsultasi dan rujukan kepada ahli terkait.



Gambar 4.4 Bidan Sedangan Memerhatikan Anak Bermain

1. Penggunaan Instrumen Skrining Denver II

Denver Developmental Screening Test II (Denver II) adalah instrumen skrining perkembangan anak yang banyak digunakan dalam praktik klinis untuk mendeteksi secara dini gangguan atau keterlambatan perkembangan pada anak. Denver II sangat relevan untuk anak usia prasekolah karena mencakup berbagai aspek perkembangan utama, antara lain:

- **Motorik Kasar (gross motor):** Kemampuan gerak tubuh secara umum seperti berjalan, melompat, berlari, atau keseimbangan tubuh.
- **Motorik Halus (fine motor-adaptive):** Kemampuan dalam menggunakan otot-otot kecil seperti menggambar, menulis, merangkai benda kecil, atau memegang benda dengan benar.
- **Bahasa (language):** Kemampuan anak untuk memahami dan menggunakan bahasa, termasuk bicara, pemahaman kata, dan ekspresi verbal.
- **Personal-Sosial (personal-social):** Kemampuan dalam interaksi sosial, seperti bermain dengan teman sebaya, mengungkapkan emosi secara tepat, dan mengikuti aturan sederhana.

Penggunaan instrumen Denver II oleh bidan atau tenaga kesehatan lain dilakukan dengan cara memberikan sejumlah tugas atau kegiatan spesifik sesuai usia anak, lalu mengobservasi apakah anak mampu melaksanakan tugas tersebut sesuai dengan standar normal perkembangannya. Hasil skrining ini dapat menentukan apakah anak berkembang sesuai dengan tahapan usianya atau terdapat indikasi keterlambatan perkembangan yang memerlukan intervensi lebih lanjut.

2. Observasi Tanda-tanda Keterlambatan Perkembangan

Selain penggunaan alat skrining formal, observasi langsung oleh bidan atau orang tua sangat penting dalam mendeteksi keterlambatan perkembangan pada anak prasekolah. Beberapa tanda yang perlu diobservasi secara seksama antara lain:

- **Keterbatasan Bicara:** Misalnya anak mengalami kesulitan berbicara atau kosa katanya jauh di bawah standar usianya. Anak mungkin belum bisa mengucapkan kalimat yang jelas atau bahkan belum bisa mengucapkan banyak kata pada usia 4–5 tahun.
- **Kesulitan Koordinasi Motorik:** Anak yang mengalami keterlambatan perkembangan motorik kasar mungkin terlihat kesulitan dalam melakukan aktivitas fisik sederhana seperti melompat, berlari, atau menaiki tangga. Dalam motorik halus, anak mungkin sulit menggunakan alat tulis atau melakukan kegiatan yang memerlukan koordinasi jari-jari secara presisi.
- **Interaksi Sosial yang Buruk:** Anak yang mengalami gangguan perkembangan sosial mungkin menunjukkan kesulitan dalam bermain bersama teman sebaya, sulit berbagi mainan, atau tidak memahami konsep sederhana seperti giliran. Mereka mungkin juga menarik diri, tidak tertarik pada interaksi dengan orang lain, atau kesulitan dalam memahami perasaan dan ekspresi emosi orang lain.

Observasi yang dilakukan secara rutin dan teliti oleh bidan maupun orang tua sangat penting untuk mengidentifikasi tanda-tanda gangguan perkembangan secara dini. Semakin awal gangguan perkembangan dideteksi, semakin cepat pula intervensi dapat diberikan.

3. Konsultasi dengan Tenaga Ahli atau Rujukan ke Spesialis Terkait

Jika hasil skrining Denver II atau observasi langsung menunjukkan adanya tanda-tanda gangguan atau keterlambatan perkembangan, bidan memiliki peran untuk segera mengambil langkah-langkah lanjutan, antara lain:

- **Konsultasi dengan Tenaga Ahli:** Bidan dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis anak, psikolog perkembangan anak, atau tenaga ahli lain yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani gangguan perkembangan anak. Konsultasi ini bertujuan untuk mendapatkan arahan lebih lanjut mengenai langkah-langkah intervensi yang paling tepat bagi anak.
- **Rujukan ke Spesialis:** Jika indikasi keterlambatan atau gangguan perkembangan dirasa cukup serius dan memerlukan penanganan lebih intensif, bidan dapat

merujuk anak kepada spesialis yang relevan, seperti dokter spesialis anak, terapis okupasi, terapis wicara, atau psikolog anak. Rujukan ini memastikan bahwa anak mendapat pemeriksaan lebih komprehensif serta penanganan profesional sesuai dengan kebutuhannya.

F. Praktik

1. Praktik Skrining Perkembangan Menggunakan Denver II

Denver II (Denver Developmental Screening Test II) merupakan instrumen standar yang digunakan untuk mendeteksi secara dini keterlambatan atau gangguan perkembangan anak usia 0–6 tahun. Untuk anak usia prasekolah (3–6 tahun), instrumen ini sangat relevan dalam memantau perkembangan anak secara komprehensif.

Berikut ini adalah penjelasan detail langkah-langkah pelaksanaan praktik skrining Denver II:

a. Tujuan Skrining Denver II

Praktik skrining Denver II bertujuan untuk:

- Mengidentifikasi secara dini apakah perkembangan anak sesuai dengan tahapan usianya atau terdapat keterlambatan.
- Memberikan gambaran tentang kemampuan anak di empat aspek utama: motorik kasar, motorik halus, bahasa, dan personal-sosial.
- Memberikan informasi kepada tenaga kesehatan dan orang tua tentang langkah intervensi atau stimulasi yang diperlukan bila terdapat tanda keterlambatan.

b. Persiapan Pelaksanaan Skrining

Sebelum memulai praktik skrining, langkah-langkah persiapan yang perlu dilakukan adalah:

1) Menyiapkan Alat dan Bahan

- Formulir Denver II.
- Alat peraga khusus seperti bola kecil, kubus, kertas dan pensil/crayon, buku cerita bergambar, benda kecil untuk diambil, dan kartu gambar.

2) Menentukan Usia Anak secara Akurat

Hitung usia anak dalam tahun, bulan, dan hari agar sesuai dengan penilaian tugas-tugas yang harus dilakukan.

3) Menciptakan Lingkungan Kondusif

Ruangan harus nyaman, tenang, bebas gangguan agar anak merasa aman dan dapat berpartisipasi aktif.

c. Pelaksanaan Skrining Denver II

Proses skrining dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1) Menjalin Hubungan Baik (Rapport):

Sambut anak dengan ramah, perkenalkan diri, dan libatkan dalam obrolan singkat agar anak merasa nyaman.

2) Memberikan Instruksi Tugas secara Jelas

Instruksi diberikan dengan bahasa sederhana, jelas, dan sesuai dengan usia anak. Contohnya:

- "Bisakah kamu menggambar lingkaran seperti ini?"
- "Coba kamu ambil bola ini lalu lemparkan ke arah saya."
- "Apa nama gambar ini?"

3) Observasi dan Dokumentasi:

Amati kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas sesuai aspek perkembangan yang dinilai, yaitu:

- Motorik Kasar: Berlari, melompat, menjaga keseimbangan tubuh, berdiri dengan satu kaki.
- Motorik Halus: Menggambar bentuk sederhana seperti garis atau lingkaran, menyusun kubus, merangkai benda kecil.
- Bahasa: Kemampuan berbicara jelas, mengidentifikasi gambar sederhana, mengikuti perintah yang kompleks.
- Personal-Sosial: Kemampuan interaksi dengan penguji, bermain secara kooperatif, kemandirian dalam aktivitas sederhana.

d. Interpretasi Hasil Skrining Denver II

Setelah observasi selesai, hasil skrining dianalisis sebagai berikut:

- Normal (Lulus): Anak mampu melakukan tugas-tugas sesuai kelompok usianya tanpa kesulitan.
- Waspada (Suspect): Anak mengalami kesulitan pada beberapa tugas, yang mungkin membutuhkan pengamatan lebih lanjut.
- Keterlambatan (Delay): Anak gagal melakukan tugas-tugas tertentu yang seharusnya mampu dilakukan sesuai usianya.

Penilaian ini ditandai dalam formulir Denver II, dan hasilnya digunakan untuk menentukan tindak lanjut yang sesuai.

e. Tindak Lanjut dari Hasil Skrining

Berdasarkan hasil skrining, tindakan lanjutan meliputi:

1) Konseling dan Edukasi Orang Tua

Jelaskan hasil skrining secara jelas kepada orang tua, berikan informasi tentang aspek perkembangan anak yang perlu diperhatikan lebih lanjut.

2) Perencanaan Intervensi

Jika terdapat keterlambatan ringan, berikan rekomendasi stimulasi tambahan yang dapat dilakukan di rumah.

3) Rujukan

Jika ditemukan keterlambatan perkembangan yang signifikan, segera rujuk anak ke tenaga ahli seperti dokter spesialis anak, psikolog perkembangan anak, terapis okupasi, atau terapis wicara untuk penanganan lebih lanjut.

f. Dokumentasi dan Evaluasi Berkala

Seluruh hasil skrining dicatat secara rapi dan sistematis dalam catatan kesehatan anak. Evaluasi berkala perlu dilakukan secara rutin (biasanya setiap 6 bulan hingga 1 tahun), terutama bagi anak yang menunjukkan tanda-tanda keterlambatan, untuk memastikan perkembangan anak terus terpantau secara optimal.

2. Edukasi dan Demonstrasi Stimulasi Motorik dan Bahasa kepada Orang Tua

Edukasi dan demonstrasi stimulasi motorik dan bahasa kepada orang tua merupakan bagian penting dalam peran bidan untuk memastikan perkembangan anak prasekolah (usia 3–6 tahun) berlangsung optimal. Bidan bertugas memberikan panduan dan pelatihan praktis kepada orang tua mengenai cara memberikan stimulasi perkembangan motorik dan bahasa secara efektif di rumah.

Penjelasan detail mengenai pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Edukasi dan Demonstrasi Stimulasi

- Meningkatkan pemahaman orang tua tentang pentingnya stimulasi motorik dan bahasa sesuai usia anak.
- Memberikan keterampilan praktis kepada orang tua dalam memberikan stimulasi yang efektif.
- Membantu orang tua mengenali tanda-tanda keterlambatan perkembangan motorik dan bahasa pada anak.
- Mendukung perkembangan optimal anak dalam aspek fisik, motorik, dan bahasa sejak dini.

b. Persiapan sebelum Edukasi dan Demonstrasi

Sebelum melakukan edukasi dan demonstrasi, bidan perlu melakukan persiapan berikut:

- Menyiapkan media dan alat bantu seperti gambar, buku cerita, puzzle, alat tulis, mainan edukatif, bola, plastisin, dan alat lainnya yang sesuai untuk stimulasi.
- Menyusun materi yang jelas dan mudah dipahami oleh orang tua.
- Menentukan metode penyampaian yang menarik, seperti demonstrasi langsung, diskusi interaktif, serta praktik langsung oleh orang tua.

c. Edukasi dan Demonstrasi Stimulasi Motorik

Stimulasi motorik meliputi dua aspek penting, yaitu motorik kasar dan motorik halus.

1) Stimulasi Motorik Kasar

Motorik kasar berkaitan dengan kemampuan anak menggunakan otot-otot besar, seperti lengan, kaki, dan tubuh secara keseluruhan.

Bidan memberikan demonstrasi aktivitas seperti:

- Berlari, melompat, dan berjalan di garis lurus: Ajarkan cara sederhana dengan bermain kejar-kejaran atau melompat tali, yang bermanfaat untuk keseimbangan dan koordinasi tubuh anak.
- Bermain bola: Perlihatkan cara bermain menangkap, melempar, dan menendang bola untuk mengembangkan keterampilan koordinasi tangan dan kaki serta kekuatan otot.
- Menari atau bergerak mengikuti irama musik: Tunjukkan aktivitas ini untuk mengembangkan keseimbangan, koordinasi, dan ekspresi tubuh anak.

2) Stimulasi Motorik Halus

Motorik halus melibatkan otot kecil seperti jari dan tangan. Demonstrasi stimulasi motorik halus meliputi aktivitas seperti:

- Menggambar dan mewarnai: Ajarkan cara menggambar bentuk sederhana seperti lingkaran, segitiga, atau kotak serta penggunaan alat tulis yang benar.
- Meronce atau merangkai benda kecil: Praktikkan cara menyusun manik-manik atau puzzle yang membantu melatih ketelitian, koordinasi tangan dan mata.
- Bermain dengan plastisin atau clay: Perlihatkan aktivitas membentuk benda yang meningkatkan kekuatan jari, kreativitas, dan koordinasi motorik halus.

d. Edukasi dan Demonstrasi Stimulasi Bahasa

Stimulasi bahasa bertujuan untuk mengembangkan kemampuan anak dalam memahami dan menggunakan bahasa. Langkah-langkahnya meliputi:

1) Membaca Buku Cerita

Peragakan cara membaca buku cerita dengan ekspresi wajah, intonasi suara yang menarik, serta ajarkan cara mengajukan pertanyaan sederhana tentang isi cerita kepada anak untuk melatih pemahaman dan kosakata anak.

2) Mengajak Berbicara dan Diskusi

Berikan contoh cara mengajak anak berdiskusi tentang aktivitas sehari-hari atau peristiwa yang dialami anak. Gunakan pertanyaan terbuka yang mendorong anak untuk berpikir dan berkomunikasi lebih banyak.

3) Bernyanyi atau Membaca Puisi

Ajarkan teknik sederhana seperti bernyanyi lagu-lagu anak atau membaca puisi pendek yang mudah diingat anak untuk mengembangkan kemampuan berbicara, irama, dan pelafalan kata.

e. Praktik Langsung oleh Orang Tua

Setelah demonstrasi, bidan perlu memberikan kesempatan kepada orang tua untuk mempraktikkan langsung teknik-teknik stimulasi motorik dan bahasa yang telah diajarkan.

Hal ini bertujuan agar orang tua:

- Merasakan langsung cara efektif memberikan stimulasi.
- Mendapatkan umpan balik secara langsung dari bidan jika terdapat kesalahan atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan stimulasi.

f. Evaluasi dan Tindak Lanjut

- Setelah sesi edukasi dan demonstrasi, bidan melakukan evaluasi untuk memastikan pemahaman dan kemampuan orang tua dalam memberikan stimulasi di rumah.
- Bidan juga memberikan saran tindak lanjut dan jadwal evaluasi rutin untuk memastikan perkembangan anak tetap optimal dan terpantau dengan baik.

G. Tugas

1. Buat makalah tentang stimulasi perkembangan motorik halus pada anak prasekolah.
2. Buat video edukasi singkat tentang deteksi dini keterlambatan bicara.
3. Lakukan observasi pada 2 anak prasekolah, buat laporan hasil observasi.
4. Buat leaflet tentang pentingnya permainan edukatif.
5. Studi kasus: buat rencana intervensi untuk anak dengan gangguan sosial.

H. Soal Kasus

Soal 1:

Seorang anak laki-laki berusia 4 tahun dibawa oleh ibunya ke Klinik Tumbuh Kembang Anak dengan keluhan belum mampu menyusun kalimat sederhana, hanya mengucapkan beberapa kata secara terputus-putus, dan sulit memahami instruksi sederhana. Berdasarkan hasil skrining Denver II ditemukan keterlambatan signifikan di aspek bahasa, namun aspek motorik kasar, motorik halus, dan sosial-emotional dalam batas normal.

Apakah diagnosis yang paling mungkin dari kasus tersebut?

- A. Gangguan perkembangan motorik kasar
- B. Gangguan perkembangan motorik halus
- C. Gangguan perkembangan bahasa
- D. Gangguan perkembangan sosial
- E. Gangguan emosi anak

Soal 2:

Seorang anak perempuan berusia 5 tahun dibawa ke Posyandu oleh orang tuanya dengan keluhan kesulitan menggambar bentuk sederhana seperti lingkaran atau garis lurus. Hasil anamnesis menunjukkan bahwa Putri kesulitan menggunakan pensil dan krayon secara tepat. Pemeriksaan Denver II menunjukkan keterlambatan dalam motorik halus, sedangkan motorik kasar, bahasa, dan sosial normal.

Apakah intervensi awal terbaik yang dapat dilakukan oleh bidan?

- A. Latihan intensif motorik kasar
- B. Edukasi stimulasi motorik halus melalui menggambar, menyusun puzzle, atau bermain plastisin
- C. Merujuk ke dokter spesialis saraf

- D. Stimulasi bahasa dan komunikasi
- E. Latihan keterampilan social

Soal 3:

Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun datang bersama orang tuanya ke TPMB dengan keluhan sering jatuh ketika berlari, sulit berdiri satu kaki, dan belum bisa bersepeda dengan roda tambahan. Pemeriksaan menggunakan Denver II menunjukkan keterlambatan pada motorik kasar, sedangkan motorik halus, bahasa, dan sosial dalam batas normal.

Manakah rekomendasi intervensi yang paling tepat?

- A. Merujuk segera ke terapi wicara
- B. Edukasi stimulasi motorik halus
- C. Mengajarkan konsep angka dan huruf
- D. Konseling perkembangan social
- E. Latihan fisik intensif melalui permainan seperti berlari, melompat, atau bersepeda

Soal 4:

Seorang anak perempuan berusia 4,5 tahun diantar ibunya ke TPMB dengan keluhan sulit bermain bersama teman sebayanya. Ibu mengatakan lebih sering menyendiri, tidak mau berbagi mainan, dan kesulitan memahami konsep bergiliran dalam permainan. Skrining Denver II menunjukkan keterlambatan pada aspek personal-sosial saja. Intervensi awal yang paling tepat dilakukan bidan adalah?

- A. Latihan intensif motorik kasar
- B. Merujuk ke spesialis tumbuh kembang anak
- C. Terapi bahasa
- D. Edukasi kepada orang tua tentang stimulasi interaksi sosial dan permainan kooperatif
- E. Mengabaikan kondisi karena masih dalam batas wajar

Soal 5:

Seorang anak laki-laki berusia 5,5 tahun dibawa ke Klinik Pratama oleh orang tuanya dengan keluhan kesulitan memahami konsep waktu seperti "kemarin", "sekarang", dan "besok". Dari hasil pemeriksaan Denver II ditemukan keterlambatan pada aspek perkembangan kognitif saja. Manakah tindakan intervensi awal yang sebaiknya dilakukan?

- A. Merujuk segera ke dokter spesialis saraf
- B. Latihan intensif motorik kasar
- C. Mengajarkan konsep waktu melalui cerita sederhana dan rutinitas harian
- D. Terapi wicara
- E. Mengabaikan karena kondisi akan membaik sendiri

Kunci Jawaban:

1. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Keterlambatan bicara dan kesulitan memahami instruksi sederhana merupakan tanda khas gangguan perkembangan bahasa. Hal ini diperkuat dengan hasil skrining Denver II yang menunjukkan keterlambatan hanya di area bahasa.

2. Kunci Jawaban: B

Pembahasan:

Intervensi awal yang tepat untuk gangguan motorik halus adalah memberikan edukasi stimulasi melalui aktivitas menggambar, menyusun puzzle, atau bermain plastisin agar anak mampu meningkatkan keterampilan koordinasi tangan dan jarinya.

3. Kunci Jawaban: E

Pembahasan:

Gangguan motorik kasar perlu stimulasi melalui latihan fisik seperti bermain bola, melompat, atau bersepeda untuk menguatkan koordinasi otot besar dan keseimbangan tubuh.

4. Kunci Jawaban: D

Pembahasan:

Intervensi awal terbaik adalah memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya stimulasi interaksi sosial melalui aktivitas bermain kelompok, berbagi, dan memahami konsep giliran secara rutin.

5. Kunci Jawaban: C

Pembahasan:

Gangguan pemahaman konsep waktu merupakan keterlambatan kognitif ringan yang bisa diperbaiki dengan mengajarkan konsep tersebut melalui cerita sederhana, rutinitas harian, atau menggunakan ilustrasi yang mudah dipahami anak.

I. Soal OSCE Kebidanan

Topik: Pemantauan dan Stimulasi Perkembangan Anak Usia Prasekolah (3–6 Tahun)

Skenario Kasus

Seorang ibu membawa anak perempuannya yang bernama **Aisyah**, berusia 4 tahun ke Praktik Mandiri Bidan karena merasa khawatir perkembangan anaknya terlambat dibanding teman seusianya. Ibu Aisyah mengatakan bahwa anaknya kesulitan menggambar bentuk sederhana, masih kurang jelas dalam berbicara, dan sulit berinteraksi dengan teman sebaya. Ibu meminta Anda sebagai bidan untuk memeriksa dan memberikan saran yang tepat tentang tumbuh kembang anaknya.

Tugas Peserta

Anda adalah seorang bidan yang bertugas di Praktik Mandiri. Anda diminta untuk:

1. Menjalin komunikasi yang efektif dengan ibu anak (orang tua).
2. Melakukan anamnesis singkat terkait perkembangan anak prasekolah.
3. Melakukan skrining perkembangan menggunakan Denver II (aspek motorik halus, bahasa, personal-sosial).
4. Memberikan edukasi dan demonstrasi stimulasi perkembangan motorik halus, bahasa, dan sosial kepada ibu.
5. Menyusun rencana tindak lanjut dan rekomendasi yang jelas kepada ibu Aisyah.

Waktu yang tersedia: **15 menit**

Tugas Penguji

1. Mengobservasi kemampuan peserta dalam berkomunikasi dengan ibu pasien.
2. Mengamati teknik peserta saat melakukan skrining Denver II.
3. Mengobservasi kejelasan peserta dalam memberikan edukasi dan demonstrasi stimulasi.
4. Mengamati ketepatan peserta dalam menyusun rencana intervensi dan rekomendasi yang diberikan kepada orang tua.

Tugas Pasien Simulasi (Ibu Anak)

1. Memerankan seorang ibu yang cemas dengan kondisi anaknya.
2. Menjawab pertanyaan peserta dengan jelas sesuai skenario berikut:
 - Anak sulit menggambar bentuk sederhana seperti lingkaran atau kotak.
 - Anak berbicara tidak jelas, sering kesulitan menyusun kalimat.

- Anak sulit berinteraksi dengan teman sebaya di lingkungan bermain.
3. Menunjukkan sikap kooperatif dan responsif saat diberikan edukasi oleh peserta.

Daftar Alat Dan Bahan

1. Formulir Denver II
2. Alat tulis (kertas, pensil, krayon)
3. Bola kecil
4. Buku cerita bergambar
5. Puzzle sederhana
6. Mainan edukatif kecil (balok, plastisin)
7. Kursi dan meja pemeriksaan anak
8. Jam stopwatch untuk waktu pengukuran

RUBRIK PENILAIAN OSCE

Aspek Penilaian	Bobot	Skor 1	Skor 2	Skor 3	Skor 4	Skor 5
1. Komunikasi Efektif dengan Orang Tua	20%	Tidak jelas, kurang ramah	Kurang jelas, sedikit ramah	Cukup jelas dan ramah	Jelas, ramah, empati	Sangat jelas, sangat ramah, empati tinggi
2. Anamnesis Perkembangan Anak	15%	Tidak relevan dan tidak sistematis	Kurang relevan, tidak lengkap	Cukup relevan, kurang lengkap	Relevan, cukup sistematis dan lengkap	Sangat relevan, sistematis, dan lengkap
3. Teknik Skrining Denver II	20%	Salah prosedur skrining	Kurang tepat, banyak yang terlewat	Cukup tepat, beberapa aspek terlewat	Tepat, hampir semua aspek diperiksa	Sangat tepat, semua aspek diperiksa lengkap
4. Edukasi dan Demonstrasi Stimulasi	25%	Tidak jelas, tidak ada demonstrasi	Kurang jelas, demonstrasi kurang efektif	Cukup jelas, demonstrasi cukup efektif	Jelas, demonstrasi efektif	Sangat jelas, demonstrasi sangat efektif, mudah dipahami
5. Rencana Tindak Lanjut	20%	Tidak memberikan rekomendasi jelas	Rekomendasi tidak relevan	Rekomendasi cukup relevan, kurang jelas	Rekomendasi relevan dan jelas	Rekomendasi sangat relevan, jelas, mudah dilaksanakan

Keterangan Skor:

- **Skor 1:** Sangat kurang/tidak kompeten
- **Skor 2:** Kurang kompeten
- **Skor 3:** Cukup kompeten
- **Skor 4:** Kompeten
- **Skor 5:** Sangat kompeten

Kunci Jawaban / Pembahasan

Peserta harus mampu melaksanakan tugas OSCE dengan kompeten sebagai berikut:

1. Komunikasi efektif: Menyambut ibu dengan ramah, memperkenalkan diri, menanyakan nama anak, usia, serta menenangkan kekhawatiran ibu.
2. Anamnesis singkat: Menanyakan spesifik mengenai aspek perkembangan motorik halus (menggambar, menulis), bahasa (cara bicara, pemahaman kalimat), dan sosial (interaksi dengan teman).
3. Skrining Denver II: Peserta melakukan skrining aspek motorik halus (meminta anak menggambar lingkaran), bahasa (berbicara sederhana dan mengikuti perintah sederhana), personal-sosial (menanyakan tentang interaksi teman sebaya).
4. Edukasi dan Demonstrasi:
 - Motorik halus: Demonstrasi menggambar lingkaran, menyusun puzzle, bermain plastisin.
 - Bahasa: Membaca buku cerita, mengajak anak diskusi, bernyanyi.
 - Sosial: Mengajak bermain peran atau berbagi mainan sederhana.
5. Rencana Tindak Lanjut:
 - Memberikan rekomendasi kegiatan stimulasi di rumah secara rutin.
 - Menyarankan ibu untuk memberikan stimulasi intensif selama 2–3 bulan kemudian evaluasi ulang.
 - Jika masih ada gangguan perkembangan setelah evaluasi, segera merujuk ke spesialis perkembangan anak (dokter spesialis anak atau psikolog anak).

Bab 5

Asuhan Neonatus dan Bayi Sehat

A. Pendahuluan

Periode neonatal, yaitu sejak lahir hingga usia 28 hari, merupakan masa kritis dalam kehidupan seorang bayi karena terjadi transisi penting dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Pada periode ini, berbagai adaptasi fisiologis penting terjadi, khususnya dalam fungsi sistem pernapasan, sirkulasi darah, dan pengaturan suhu tubuh. Kualitas asuhan yang diberikan selama masa neonatal sangat menentukan kelangsungan hidup bayi, pencegahan komplikasi, serta pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Asuhan neonatal yang baik mencakup berbagai tindakan sistematis yang diberikan segera setelah bayi lahir, seperti penilaian kondisi bayi melalui skor APGAR, menjaga suhu tubuh melalui pengeringan dan kontak kulit-ke-kulit, pemotongan serta perawatan tali pusat, pemberian profilaksis mata, dan vitamin K untuk mencegah komplikasi dini. Selain itu, asuhan rutin yang konsisten dalam pemantauan kondisi kesehatan, pertumbuhan fisik, perkembangan neurologis, serta imunisasi dasar merupakan bagian penting yang harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bayi tumbuh sehat dan optimal.

Selain tindakan klinis, pemberian edukasi kepada orang tua tentang berbagai aspek perawatan bayi sehat menjadi hal yang tidak kalah penting. Edukasi ini meliputi pentingnya pemberian ASI eksklusif, teknik perawatan tali pusat secara kering (dry cord care), perawatan kulit bayi, pengenalan tanda bahaya pada bayi, serta strategi pengelolaan pola tidur yang aman. Dengan pengetahuan yang tepat, orang tua akan

mampu memberikan perawatan yang optimal di rumah serta segera mengenali dan melaporkan gejala-gejala yang memerlukan perhatian medis.

Terakhir, pencegahan infeksi merupakan aspek kritis yang tidak boleh diabaikan dalam asuhan neonatal. Infeksi merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada bayi baru lahir. Strategi pencegahan yang meliputi kebersihan tangan, imunisasi tepat waktu, perawatan kulit dan tali pusat yang steril, serta sterilisasi peralatan bayi, merupakan langkah-langkah efektif dalam melindungi bayi dari infeksi yang berpotensi membahayakan.

Dalam bab ini, mahasiswa akan mempelajari secara komprehensif tentang asuhan neonatal dan bayi sehat, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, profesional, dan sesuai standar nasional untuk mendukung kesehatan serta tumbuh kembang bayi secara optimal.

B. Capaian Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

- a. Mahasiswa mampu memberikan asuhan kebidanan komprehensif kepada neonatus dan bayi sehat secara profesional, holistik, dan sesuai standar pelayanan kesehatan nasional.
- b. Mahasiswa mampu memberikan edukasi yang jelas, praktis, dan efektif kepada orang tua tentang perawatan bayi sehat.
- c. Mahasiswa mampu melakukan upaya pencegahan infeksi pada neonatus dan bayi sesuai pedoman kesehatan yang berlaku.

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

- a. Mahasiswa mampu melakukan asuhan segera setelah lahir secara sistematis dan tepat sesuai standar pelayanan kebidanan nasional.
- b. Mahasiswa mampu memberikan asuhan rutin yang komprehensif pada bayi baru lahir normal hingga usia 28 hari.
- c. Mahasiswa mampu memberikan edukasi secara efektif kepada orang tua tentang perawatan bayi sehat di rumah.
- d. Mahasiswa mampu menerapkan strategi pencegahan infeksi pada neonatus dan bayi secara tepat dan efektif.

3. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

CPMK 1: Asuhan Segera Setelah Lahir

- **Sub-CPMK 1.1:** Mahasiswa mampu melakukan penilaian APGAR pada bayi baru lahir secara tepat dan akurat.
- **Sub-CPMK 1.2:** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pengeringan bayi dan kontak kulit-ke-kulit (IMD) sesuai standar.
- **Sub-CPMK 1.3:** Mahasiswa mampu melakukan pemotongan dan perawatan tali pusat menggunakan metode dry cord care secara steril.
- **Sub-CPMK 1.4:** Mahasiswa mampu memberikan profilaksis mata dan vitamin K dengan teknik yang benar.

CPMK 2: Asuhan Rutin Neonatus Hingga Usia 28 Hari

- **Sub-CPMK 2.1:** Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik rutin (berat badan, panjang badan, lingkar kepala, refleks neonatal, pemeriksaan kulit) pada neonatus secara sistematis.
- **Sub-CPMK 2.2:** Mahasiswa mampu memantau tanda vital neonatus secara akurat (pernapasan, denyut jantung, suhu tubuh, pola eliminasi).
- **Sub-CPMK 2.3:** Mahasiswa mampu memberikan imunisasi dasar (HB-0, BCG, OPV-0) sesuai jadwal imunisasi nasional.
- **Sub-CPMK 2.4:** Mahasiswa mampu memantau tumbuh kembang neonatus menggunakan kurva pertumbuhan WHO dan mengidentifikasi keterlambatan perkembangan secara dini.
- **Sub-CPMK 2.5:** Mahasiswa mampu melakukan skrining neonatal (hipotiroidisme kongenital, PKU, gangguan pendengaran) secara tepat waktu dan akurat.

CPMK 3: Edukasi Orang Tua tentang Perawatan Bayi Sehat

- **Sub-CPMK 3.1:** Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya pemberian ASI eksklusif, teknik menyusui yang benar, serta tanda bayi mendapat cukup ASI kepada orang tua.
- **Sub-CPMK 3.2:** Mahasiswa mampu memberikan edukasi tentang perawatan tali pusat yang benar (dry cord care) dan tanda bahaya infeksi tali pusat.
- **Sub-CPMK 3.3:** Mahasiswa mampu menjelaskan teknik perawatan kulit bayi yang benar dan pencegahan ruam popok secara jelas dan praktis.
- **Sub-CPMK 3.4:** Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengedukasi tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir yang harus segera dilaporkan kepada tenaga kesehatan.

- **Sub-CPMK 3.5:** Mahasiswa mampu memberikan edukasi tentang manajemen pola tidur dan teknik menenangkan bayi secara efektif dan aman.

CPMK 4: Pencegahan Infeksi pada Neonatus dan Bayi

- **Sub-CPMK 4.1:** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan dan mengedukasi tentang teknik mencuci tangan yang benar dalam perawatan bayi.
- **Sub-CPMK 4.2:** Mahasiswa mampu memberikan imunisasi tepat waktu sebagai upaya pencegahan infeksi pada neonatus sesuai panduan nasional.
- **Sub-CPMK 4.3:** Mahasiswa mampu melakukan perawatan kulit dan tali pusat bayi secara steril dan mencegah risiko infeksi.
- **Sub-CPMK 4.4:** Mahasiswa mampu memberikan edukasi tentang pembatasan kontak bayi dengan orang sakit untuk mencegah penularan infeksi.
- **Sub-CPMK 4.5:** Mahasiswa mampu mendemonstrasikan cara sterilisasi alat-alat perawatan bayi dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar bayi secara efektif.

C. Asuhan Segera Setelah Lahir

Asuhan segera setelah lahir merupakan tindakan penting dalam memastikan bayi baru lahir dapat beradaptasi secara optimal terhadap kehidupan di luar kandungan. Masa transisi ini sangat krusial karena organ vital bayi, khususnya sistem pernapasan, peredaran darah, serta sistem pengaturan suhu tubuh, harus segera berfungsi secara mandiri. Oleh karena itu, asuhan yang diberikan harus dilakukan secara sistematis, cepat, tepat, dan sesuai standar pelayanan kesehatan.

Tujuan utama asuhan segera setelah lahir adalah menjamin keselamatan bayi, mendukung proses adaptasi fisiologis yang optimal, serta mencegah komplikasi yang dapat timbul di menit-menit pertama kehidupan bayi.

Secara *detail*, langkah-langkah asuhan segera setelah lahir mencakup:

1. Penilaian Awal Bayi (APGAR Score)

Penilaian APGAR merupakan pemeriksaan standar yang dilakukan segera setelah bayi lahir, dilakukan dua kali yaitu pada menit pertama dan menit kelima setelah lahir. Tujuannya untuk mengevaluasi secara cepat kondisi bayi dan menentukan apakah bayi membutuhkan intervensi medis tambahan atau tidak.

Penilaian APGAR mencakup lima parameter utama:

Parameter Penilaian APGAR

Parameter	Skor 0	Skor 1	Skor 2
Warna kulit	Biru atau pucat seluruhnya	Badan kemerahan, ekstremitas biru	Seluruh tubuh kemerahan
Denyut jantung	Tidak ada	<100 kali/menit	≥100 kali/menit
Refleks iritabilitas	Tidak ada respons	Meringis atau gerakan minimal	Menangis kuat, batuk, bersin
Tonus otot	Lemah, lembek	Fleksi sedikit pada ekstremitas	Gerakan aktif, fleksi ekstremitas kuat
Pernapasan	Tidak ada	Lambat, tidak teratur, menangis lemah	Menangis kuat, teratur

Interpretasi skor APGAR adalah sebagai berikut:

- **Skor 7-10:** Bayi dalam kondisi baik, hanya memerlukan observasi rutin.
- **Skor 4-6:** Bayi mengalami gangguan adaptasi sedang, memerlukan stimulasi tambahan seperti menggosok punggung atau oksigen tambahan.
- **Skor ≤3:** Bayi dalam keadaan kritis, memerlukan resusitasi aktif segera.

2. Pengeringan dan Kehangatan

Segera setelah lahir, bayi harus dikeringkan secara menyeluruh dengan kain bersih yang kering dan hangat. Tindakan ini bertujuan untuk:

- **Mencegah hipotermia:** Bayi baru lahir rentan kehilangan panas tubuh dengan cepat, sehingga pengeringan segera merupakan tindakan penting dalam menjaga suhu tubuh bayi.
- **Stimulasi pernapasan:** Mengeringkan bayi dengan gesekan lembut di punggung dapat membantu stimulasi refleks pernapasan.

Setelah pengeringan selesai, segera lakukan kontak kulit-ke-kulit (skin-to-skin contact) antara bayi dengan ibu minimal satu jam setelah lahir, yang dikenal dengan **Inisiasi Menyusu Dini (IMD)**. Tindakan ini memiliki manfaat signifikan antara lain:

- Menstabilkan suhu tubuh bayi secara alami melalui suhu tubuh ibu.
- Membantu stabilisasi detak jantung dan pernapasan bayi.

- Mendorong bayi melakukan hisapan pertama untuk menyusui, yang sangat penting untuk memulai pemberian ASI eksklusif.
- Membantu proses bonding psikologis antara ibu dan bayi.

3. Pemotongan dan Perawatan Tali Pusat

Tali pusat dipotong setelah berhenti berdenyut (delayed cord clamping), yaitu sekitar 1-3 menit setelah lahir. Penundaan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

- Menambah volume darah bayi, sehingga meningkatkan cadangan zat besi dan hemoglobin, yang penting untuk mencegah anemia pada bayi.
- Menurunkan risiko perdarahan intraventrikular, khususnya pada bayi prematur.

Pemotongan tali pusat dilakukan dengan alat steril (gunting steril atau penjepit tali pusat steril) untuk mencegah infeksi. Setelah pemotongan tali pusat, perawatan tali pusat dilakukan dengan metode perawatan kering (dry cord care):

- Tali pusat dijaga tetap bersih dan kering tanpa pemberian bahan tambahan seperti alkohol atau antiseptik kecuali terdapat indikasi khusus.
- Perawatan kering terbukti efektif mencegah infeksi dan mempercepat pelepasan tali pusat (biasanya dalam waktu 5–10 hari).

4. Pemberian Profilaksis Mata dan Vitamin K

a. Profilaksis Mata

Pemberian profilaksis mata dilakukan dengan salep antibiotik mata seperti eritromisin 0,5% atau tetrasiklin 1% segera setelah lahir, bertujuan mencegah oftalmia neonatorum, yaitu infeksi mata berat yang biasanya disebabkan oleh gonore atau klamidia dari jalan lahir ibu.

Cara pemberiannya:

- Oleskan salep sepanjang kelopak mata bagian bawah secara hati-hati, mulai dari sudut dalam ke arah sudut luar mata.
- Lakukan secara steril dan lembut agar tidak melukai bayi.

b. Pemberian Vitamin K

Vitamin K diberikan pada bayi baru lahir secara intramuskular di paha bagian luar dengan dosis tunggal 1 mg, paling lambat 6 jam setelah kelahiran. Tujuan pemberian vitamin K adalah mencegah perdarahan neonatus akibat defisiensi vitamin K (Hemorrhagic Disease of Newborn/HDN).

Alasan pemberian vitamin K adalah karena bayi baru lahir belum mampu memproduksi vitamin K secara optimal akibat:

- Kolonisasi bakteri usus yang belum sempurna.
- Transfer vitamin K dari plasenta yang terbatas.
- ASI yang kandungan vitamin K-nya relatif rendah pada minggu pertama setelah lahir.

Pemberian vitamin K sangat penting untuk mencegah perdarahan internal atau eksternal yang berisiko tinggi menyebabkan morbiditas bahkan mortalitas bayi.

D. Asuhan Rutin Pada Bayi Baru Lahir Normal Hingga Usia 28 Hari

Masa neonatal, yang berlangsung sejak kelahiran hingga usia 28 hari, merupakan periode paling kritis dalam kehidupan bayi. Dalam masa ini, bayi menjalani adaptasi yang kompleks dari kehidupan intrauterin ke lingkungan ekstrauterin. Untuk memastikan adaptasi yang optimal serta pertumbuhan dan perkembangan bayi berjalan sesuai standar, diperlukan asuhan rutin yang sistematis, teratur, dan komprehensif.

1. Tujuan Asuhan Rutin

Asuhan rutin pada bayi baru lahir bertujuan untuk:

- Memantau dan memastikan kondisi bayi tetap sehat dan berkembang optimal.
- Mendeteksi secara dini adanya gangguan atau kelainan kesehatan agar dapat segera diintervensi.
- Menyediakan imunisasi dasar sebagai upaya pencegahan penyakit yang umum terjadi pada masa neonatal.
- Memberikan informasi dan edukasi kepada orang tua mengenai pemantauan kesehatan bayi secara mandiri.

Asuhan rutin ini mencakup berbagai tindakan, antara lain pemeriksaan fisik, pemantauan tanda vital, pemberian imunisasi dasar, pemantauan tumbuh kembang, serta skrining neonatal.

2. Pemeriksaan Fisik Rutin

Pemeriksaan fisik rutin merupakan tindakan dasar yang wajib dilakukan secara berkala (biasanya setiap kunjungan ke tenaga kesehatan) untuk mengidentifikasi keadaan umum bayi secara menyeluruh. Komponen penting pemeriksaan ini meliputi:

- **Berat badan:** Pemeriksaan dilakukan secara berkala untuk memantau peningkatan berat badan yang optimal, yaitu sekitar 150–200 gram per minggu pada bulan pertama kehidupan. Penurunan berat badan hingga maksimal 10% dari berat lahir dalam minggu pertama dianggap normal, namun bayi diharapkan kembali ke berat lahir pada akhir minggu kedua.
- **Panjang badan:** Pemantauan panjang badan penting untuk mendeteksi pertumbuhan linier bayi. Panjang rata-rata bayi baru lahir adalah sekitar 48–52 cm, dengan penambahan sekitar 3–4 cm dalam bulan pertama.
- **Lingkar kepala:** Dilakukan untuk mendeteksi perkembangan otak yang optimal. Lingkar kepala normal saat lahir berkisar antara 33–37 cm, bertambah sekitar 1 cm setiap bulan.
- **Refleks neonatal:** Pemeriksaan refleks ini mencakup refleks rooting, sucking, grasping, Moro, stepping, dan Babinski. Refleks ini penting untuk memastikan integritas sistem saraf bayi.
- **Pemeriksaan kulit:** Dilakukan untuk mengidentifikasi adanya ruam, lesi, jaundice (ikterus neonatorum), serta memastikan integritas kulit bayi secara umum.

3. Pemantauan Tanda Vital

Pemantauan tanda vital merupakan komponen penting yang harus rutin dilakukan setiap kali kunjungan atau pemantauan harian oleh orang tua. Tanda vital yang dipantau meliputi:

- **Pernapasan:** Normalnya 30–60 kali per menit, dengan pola pernapasan teratur tanpa suara tambahan seperti mendengkur atau retraksi dada.
- **Denyut jantung:** Normalnya 120–160 denyut per menit, dengan ritme yang teratur.
- **Suhu tubuh:** Normal berkisar antara 36,5°C–37,5°C. Hipotermia atau hipertermia harus segera ditangani karena bayi neonatus rentan terhadap perubahan suhu lingkungan.
- **Pola eliminasi:** Frekuensi urin minimal 6–8 kali sehari, tinja 3–5 kali sehari pada minggu pertama. Pemantauan eliminasi penting untuk memastikan fungsi ginjal dan sistem pencernaan normal.

4. Pemberian Imunisasi Dasar

Imunisasi dasar wajib diberikan sesuai jadwal imunisasi nasional untuk melindungi bayi dari penyakit infeksi serius:

- **Imunisasi Hepatitis B (HB-0):** Diberikan segera setelah lahir atau maksimal dalam 24 jam pertama kehidupan. Imunisasi ini mencegah risiko transmisi virus Hepatitis B dari ibu ke bayi, serta melindungi dari infeksi Hepatitis B akut dan kronik.
- **Imunisasi BCG (Bacillus Calmette-Guerin):** Diberikan pada usia 0–1 bulan, berfungsi melindungi bayi dari tuberkulosis (TB) berat.
- **Imunisasi Polio Oral (OPV-0):** Diberikan segera setelah lahir untuk melindungi bayi dari virus polio yang berpotensi menyebabkan kelumpuhan.

Pemberian imunisasi ini harus dicatat secara akurat dalam buku kesehatan bayi untuk pemantauan lanjutan.

5. Pemantauan Tumbuh Kembang

Pemantauan tumbuh kembang merupakan elemen kunci asuhan rutin yang dilakukan setiap minggu hingga usia 1 bulan, dan dilanjutkan secara berkala. Tujuannya adalah memastikan bahwa bayi mengalami pertumbuhan fisik serta perkembangan neurologis yang sesuai dengan usia:

- **Kurva pertumbuhan WHO:** Digunakan sebagai alat standar untuk mengevaluasi berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala bayi. Dengan kurva ini, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi secara dini masalah tumbuh kembang seperti gagal tumbuh (failure to thrive) atau pertumbuhan berlebih.
- **Pengamatan perkembangan neurologis:** Pemantauan refleks neonatal secara berkala, pengamatan respons terhadap suara, cahaya, sentuhan, serta kemampuan motorik awal bayi, seperti mengangkat kepala sebentar saat tengkurap, penting untuk mendeteksi perkembangan neurologis normal atau keterlambatan perkembangan dini.

6. Skrining Neonatal

Skrining neonatal merupakan tindakan preventif yang bertujuan mengidentifikasi secara dini gangguan metabolik atau kongenital yang tidak langsung terdeteksi secara fisik:

- **Hipotiroidisme kongenital:** Deteksi melalui pemeriksaan kadar hormon TSH neonatal pada hari ke-3 hingga ke-5 setelah lahir, bertujuan menghindari keterlambatan tumbuh kembang akibat defisiensi hormon tiroid.
- **Fenilketonuria (PKU):** Dilakukan dengan pemeriksaan darah kapiler bayi untuk mendeteksi kadar fenilalanin tinggi. Deteksi dini penting agar bayi dapat segera menjalani diet khusus untuk mencegah retardasi mental berat.
- **Gangguan pendengaran:** Skrining dilakukan dengan tes OAE (otoacoustic emissions) atau ABR (auditory brainstem response), bertujuan mendeteksi gangguan pendengaran sejak dini yang dapat mempengaruhi perkembangan bicara dan bahasa bayi.

E. Edukasi Orang Tua Tentang Perawatan Bayi Sehat

Edukasi yang tepat kepada orang tua merupakan komponen esensial untuk memastikan kesehatan, pertumbuhan, dan perkembangan optimal bayi setelah dibawa pulang dari fasilitas kesehatan. Orang tua perlu diberikan informasi yang jelas, praktis, dan mudah dipahami, mencakup aspek pemberian ASI, perawatan sehari-hari, pengenalan tanda-tanda bahaya, dan manajemen kenyamanan bayi.

1. Pemberian ASI Eksklusif

a. Pentingnya ASI Eksklusif

ASI eksklusif adalah pemberian hanya ASI tanpa tambahan makanan atau cairan lain hingga bayi berusia 6 bulan. Manfaat ASI eksklusif meliputi:

- Mengandung nutrisi lengkap yang tepat untuk bayi baru lahir hingga usia 6 bulan.
- Memberikan zat antibodi alami yang melindungi bayi dari infeksi seperti diare, pneumonia, infeksi telinga, dan alergi.
- Meningkatkan hubungan emosional (bonding) antara ibu dan bayi.
- Mengurangi risiko kematian bayi serta membantu perkembangan fisik dan intelektual secara optimal.

b. Teknik Menyusui yang Benar

- Posisi ibu nyaman (duduk tegak dengan punggung bersandar).
- Bayi ditempatkan sejajar perut ibu (tubuh bayi menghadap ke tubuh ibu), kepala dan tubuh bayi lurus.
- Bayi membuka mulut lebar, dagu bayi menempel erat ke payudara, bibir bawah bayi terlipat keluar, sebagian besar areola (bagian gelap payudara) masuk ke dalam mulut bayi.

- Pastikan ibu tidak mengalami nyeri atau ketidaknyamanan berlebihan selama menyusui.

c. Manajemen Laktasi

- Menyusui bayi sesering mungkin, minimal 8–12 kali sehari.
- Jangan membatasi durasi menyusui; biarkan bayi menyusu hingga puas (sekitar 15–20 menit pada tiap payudara).
- Ibu perlu konsumsi makanan bergizi, cairan yang cukup, istirahat cukup, serta hindari stres berlebihan agar produksi ASI optimal.

d. Tanda Bayi Cukup ASI

- Bayi tampak puas dan tenang setelah menyusu.
- Buang air kecil minimal 6 kali sehari dengan warna urine jernih kekuningan.
- Berat badan bertambah secara konsisten, sekitar 150–200 gram per minggu setelah minggu pertama.
- Bayi tidur nyenyak dan bangun sendiri saat lapar.

2. Perawatan Tali Pusat

a. Perawatan Tali Pusat yang Benar

- Metode terbaik adalah **perawatan kering (dry cord care)**, yaitu tali pusat dibiarkan terbuka tanpa ditutup kain atau kasa dan tidak perlu diberikan alkohol atau antiseptik.
- Tali pusat biasanya puput sendiri dalam 7–14 hari setelah lahir.
- Pastikan tali pusat tetap kering, jangan terkena air secara langsung saat mandi.
- Saat popok digunakan, lipat popok di bawah pangkal tali pusat untuk mencegah iritasi dan menjaga tali pusat agar tetap kering.

b. Tanda Infeksi Tali Pusat yang Harus Diwaspadai

Orang tua harus segera membawa bayi ke fasilitas kesehatan bila terdapat:

- Kemerahan dan bengkak di sekitar pangkal tali pusat.
- Keluar cairan berbau atau nanah dari tali pusat.
- Bayi rewel, demam tinggi ($>38^{\circ}\text{C}$), atau tampak sakit.

3. Perawatan Kulit Bayi

Kulit bayi sangat sensitif dan rentan terhadap iritasi. Penting untuk memberikan perawatan yang tepat agar kulit bayi tetap sehat.

a. Cara Membersihkan Kulit Bayi

- Gunakan air hangat dengan suhu sekitar $36,5\text{--}37,5^{\circ}\text{C}$.

- Pakai sabun bayi yang ringan, bebas pewangi, pewarna, dan iritan lainnya.
- Frekuensi mandi cukup 2–3 kali seminggu; setiap hari cukup bersihkan area wajah, tangan, area popok, dan lipatan kulit dengan kain lembut yang dibasahi air hangat.

b. Pencegahan Ruam Popok dan Iritasi Kulit

- Ganti popok setiap 2–3 jam atau segera setelah bayi buang air besar.
- Bersihkan area popok secara lembut, keringkan dengan menepuk-nepuk lembut, jangan menggosok kulit bayi.
- Gunakan pelembap bayi atau krim pelindung (barrier cream) pada area popok.
- Berikan waktu bagi bayi untuk tidak memakai popok sesekali (diangin-anginkan).

4. Tanda Bahaya pada Bayi

Orang tua harus bisa mengenali tanda bahaya yang memerlukan perhatian medis segera:

- Demam tinggi ($>38^{\circ}\text{C}$) atau hipotermia (suhu tubuh $<36^{\circ}\text{C}$).
- Sesak napas atau kesulitan bernapas, ditandai napas cepat (>60 kali/menit), bayi tampak kebiruan, atau terdengar suara napas abnormal (mengi).
- Kejang atau gerakan abnormal yang tidak terkontrol.
- Muntah hebat atau terus-menerus, terutama disertai perut kembung, muntah berwarna hijau, atau bayi tidak mau menyusu sama sekali.
- Bayi sangat lemas, mengantuk terus-menerus, sulit dibangunkan, atau tidak responsif terhadap rangsangan.
- Perdarahan aktif dari tali pusat, hidung, mulut, atau bagian tubuh lainnya.

Jika salah satu tanda di atas ditemukan, bayi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat.

5. Manajemen Pola Tidur dan Menenangkan Bayi

Pola tidur bayi baru lahir bervariasi, namun orang tua perlu mengenal pola tidur yang normal dan teknik menenangkan bayi yang efektif.

a. Pola Tidur Bayi yang Normal

- Bayi baru lahir tidur sekitar 16–20 jam per hari, dengan siklus tidur singkat sekitar 2–4 jam, bangun untuk menyusu, lalu tidur lagi.
- Seiring usia bertambah, bayi akan memiliki pola tidur yang lebih panjang pada malam hari (sekitar usia 3 bulan ke atas).

b. Teknik Menenangkan Bayi

- Kontak kulit-ke-kulit antara bayi dan orang tua (skin-to-skin contact).
- Menggendong dan mengayun bayi dengan gerakan perlahan dan teratur.
- Menyanyikan lagu pengantar tidur dengan suara lembut atau menggunakan suara latar yang tenang seperti white noise.
- Membalut bayi dengan kain lembut (swaddling), tidak terlalu ketat, agar bayi merasa hangat dan nyaman.

c. Keamanan Tidur

- Bayi harus tidur dalam posisi telentang, permukaan tidur rata dan keras, tanpa bantal, boneka, atau benda lembut lainnya di sekitar bayi.
- Ini penting untuk mengurangi risiko Sindrom Kematian Bayi Mendadak (SIDS).

F. Pencegahan Infeksi Pada Neonatus dan Bayi

Pencegahan infeksi pada neonatus dan bayi sangat krusial karena pada usia ini sistem imun bayi masih belum sempurna dan rentan terhadap berbagai jenis infeksi. Infeksi pada bayi baru lahir dapat menyebabkan komplikasi serius seperti sepsis, pneumonia, meningitis, bahkan kematian. Strategi pencegahan yang efektif sangat diperlukan untuk melindungi bayi dari risiko infeksi.

1. Cuci Tangan

a. Pentingnya Cuci Tangan

Cuci tangan merupakan langkah paling sederhana namun efektif dalam mencegah penularan infeksi kepada bayi. Orang tua, keluarga, maupun tenaga kesehatan yang merawat bayi harus rutin mencuci tangan, terutama sebelum dan sesudah melakukan kontak dengan bayi atau barang-barangnya.

b. Langkah-langkah Mencuci Tangan yang Benar

- Basahi tangan dengan air mengalir.
- Gunakan sabun secukupnya dan gosokkan pada seluruh bagian tangan, termasuk sela jari, kuku, pergelangan tangan, serta punggung tangan selama minimal 20 detik.
- Bilas tangan dengan air mengalir hingga bersih.
- Keringkan dengan handuk bersih atau tissue sekali pakai.

c. Kapan Cuci Tangan Dilakukan

- Sebelum menggendong atau menyentuh bayi.
- Sebelum menyusui atau menyiapkan makanan bayi.
- Setelah mengganti popok bayi atau membersihkan bayi.

- Setelah menggunakan toilet.
- Setelah bersin, batuk, atau menyentuh barang yang berpotensi kotor.

2. Imunisasi Tepat Waktu

a. Manfaat Imunisasi Tepat Waktu

Imunisasi memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit menular serius seperti Hepatitis B, Tuberkulosis (TBC), Polio, Difteri, Pertusis, Tetanus, dan campak. Vaksinasi sejak dini memastikan bahwa bayi menerima perlindungan optimal sebelum potensi paparan terhadap agen infeksi.

b. Jadwal Imunisasi Dasar Bayi Baru Lahir menurut Kemenkes RI

- Hepatitis B (HB-0): diberikan segera dalam 24 jam pertama setelah lahir.
- Polio-0 (OPV-0): diberikan segera setelah lahir hingga usia 1 bulan.
- BCG: diberikan sebelum bayi berusia 1 bulan.

Imunisasi berikutnya harus sesuai jadwal imunisasi nasional yang telah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

3. Perawatan Kulit dan Tali Pusat yang Steril

a. Perawatan Tali Pusat

Tali pusat bayi merupakan jalan masuk yang potensial bagi infeksi jika tidak dirawat dengan benar. Cara terbaik untuk merawat tali pusat adalah metode dry cord care, yaitu menjaga agar tali pusat tetap kering dan bersih hingga puput secara alami dalam waktu 1–2 minggu.

b. Cara menjaga Kebersihan Tali Pusat

- Cuci tangan sebelum dan setelah perawatan tali pusat.
- Jangan menutup tali pusat dengan kain kasa, plester, atau benda lainnya.
- Lipat popok di bawah pangkal tali pusat agar tidak terkena urine atau feses.
- Pantau tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, nanah, atau bau tidak sedap pada area tali pusat.

c. Perawatan Kulit Bayi yang Steril

Kulit bayi yang lembut mudah mengalami iritasi atau infeksi. Perawatan kulit yang baik dilakukan dengan:

- Menggunakan air hangat untuk mandi dengan sabun yang lembut khusus bayi.
- Mengeringkan kulit bayi dengan lembut menggunakan handuk bersih tanpa menggosok.

- Menggunakan pelembap bayi yang hypoallergenic untuk menjaga kelembapan kulit.
- Mengganti popok secara rutin (tiap 2–3 jam) untuk mencegah ruam popok.

4. Kontak Terbatas dengan Orang Sakit

Bayi baru lahir memiliki sistem kekebalan tubuh yang sangat lemah sehingga sangat rentan terhadap infeksi. Mengurangi kontak dengan orang sakit adalah salah satu cara pencegahan infeksi terbaik.

Panduan kontak terbatas:

- Hindari membawa bayi ke tempat keramaian seperti mall, pasar, atau transportasi umum pada minggu-minggu awal kehidupan bayi.
- Batasi jumlah pengunjung yang datang menemui bayi, terutama jika pengunjung memiliki gejala infeksi seperti flu, batuk, atau demam.
- Jika ada anggota keluarga yang sakit, disarankan untuk sementara waktu menjaga jarak dengan bayi hingga sembuh sepenuhnya.

5. Sterilisasi Alat dan Lingkungan

a. Sterilisasi Alat Bayi

Peralatan bayi seperti botol susu, dot, empeng, alat makan, dan mainan harus rutin disterilisasi untuk menghindari risiko kontaminasi bakteri atau virus.

b. Cara Sterilisasi Alat Bayi

- Sterilisasi dengan perebusan air mendidih selama minimal 5–10 menit.
- Menggunakan sterilizer elektrik atau microwave sterilizer khusus peralatan bayi.
- Simpan peralatan yang telah disterilisasi di tempat tertutup dan bersih.

c. Membersihkan Lingkungan Sekitar Bayi

Lingkungan tempat bayi tidur dan bermain harus selalu dijaga kebersihannya.

- Bersihkan permukaan tempat tidur, meja ganti popok, mainan, dan barang-barang yang sering disentuh bayi dengan cairan pembersih aman atau disinfektan ringan yang direkomendasikan untuk bayi.
- Hindari menggunakan bahan pembersih yang mengandung bahan kimia keras, karena dapat menyebabkan iritasi pada kulit atau saluran pernapasan bayi.
- Pastikan ventilasi udara yang baik di ruang bayi untuk mencegah kelembapan berlebih yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya kuman atau jamur.

G. Tugas

Tugas 1: Studi Kasus Penilaian APGAR

Tujuan: Mahasiswa mampu melakukan interpretasi skor APGAR serta menentukan tindakan lanjutannya.

Instruksi Tugas:

- Buatlah sebuah studi kasus singkat tentang bayi baru lahir.
- Tuliskan hasil penilaian APGAR bayi tersebut pada menit pertama dan kelima setelah lahir.
- Analisis dan interpretasikan skor APGAR tersebut.
- Berikan rekomendasi intervensi atau tindakan lanjutannya sesuai skor APGAR.

Keluaran Tugas:

- Naskah studi kasus (1 halaman).
- Analisis interpretasi skor APGAR dan rekomendasi intervensi (maksimal 1 halaman).

Tugas 2: Edukasi Perawatan Tali Pusat kepada Orang Tua

Tujuan: Mahasiswa mampu memberikan edukasi secara jelas kepada orang tua tentang perawatan tali pusat pada bayi baru lahir.

Instruksi Tugas:

- Buatlah panduan edukasi sederhana yang ditujukan untuk orang tua tentang cara perawatan tali pusat bayi baru lahir yang benar menggunakan metode dry cord care.
- Jelaskan juga tanda-tanda infeksi tali pusat yang perlu diwaspadai oleh orang tua.
- Gunakan bahasa yang mudah dimengerti dan ilustrasi (boleh dalam bentuk gambar atau infografis).

Keluaran Tugas: Panduan edukasi (1-2 halaman) dalam bentuk leaflet atau infografis.

Tugas 3: Video Demonstrasi Teknik Menyusui yang Benar

Tujuan: Mahasiswa mampu memperagakan teknik menyusui yang benar serta mengedukasi ibu tentang pentingnya ASI eksklusif.

Instruksi Tugas:

- Rekamlah video pendek berdurasi 3–5 menit tentang demonstrasi teknik menyusui yang benar.
- Jelaskan dalam video tentang:
 - Posisi ibu dan bayi yang benar.
 - Tanda pelekatan (latch on) bayi yang tepat.

- Tanda bayi mendapatkan cukup ASI.
 - Gunakan model boneka atau alat peraga bayi jika tidak tersedia bayi asli.
- Keluaran Tugas: Video demonstrasi berdurasi 3–5 menit dalam format MP4.

Tugas 4: Lembar Observasi Asuhan Neonatus Hingga 28 Hari

Tujuan: Mahasiswa mampu melakukan pemantauan tumbuh kembang serta pemeriksaan fisik rutin neonatus hingga usia 28 hari.

Instruksi Tugas:

- Buatlah lembar observasi yang digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan fisik rutin, tanda vital, imunisasi, serta pemantauan tumbuh kembang neonatus selama periode neonatal (28 hari pertama).
- Pastikan mencakup pemeriksaan seperti berat badan, panjang badan, lingkaran kepala, pola eliminasi, suhu, denyut jantung, frekuensi pernapasan, dan imunisasi yang diberikan.
- Sertakan kolom untuk catatan tambahan yang mungkin ditemukan saat pemeriksaan.

Keluaran Tugas: Formulir observasi (1-2 halaman).

Tugas 5: Makalah Pencegahan Infeksi pada Neonatus dan Bayi

Tujuan: Mahasiswa mampu menjelaskan strategi lengkap pencegahan infeksi pada neonatus dan bayi serta memberikan edukasi praktis pada keluarga.

Instruksi Tugas:

- Buatlah sebuah makalah singkat (maksimal 3 halaman) yang menjelaskan secara lengkap mengenai strategi pencegahan infeksi pada neonatus dan bayi.
- Makalah harus mencakup:
 - Pentingnya mencuci tangan dalam pencegahan infeksi.
 - Jadwal imunisasi wajib neonatus.
 - Cara sterilisasi alat-alat perawatan bayi.
 - Pencegahan infeksi kulit dan tali pusat.
 - Rekomendasi untuk membatasi kontak dengan orang sakit.
- Sertakan minimal 3 referensi terbaru (maksimal 5 tahun terakhir).

Keluaran Tugas: Makalah (maksimal 3 halaman), dengan format APA untuk daftar pustaka.

H. Soal Kasus

Soal 1:

Seorang bayi perempuan baru lahir spontan, menangis kuat dengan denyut jantung 120 kali/menit, tubuh merah muda namun ekstremitas masih kebiruan, gerakan aktif, dan bereaksi kuat saat hidungnya dibersihkan.

Berapakah skor APGAR bayi tersebut?

- A. 10
- B. 9
- C. 8
- D. 7
- E. 6

Soal 2:

Seorang ibu datang membawa bayinya yang berusia 7 hari dengan keluhan tali pusat kemerahan, berbau busuk, dan keluar cairan kekuningan. Bayi tampak rewel dan suhu tubuh 38,3°C.

Sebagai bidan, tindakan yang tepat adalah:

- A. Membersihkan tali pusat dengan alkohol 70%
- B. Melakukan perawatan tali pusat kering dan observasi
- C. Memberikan edukasi cara perawatan tali pusat di rumah
- D. Merujuk bayi segera ke fasilitas kesehatan
- E. Memberikan salep antibiotik topical

Soal 3:

Seorang ibu datang dengan keluhan payudara lecet saat menyusui bayi berusia 5 hari. Ibu mengeluh nyeri hebat setiap menyusui. Pemeriksaan menunjukkan bayi hanya menghisap puting tanpa mencakup areola. Edukasi yang tepat untuk ibu adalah:

- A. Membatasi waktu menyusui maksimal 10 menit tiap payudara
- B. Menyusui bayi dengan posisi kepala lebih tinggi dari badan
- C. Memastikan mulut bayi mencakup sebagian besar areola saat menyusui
- D. Menggunakan dot agar payudara istirahat sementara waktu
- E. Mengoleskan krim antiseptik pada puting sebelum menyusui

Soal 4:

Seorang ibu melahirkan bayi laki-laki secara spontan di rumah sakit. Usia bayi saat ini 18 jam setelah lahir, bayi sehat dan menyusu dengan baik.

Imunisasi dasar yang harus segera diberikan pada bayi tersebut adalah:

- A. BCG dan Polio
- B. Hepatitis B-0 dan Polio-0
- C. Hepatitis B-0
- D. BCG saja
- E. Polio-0 saja

Soal 5:

Seorang bayi berusia 10 hari dibawa ke klinik untuk pemeriksaan rutin. Bidan melihat tangan ibu tampak kotor dan ibu tidak mencuci tangan sebelum menyentuh bayi.

Edukasi paling penting yang harus segera diberikan kepada ibu adalah:

- A. Teknik mencuci tangan yang benar sebelum dan sesudah menyentuh bayi
- B. Frekuensi mandi bayi minimal 2 kali sehari
- C. Teknik menyusui yang baik agar bayi tidak sakit
- D. Cara mengganti popok secara cepat dan efisien
- E. Pola tidur bayi yang aman dan nyaman

Kunci Jawaban:

1. Jawaban: B. 9

Pembahasan:

Penilaian APGAR:

- Warna kulit: Badan merah, ekstremitas biru (skor 1)
- Denyut jantung: ≥ 100 kali/menit (skor 2)
- Refleks iritabilitas: Menangis kuat (skor 2)
- Tonus otot: Gerakan aktif (skor 2)
- Pernapasan: Menangis kuat, teratur (skor 2)

Total skor = $1 + 2 + 2 + 2 + 2 = 9$ (baik).

2. Jawaban: D. Merujuk bayi segera ke fasilitas kesehatan

Pembahasan:

Gejala infeksi berat (omfalitis) yaitu kemerahan, bau busuk, cairan kekuningan, demam, dan rewel. Tindakan tepat adalah segera merujuk bayi untuk mendapatkan terapi antibiotik sistemik dan perawatan medis lanjutan.

3. Jawaban: C. Memastikan mulut bayi mencakup sebagian besar areola

Pembahasan:

Lecet payudara sering disebabkan oleh posisi dan teknik latch-on yang salah. Teknik latch-on benar adalah mulut bayi mencakup sebagian besar areola, bukan hanya puting.

4. Jawaban: B. Hepatitis B-0 dan Polio-0

Pembahasan:

Imunisasi wajib yang segera diberikan dalam 24 jam pertama setelah lahir adalah Hepatitis B-0 dan Polio-0 untuk melindungi bayi dari infeksi virus Hepatitis B dan Polio.

5. Jawaban: A. Teknik mencuci tangan yang benar sebelum dan sesudah menyentuh bayi

Pembahasan:

Mencuci tangan secara benar adalah cara efektif mencegah infeksi. Tangan yang kotor menjadi sumber utama penularan infeksi pada bayi neonatus, sehingga edukasi ini harus segera diberikan kepada ibu.

I. Soal OSCE

Materi: Asuhan Neonatus dan Bayi Sehat

Skenario Kasus

Seorang bayi perempuan lahir secara spontan di klinik kebidanan tempat Anda bertugas. Bayi lahir tepat waktu dengan berat badan lahir 3.100 gram, panjang badan 50 cm, dan lingkar kepala 34 cm. Setelah lahir, bayi menangis kuat dengan tubuh berwarna kemerahan tetapi ekstremitasnya masih kebiruan. Denyut jantung bayi 130 kali/menit, tonus otot aktif, serta refleks iritabilitas baik. Anda diminta memberikan asuhan segera setelah lahir hingga edukasi kepada ibu tentang perawatan bayi di rumah.

Tugas Peserta

1. Lakukan penilaian APGAR bayi dengan tepat.
2. Demonstrasikan tindakan pengeringan bayi dan lakukan kontak kulit-ke-kulit (IMD).
3. Lakukan pemotongan dan perawatan tali pusat dengan benar.
4. Berikan profilaksis mata dan vitamin K dengan teknik yang benar.
5. Berikan edukasi kepada ibu mengenai:
 - Pentingnya ASI eksklusif
 - Perawatan tali pusat
 - Perawatan kulit bayi
 - Pencegahan infeksi
 - Tanda bahaya yang harus segera dilaporkan

Tugas Penguji

1. Mengamati dan menilai keterampilan peserta dalam melakukan tindakan.
2. Memberikan pertanyaan tambahan jika diperlukan untuk menguji pemahaman peserta tentang tindakan yang dilakukan.

Tugas Pasien Simulasi (Ibu Bayi)

- Bersikap kooperatif dan mendengarkan dengan seksama edukasi yang diberikan peserta.
- Bertanya jika ada materi yang belum jelas atau perlu diperjelas kembali.

Daftar Alat Dan Bahan

- Boneka bayi newborn
- Kain bersih, kering, dan hangat
- Alat potong tali pusat steril (gunting steril, penjepit tali pusat)
- Salep mata eritromisin atau tetrasiklin (simulasi)
- Vitamin K injeksi (simulasi)
- S spuit steril
- Alkohol swab
- Hand sanitizer
- Sarung tangan steril
- Popok bersih
- Buku panduan edukasi neonatus
- Leaflet edukasi perawatan bayi sehat

Rubrik Penilaian OSCE: Asuhan Neonatus dan Bayi Sehat

No	Aspek yang Dinilai	Penilaian	Skor (0–2)
1	Penilaian APGAR	2: Melakukan penilaian APGAR dengan benar, lengkap dan tepat waktu (menit ke-1 dan ke-5). 1: Melakukan penilaian APGAR namun kurang lengkap atau kurang tepat waktu. 0: Tidak melakukan atau salah total dalam penilaian APGAR.	
2	Pengeringan dan Kontak Kulit-ke-Kulit (IMD)	2: Mengeringkan bayi dengan benar, menjaga kehangatan tubuh bayi dan segera melakukan IMD secara tepat minimal 1 jam. 1: Mengeringkan bayi namun kurang lengkap atau IMD dilakukan namun kurang dari 1 jam. 0: Tidak melakukan atau salah dalam tindakan pengeringan dan IMD.	
3	Pemotongan dan Perawatan Tali Pusat	2: Memotong tali pusat secara steril setelah berhenti berdenyut, perawatan dilakukan dengan metode dry cord care secara tepat. 1: Memotong dan merawat tali pusat namun kurang steril atau kurang tepat dalam metode perawatan. 0: Tidak melakukan atau tindakan salah dan tidak steril.	
4	Pemberian Profilaksis Mata	2: Memberikan profilaksis mata secara tepat (salep antibiotik mata diberikan secara steril dari sudut dalam	

No	Aspek yang Dinilai	Penilaian	Skor (0–2)
		ke luar mata). 1: Memberikan profilaksis mata namun kurang tepat dalam teknik pemberian. 0: Tidak memberikan profilaksis mata atau tindakan tidak steril/salah.	
5	Pemberian Vitamin K	2: Memberikan vitamin K secara intramuskular dengan dosis tepat, di paha luar bayi secara steril. 1: Memberikan vitamin K namun kurang tepat dalam dosis atau lokasi injeksi. 0: Tidak memberikan vitamin K atau tindakan tidak steril/salah.	
6	Edukasi ASI Eksklusif	2: Memberikan edukasi tentang pentingnya ASI eksklusif, teknik menyusui, tanda kecukupan ASI secara jelas dan lengkap. 1: Memberikan edukasi namun kurang lengkap atau kurang jelas. 0: Tidak memberikan edukasi tentang ASI eksklusif.	
7	Edukasi Perawatan Tali Pusat	2: Memberikan edukasi jelas tentang metode perawatan kering, tanda-tanda infeksi tali pusat dengan baik dan lengkap. 1: Memberikan edukasi namun kurang jelas atau tidak lengkap. 0: Tidak memberikan edukasi perawatan tali pusat.	
8	Edukasi Perawatan Kulit Bayi	2: Memberikan edukasi yang jelas dan lengkap tentang cara mandi bayi, pencegahan ruam popok dan perawatan kulit bayi secara umum. 1: Memberikan edukasi namun kurang jelas atau tidak lengkap. 0: Tidak memberikan edukasi perawatan kulit bayi.	
9	Edukasi Pencegahan Infeksi	2: Memberikan edukasi cuci tangan, sterilisasi alat bayi, kontak terbatas dengan orang sakit secara jelas dan lengkap. 1: Memberikan edukasi namun kurang jelas atau tidak lengkap. 0: Tidak memberikan edukasi pencegahan infeksi.	
10	Edukasi Tanda Bahaya	2: Menjelaskan tanda bahaya pada bayi dengan jelas dan lengkap serta menyarankan untuk segera membawa ke fasilitas kesehatan.	

No	Aspek yang Dinilai	Penilaian	Skor (0–2)
		1: Memberikan edukasi namun kurang jelas atau kurang lengkap. 0: Tidak memberikan edukasi tanda bahaya.	
11	Komunikasi dan Sikap Profesional	2: Berkomunikasi efektif, sopan, menunjukkan sikap profesional dan empati terhadap ibu bayi selama tindakan dan edukasi. 1: Komunikasi kurang efektif atau sikap kurang empati. 0: Tidak komunikatif, tidak profesional, atau tidak empati.	

Skor Total Maksimal: 22

Kriteria Kelulusan:

- Kompeten: skor ≥ 18
- Cukup Kompeten: skor 14–17
- Kurang Kompeten: skor <14

Bab 6

Gizi Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah

A. Pendahuluan

Masa bayi hingga prasekolah merupakan masa kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak. Kebutuhan nutrisi pada periode ini harus terpenuhi secara optimal agar tumbuh kembang anak berlangsung dengan baik dan risiko gangguan pertumbuhan seperti gizi kurang, gizi buruk, dan stunting dapat diminimalkan. Peran tenaga kesehatan khususnya bidan dalam mengedukasi orang tua tentang pemberian makanan yang tepat, manajemen pemberian ASI eksklusif, dan makanan pendamping ASI (MP-ASI) menjadi penting guna mencapai status gizi yang optimal.

B. Capaian Pembelajaran

1. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu menguasai teori dan keterampilan dalam pemberian asuhan gizi pada bayi, balita, dan anak prasekolah secara komprehensif, berdasarkan pedoman nasional dan internasional (WHO), serta mampu mengedukasi keluarga dan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan masalah gizi.

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar nutrisi, pemberian ASI eksklusif, MP-ASI, serta mampu mengelola dan mengevaluasi asupan gizi bayi, balita, dan anak prasekolah guna mencegah serta menangani gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.

3. Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Mahasiswa mampu:

Sub-CPMK 1:

Menjelaskan kebutuhan nutrisi bayi, balita, dan anak prasekolah secara spesifik berdasarkan usia, aktivitas fisik, serta tahap perkembangan anak.

Indikator Pencapaian:

- Menguraikan kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral bayi usia 0–12 bulan.
- Menjelaskan secara terperinci kebutuhan gizi balita usia 1–3 tahun sesuai standar WHO.
- Mengidentifikasi kebutuhan nutrisi anak prasekolah (usia 4–6 tahun) untuk mendukung tumbuh kembang optimal.

Sub-CPMK 2:

Menjelaskan prinsip pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI (MP-ASI) sesuai standar WHO.

Indikator Pencapaian:

- Menyebutkan manfaat pemberian ASI eksklusif pada 6 bulan pertama kehidupan bayi.
- Menjelaskan empat prinsip utama pemberian MP-ASI menurut standar WHO (tepat waktu, adekuat, aman, dan responsif).
- Memberikan contoh menu MP-ASI yang memenuhi kriteria standar WHO.

Sub-CPMK 3:

Mengelola penatalaksanaan pemberian makanan sehat pada anak secara efektif dan komprehensif.

Indikator Pencapaian:

- Menyusun jadwal makan anak secara teratur sesuai kelompok usia.
- Mengidentifikasi jenis-jenis makanan sehat dari berbagai kelompok nutrisi untuk anak.
- Menjelaskan pengaturan porsi makan yang sesuai usia anak.
- Mendemonstrasikan cara melibatkan anak secara aktif dalam kegiatan makan guna membangun hubungan positif dengan makanan.

Sub-CPMK 4:

Menjelaskan strategi pencegahan dan penanganan gizi kurang, gizi buruk, dan stunting pada bayi, balita, dan anak prasekolah sesuai standar nasional dan internasional.

Indikator Pencapaian:

- Mengidentifikasi tanda-tanda dini dari gizi kurang, gizi buruk, dan stunting.
- Menjelaskan tahapan skrining dan pemantauan pertumbuhan menggunakan grafik WHO.
- Menjelaskan intervensi medis dan nutrisi yang efektif untuk menangani gizi kurang dan gizi buruk (Formula F-75, F-100, RUTF).
- Menjelaskan teknik intervensi nutrisi serta pendampingan keluarga yang efektif untuk penanganan dan pencegahan stunting secara komprehensif.

C. Kebutuhan Nutrisi Pada Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah

Periode bayi, balita, hingga anak prasekolah merupakan fase penting yang ditandai oleh pertumbuhan dan perkembangan pesat, baik secara fisik maupun neurologis. Pemenuhan nutrisi pada periode ini sangat menentukan kualitas tumbuh kembang serta status kesehatan anak hingga masa dewasa. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kebutuhan nutrisi spesifik berdasarkan kelompok usia sangat penting bagi orang tua, pengasuh, maupun tenaga kesehatan.

1. Kebutuhan Nutrisi pada Bayi (0–12 bulan)

Bayi usia 0–6 bulan idealnya hanya memperoleh nutrisi melalui pemberian ASI eksklusif tanpa tambahan makanan atau cairan lainnya. ASI eksklusif mencukupi seluruh kebutuhan energi, protein, lemak, vitamin, mineral, dan cairan bayi selama enam bulan pertama kehidupan.



Gambar 6.1 Ibu Menyusui

Energi dan Nutrien dari ASI (0–6 bulan):

- Energi: $\pm$ 550–650 kalori per hari.
- Protein: $\pm$ 9,1 gram/hari.
- Lemak: sekitar 30–35 gram/hari, penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf bayi.
- Karbohidrat: $\pm$ 60–70 gram/hari, sebagian besar dari laktosa dalam ASI.
- Vitamin dan mineral: ASI menyediakan hampir semua kebutuhan vitamin (seperti vitamin A, vitamin D) dan mineral penting (kalsium, zat besi, dan seng), kecuali vitamin D yang mungkin membutuhkan suplementasi tambahan pada kasus tertentu.

Setelah bayi mencapai usia 6 bulan, nutrisi yang diperoleh dari ASI saja tidak lagi mencukupi kebutuhan tubuh yang sedang tumbuh. Oleh karena itu, bayi mulai memerlukan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).

Kebutuhan Nutrisi Bayi usia 6–12 bulan:

- Energi: 650–850 kalori/hari.
- Protein: 11 gram/hari.
- Lemak: 30–35 gram/hari.
- Karbohidrat: $\pm$ 95 gram/hari.
- Vitamin dan mineral esensial seperti zat besi, vitamin D, vitamin A, seng, dan kalsium harus tersedia dalam MP-ASI.

MP-ASI yang diberikan harus mengandung kepadatan energi tinggi, tekstur yang sesuai (mulai dari bubur halus hingga semi-padat), serta variasi makanan yang mencakup sumber protein hewani, protein nabati, sayuran, buah-buahan, serta biji-bijian.

2. Kebutuhan Nutrisi pada Balita (1–3 tahun)

Balita mengalami pertumbuhan dan aktivitas fisik yang signifikan. Pada tahap ini, pola makan yang tepat dan seimbang sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal.



Gambar 6.2 Anak Makan Sayur dan Buah

Kebutuhan Energi dan Nutrisi:

- Energi: sekitar **1.000–1.400 kalori per hari** tergantung aktivitas fisik dan berat badan balita.
 - Protein: **13–19 gram per hari**. Protein membantu pertumbuhan jaringan tubuh, pembentukan enzim dan hormon.
 - Lemak: sekitar **30–40% dari total kalori harian** harus berupa lemak sehat (omega-3, omega-6), sangat penting untuk perkembangan otak, saraf, dan fungsi imunitas.
 - Karbohidrat kompleks: seperti nasi, roti gandum, ubi, kentang, pasta.
 - Serat makanan: membantu sistem pencernaan dan mencegah konstipasi, sekitar **19 gram per hari**.
 - Vitamin dan mineral utama: zat besi (7 mg/hari), kalsium (700 mg/hari), vitamin D, vitamin A, zinc, serta yodium untuk perkembangan fisik dan mental yang optimal.
- Pada usia ini, balita sudah mulai mengembangkan pola makan sendiri. Oleh karena itu, variasi rasa, tekstur, dan warna makanan penting diperhatikan agar anak tertarik dan memiliki pola makan sehat jangka panjang.

3. Kebutuhan Nutrisi pada Anak Prasekolah (4–6 tahun)

Anak prasekolah merupakan fase persiapan menuju masa sekolah yang membutuhkan nutrisi optimal untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan intelektual, dan fisik yang lebih kompleks.



Gambar 6.3 Anak Memakan Sayur dan Buah

Kebutuhan Energi dan Nutrisi:

- Energi: sekitar **1.400–1.800 kalori per hari**, menyesuaikan tingkat aktivitas.
- Protein: sekitar **19–34 gram per hari**. Protein diperlukan untuk pertumbuhan otot, tulang, gigi, dan regenerasi jaringan tubuh lainnya.
- Lemak sehat: mencakup **25–35% dari total kalori harian**. Penting untuk perkembangan otak serta fungsi sistem imun yang kuat.
- Karbohidrat kompleks: sumber energi utama yang didapat dari biji-bijian, roti gandum, nasi merah, kentang, ubi, jagung, dll.
- Serat makanan: asupan serat sekitar **25 gram per hari** untuk menunjang kesehatan pencernaan.
- Kalsium: kebutuhan meningkat menjadi sekitar **1.000 mg/hari** guna mendukung pertumbuhan tulang dan gigi.
- Zat besi: 10 mg/hari, diperlukan untuk mencegah anemia dan menunjang fungsi kognitif.
- Vitamin D, A, C, serta Zinc tetap diperlukan dalam jumlah yang cukup untuk daya tahan tubuh dan kesehatan kulit serta mata.

4. Sumber Makanan yang Dianjurkan



Gambar 6.4 Anak Senang Dengan Sayuran Segar Berwarna-Warni

Pola makan sehat untuk bayi, balita, dan anak prasekolah mencakup:

- Karbohidrat: nasi, ubi, singkong, kentang, jagung, oatmeal, roti gandum.
- Protein Hewani: daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, produk olahan susu.
- Protein Nabati: kacang-kacangan, tahu, tempe, lentil, polong-polongan.
- Sayur dan Buah-buahan: wortel, bayam, brokoli, tomat, jeruk, pisang, alpukat, pepaya.
- Lemak Sehat: minyak ikan, alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan, biji-bijian.

5. Implikasi dari Pemenuhan Nutrisi yang Tidak Optimal

Pemenuhan nutrisi yang kurang atau tidak tepat pada fase bayi hingga prasekolah memiliki risiko serius seperti:

- Gangguan tumbuh kembang fisik (misalnya stunting atau pendek, wasting, obesitas).
- Gangguan perkembangan kognitif dan intelektual.
- Gangguan imunitas, meningkatkan kerentanan terhadap penyakit infeksi.
- Defisiensi mikronutrien seperti anemia (defisiensi zat besi), defisiensi vitamin A yang menyebabkan gangguan penglihatan.

D. ASI Eksklusif dan MP-ASI Sesuai Standar WHO

1. Pentingnya ASI Eksklusif selama 6 Bulan Pertama

Air Susu Ibu (ASI) eksklusif adalah pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun termasuk air putih selama enam bulan pertama kehidupan bayi. Praktik ini sangat dianjurkan oleh World Health Organization (WHO), karena berbagai manfaat kesehatan yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi secara optimal.

Manfaat utama ASI eksklusif:

a. Nutrisi Optimal:

- ASI memiliki komposisi yang sempurna dan seimbang yang terdiri atas protein, karbohidrat (laktosa), lemak sehat (omega-3, omega-6), serta vitamin dan mineral yang sangat sesuai dengan kebutuhan bayi baru lahir hingga 6 bulan.
- ASI mudah dicerna oleh sistem pencernaan bayi yang masih berkembang, sehingga meminimalisir risiko gangguan pencernaan.

b. Kekebalan Tubuh:

- ASI mengandung kolostrum yang kaya akan imunoglobulin A (IgA), zat antibodi alami yang berfungsi melindungi bayi dari berbagai infeksi saluran pencernaan, pernapasan, dan infeksi lainnya.
- Kandungan prebiotik dalam ASI membantu pertumbuhan bakteri baik di saluran cerna bayi, yang penting untuk sistem imun yang kuat.

c. Pertumbuhan dan Perkembangan Optimal:

- Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif cenderung memiliki pertumbuhan fisik yang optimal, termasuk berat badan yang sehat dan stabil.
- Kandungan lemak esensial dalam ASI mendukung perkembangan otak dan sistem saraf bayi, yang sangat penting dalam periode emas perkembangan (0–2 tahun).

d. Ikatan Emosional (Bonding):

- Proses menyusui mempererat hubungan emosional antara ibu dan bayi, sehingga membantu perkembangan emosional dan psikologis bayi yang lebih baik.

2. Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Menurut Standar WHO

Setelah usia 6 bulan, kebutuhan nutrisi bayi mulai meningkat sehingga ASI saja tidak lagi mencukupi kebutuhan nutrisi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) sangat penting.

Standar WHO merekomendasikan MP-ASI harus memenuhi empat prinsip utama:

a. Tepat Waktu (Usia 6 bulan)

- MP-ASI ideal diberikan tepat pada usia 6 bulan.
- Pemberian yang terlalu cepat (sebelum usia 6 bulan) meningkatkan risiko infeksi, alergi, atau gangguan pencernaan pada bayi.
- Sebaliknya, pemberian yang terlambat (setelah usia 6 bulan) dapat menyebabkan kekurangan nutrisi yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan bayi.

b. Adekuat dalam Kandungan Nutrisi

WHO menegaskan bahwa MP-ASI harus memenuhi kebutuhan nutrisi bayi, terutama energi, protein, serta mikronutrien yang krusial seperti zat besi, vitamin A, seng, dan kalsium.

Kandungan nutrisi ideal MP-ASI:

- Energi: Sekitar 200 kalori/hari (usia 6–8 bulan), meningkat menjadi 300 kalori/hari (usia 9–11 bulan), dan sekitar 550 kalori/hari pada usia 12–23 bulan.
- Protein: Diperlukan untuk pertumbuhan jaringan tubuh. Protein hewani seperti telur, ikan, daging ayam, atau sapi, sangat direkomendasikan karena tinggi nilai biologisnya.
- Zat besi: Penting untuk mencegah anemia yang sering terjadi pada bayi usia >6 bulan. Sumbernya antara lain daging, hati, telur, ikan, dan bayam.
- Vitamin A: Penting untuk pertumbuhan sel dan penglihatan, terdapat dalam wortel, bayam, labu kuning, hati ayam.
- Lemak sehat: Membantu penyerapan vitamin serta perkembangan otak bayi. Sumbernya antara lain minyak kelapa, minyak zaitun, alpukat, mentega, serta kacang-kacangan (dengan catatan tidak ada riwayat alergi).

c. Aman (Higienis dalam Persiapan dan Pemberian)

Kebersihan dalam proses persiapan, pengolahan, penyimpanan, dan pemberian MP-ASI adalah kunci pencegahan infeksi saluran pencernaan pada bayi. Berikut rekomendasi WHO untuk menjamin keamanan MP-ASI:

- Mencuci tangan sebelum dan setelah menyiapkan makanan.
- Menggunakan peralatan bersih dan disterilkan.

- Menyajikan makanan dalam kondisi segar (baru dimasak) serta menghindari penyimpanan terlalu lama pada suhu ruangan.
 - Menghindari pemakaian bahan tambahan berbahaya seperti MSG, gula berlebih, atau garam berlebih.
- d. Pemberian secara Responsif (*Responsive Feeding*)
- WHO menekankan bahwa MP-ASI harus diberikan secara responsif, yang artinya orang tua atau pengasuh harus sensitif terhadap sinyal lapar dan kenyang dari bayi:
- Memberikan makanan ketika bayi menunjukkan tanda-tanda lapar seperti membuka mulut, meraih sendok, atau tampak antusias terhadap makanan.
 - Menghentikan pemberian makanan ketika bayi menunjukkan tanda-tanda kenyang seperti menutup mulut, memalingkan wajah, atau kehilangan minat terhadap makanan.
 - Memberikan MP-ASI dengan penuh perhatian, dorongan positif, sabar, dan tidak memaksa agar anak memiliki hubungan positif dengan makanan.

3. Contoh MP-ASI yang Sesuai Standar WHO

Berikut beberapa contoh MP-ASI yang direkomendasikan WHO untuk usia 6 bulan ke atas:

- **Bubur nasi atau kentang** dicampur protein hewani seperti daging sapi, ayam, ikan, telur rebus cincang, hati ayam yang dikukus atau direbus hingga matang.
- Tambahkan sayuran hijau seperti bayam, kangkung, wortel, labu, brokoli untuk vitamin dan serat.
- Campurkan buah-buahan matang seperti alpukat, pisang, mangga, pepaya yang dihaluskan sebagai sumber vitamin alami dan serat.
- Tambahkan minyak kelapa, mentega, atau minyak zaitun sekitar satu sendok teh per porsi untuk menambah kalori, lemak sehat, dan memperkaya rasa.

E. Penatalaksanaan Pemberian Makanan Sehat Pada Anak

Penatalaksanaan pemberian makanan sehat pada anak merupakan bagian penting dalam memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal. Tujuan utama penatalaksanaan ini adalah menjamin terpenuhinya kebutuhan nutrisi harian anak melalui konsumsi makanan bergizi, aman, serta seimbang secara teratur dan konsisten. Adapun aspek-aspek utama dalam penatalaksanaan pemberian makanan sehat pada anak yang perlu diperhatikan meliputi:

1. Mengatur Jadwal Makan yang Teratur

Penjadwalan makan anak penting untuk menjaga pola makan yang konsisten dan stabil. Idealnya anak diberikan makanan secara teratur dengan pola:

- 3 kali makan utama (sarapan, makan siang, dan makan malam).
- 2–3 kali makanan selingan atau camilan sehat di antara makan utama.

Tujuan pengaturan jadwal ini adalah:

- Menjaga metabolisme anak tetap stabil sepanjang hari.
- Membantu anak mengenali rasa lapar dan kenyang secara lebih baik.
- Mengurangi kebiasaan makan secara berlebihan atau ngemil makanan tidak sehat.
- Mendukung pola tidur dan aktivitas fisik yang teratur.

Contoh Jadwal Ideal

Waktu	Jenis Makanan
07:00–08:00	Sarapan utama
10:00–10:30	Camilan pagi (buah atau susu)
12:00–13:00	Makan siang utama
15:00–15:30	Camilan sore (biskuit gandum)
18:00–19:00	Makan malam utama

2. Memastikan Variasi Makanan dari Berbagai Kelompok Nutrisi

Pemberian makanan anak harus mencakup nutrisi lengkap dan seimbang yang terdiri atas:

- Karbohidrat: sumber utama energi untuk aktivitas fisik dan otak anak, diperoleh dari nasi, kentang, ubi, roti gandum, dan sereal sehat.
- Protein: diperlukan untuk pertumbuhan jaringan tubuh dan fungsi sistem imun, dapat berasal dari protein hewani (daging, ayam, ikan, telur, susu) dan protein nabati (kacang-kacangan, tahu, tempe).
- Lemak Sehat: penting untuk perkembangan otak, penyerapan vitamin larut lemak, serta sumber energi yang tinggi, berasal dari alpukat, ikan salmon, minyak kelapa, minyak zaitun, kacang-kacangan, dan biji-bijian.
- Vitamin dan Mineral: penting untuk menjaga fungsi tubuh optimal, diperoleh dari sayur-sayuran berwarna hijau tua (bayam, brokoli), oranye (wortel, labu), serta buah-buahan seperti jeruk, pisang, mangga.

Setiap menu makan anak idealnya mencakup makanan dari semua kelompok ini untuk memastikan asupan nutrisi lengkap setiap hari.

3. Pemberian Makanan dalam Porsi Sesuai Usia Anak

Menyesuaikan porsi makanan dengan usia anak sangat penting agar kebutuhan energi terpenuhi tanpa menyebabkan masalah seperti obesitas atau kurang gizi.

Panduan umum porsi makanan berdasarkan usia adalah sebagai berikut:

Bayi (6–12 bulan):

- Mulai dari 2–3 sendok makan per sesi hingga meningkat bertahap sesuai respons bayi.
- Tekstur makanan: halus hingga semi-padat.

Balita (1–3 tahun):

- Sekitar 1/2 porsi makanan dewasa.
- Tekstur makanan: lunak, mudah dikunyah, potongan kecil, dan variatif.

Anak Prasekolah (4–6 tahun):

- Sekitar 2/3 hingga 3/4 porsi makanan dewasa.
- Tekstur makanan: padat dengan ukuran potongan sesuai kemampuan mengunyah.

Orang tua perlu dilatih agar mampu menyesuaikan porsi makanan yang tepat, mencegah anak makan terlalu banyak atau terlalu sedikit.

4. Melibatkan Anak dalam Aktivitas Makan

Interaksi positif selama makan penting agar anak memiliki hubungan yang sehat dengan makanan:

- **Hindari pemaksaan** saat makan, karena hal ini dapat menciptakan rasa takut atau kecemasan pada anak dan meningkatkan risiko gangguan makan.
- **Ciptakan suasana makan yang menyenangkan** dan tenang. Libatkan anak dalam memilih menu atau membantu persiapan makanan agar mereka lebih bersemangat dalam makan.
- **Gunakan alat makan menarik**, warna-warni atau bergambar agar anak lebih tertarik untuk makan.
- Beri pujian positif saat anak mau mencoba makanan baru atau menyelesaikan makanannya.
- Batasi distraksi seperti televisi, tablet, atau gadget lain saat makan sehingga anak fokus pada aktivitas makan dan mengenali tanda kenyang dengan lebih baik.

5. Edukasi kepada Orang Tua tentang Pemilihan Bahan Makanan, Penyajian, dan Kebersihan Makanan

Orang tua merupakan kunci sukses dalam penerapan pola makan sehat anak. Edukasi ini mencakup:

Pemilihan bahan makanan sehat:

- Pilih bahan makanan segar, minim pengolahan (whole foods), seperti sayuran segar, buah segar, daging tanpa lemak, serta produk susu rendah lemak.
- Batasi penggunaan bahan makanan olahan tinggi gula, garam, dan lemak trans.

Teknik penyajian makanan sehat:

- Gunakan metode masak sehat seperti direbus, dikukus, dipanggang, atau ditumis dengan minyak sehat seperti minyak zaitun atau minyak kelapa.
- Hindari penggunaan MSG, gula berlebih, atau garam dalam jumlah besar untuk anak di bawah usia 2 tahun.

Kebersihan makanan (higienitas):

- Pastikan selalu mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan.
- Bersihkan bahan makanan segar dengan air mengalir sebelum dimasak.
- Pastikan peralatan memasak dan alat makan anak dalam kondisi bersih dan steril.
- Hindari menyimpan makanan matang terlalu lama dalam suhu ruangan. Jika disimpan, gunakan pendingin dalam waktu maksimal 1–2 hari.

F. Pencegahan dan Penanganan Gizi Kurang, Gizi Buruk, dan Stunting

Gizi kurang, gizi buruk, dan stunting merupakan masalah serius yang dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik, gangguan perkembangan otak, serta meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas pada anak. Penanganan kondisi ini harus dilakukan secara komprehensif dengan menggabungkan upaya pencegahan, deteksi dini, serta intervensi gizi yang tepat.

1. Pencegahan Gizi Kurang, Gizi Buruk, dan Stunting

Pencegahan adalah langkah paling efektif untuk menurunkan prevalensi gizi kurang, gizi buruk, dan stunting. Strategi utama pencegahan meliputi:

- a. Pemberian ASI Eksklusif dan MP-ASI Tepat

- ASI eksklusif (0–6 bulan) adalah intervensi paling penting dalam pencegahan awal masalah gizi. ASI memberikan nutrisi optimal dan perlindungan terhadap infeksi.
 - Setelah usia 6 bulan, ASI perlu dilengkapi dengan MP-ASI yang berkualitas, memenuhi kebutuhan energi, protein, dan mikronutrien esensial (zat besi, zinc, vitamin A).
 - MP-ASI harus diberikan dalam jumlah, frekuensi, dan tekstur yang tepat sesuai usia anak berdasarkan rekomendasi WHO.
- b. Pengenalan Tanda Dini Gizi Kurang
- Edukasi kepada orang tua mengenai tanda-tanda dini gizi kurang membantu deteksi dini masalah gizi, antara lain:
- Penurunan berat badan atau berat badan stagnan selama 2 bulan berturut-turut.
 - Anak tampak pucat, lesu, kurang aktif, mudah lelah, dan tidak ceria.
 - Kehilangan minat terhadap makanan atau susah makan dalam jangka waktu lama.
- c. Skrining Pertumbuhan Secara Berkala
- Pemantauan berkala menggunakan grafik pertumbuhan WHO wajib dilakukan setiap bulan minimal sampai anak berusia 2 tahun. Hal ini bertujuan untuk:
- Deteksi dini gangguan pertumbuhan seperti gizi kurang, gizi buruk, maupun stunting.
 - Melakukan intervensi gizi segera jika ditemukan perlambatan atau penurunan grafik pertumbuhan.
 - Memberikan edukasi tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan kepada orang tua.

2. Penanganan Gizi Kurang dan Gizi Buruk

Penanganan anak dengan kondisi gizi kurang dan gizi buruk harus dilakukan secara terpadu, meliputi intervensi medis, nutrisi, dan edukasi keluarga secara simultan.

a. Terapi Nutrisi Khusus (Makanan Tambahan Energi Tinggi)

Intervensi nutrisi bertujuan untuk memperbaiki status gizi secara cepat dan aman. Formula makanan tambahan yang digunakan meliputi:

- Formula F-75:

Diberikan pada fase awal (stabilisasi) pada anak dengan gizi buruk berat yang disertai komplikasi medis seperti edema atau anoreksia. Formula ini

mengandung energi rendah, protein terbatas, dan zat elektrolit esensial. Digunakan selama 2–7 hari pertama hingga kondisi anak stabil.

- Formula F-100:

Diberikan pada fase rehabilitasi setelah kondisi stabil, formula ini tinggi energi dan protein untuk meningkatkan berat badan dengan cepat dan aman.

- Ready-to-use therapeutic food (RUTF):

Makanan terapi siap saji berbasis kacang yang kaya energi, protein, lemak sehat, vitamin, dan mineral. Cocok digunakan di tingkat komunitas karena praktis, mudah digunakan tanpa persiapan khusus.

b. Suplementasi Mikronutrien

Suplementasi penting untuk memperbaiki defisiensi mikronutrien yang umum terjadi pada anak dengan gizi kurang atau gizi buruk:

- Zat besi: untuk mengatasi anemia yang sering menyertai gizi buruk.
- Vitamin A: meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah kebutaan, serta memperbaiki sistem imun anak.
- Zinc: mempercepat proses penyembuhan diare, meningkatkan nafsu makan, dan memperbaiki sistem imun secara keseluruhan.

c. Edukasi Intensif terhadap Keluarga

- Mengajarkan orang tua tentang pentingnya pola makan yang bergizi seimbang, higienis, serta pemberian makan dengan responsif.
- Memberikan informasi tentang teknik memasak yang benar dan cara memilih bahan makanan bergizi dengan biaya terjangkau.
- Edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan sanitasi lingkungan, karena anak gizi buruk rentan terhadap infeksi berulang.

3. Penanganan Stunting

Stunting atau pendek kronis akibat malnutrisi berulang dalam waktu lama memerlukan intervensi berkelanjutan dan konsisten, dengan fokus pada kualitas MP-ASI, pemantauan pertumbuhan, dan pendampingan keluarga.

a. Peningkatan Kualitas MP-ASI

- Prioritaskan pemberian makanan tinggi protein hewani (ikan, telur, ayam, daging merah) untuk mendukung pertumbuhan otot dan tulang.
- Menambahkan lemak sehat (seperti minyak kelapa, alpukat, minyak ikan) untuk mendukung perkembangan otak dan meningkatkan energi.
- MP-ASI diperkaya zat besi (hati ayam, daging merah, sayuran hijau), zinc (telur, ikan, daging merah), serta vitamin A (wortel, ubi kuning, bayam).

- b. Pemantauan Ketat Pertumbuhan Anak
 - Pemantauan dilakukan setiap bulan hingga anak mencapai usia minimal 2 tahun untuk memastikan kenaikan tinggi badan sesuai standar WHO.
 - Jika ditemukan tanda stunting, intervensi nutrisi intensif harus segera diberikan untuk mengejar pertumbuhan.
- c. Pendampingan Keluarga secara Konsisten
 - Pendampingan rutin (setiap bulan) kepada keluarga agar rekomendasi nutrisi diterapkan dengan benar di rumah.
 - Memantau kepatuhan keluarga terhadap intervensi yang diberikan, memberikan solusi bila ditemukan hambatan seperti ketersediaan bahan makanan, pengetahuan yang kurang, atau masalah finansial.
 - Melibatkan keluarga dalam kelompok edukasi atau kelompok pendukung (support group) untuk meningkatkan motivasi dan konsistensi dalam pencegahan stunting.

G. Tugas

Tugas 1: Penyusunan Menu MP-ASI Sesuai Standar WHO

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu menyusun menu MP-ASI yang memenuhi standar WHO, baik dari segi kandungan nutrisi, keamanan, dan responsivitas pemberian.

Instruksi Tugas:

- Susunlah menu MP-ASI untuk bayi usia 6–12 bulan selama 1 minggu (7 hari).
- Jelaskan rincian bahan, cara pengolahan, tekstur makanan, dan cara penyajiannya.
- Pastikan menu memenuhi kebutuhan energi, protein, lemak sehat, zat besi, vitamin A, serta mikronutrien lainnya.

Keluaran Tugas:

Dokumen dalam bentuk tabel menu MP-ASI 1 minggu lengkap dengan rincian nutrisi dan langkah-langkah persiapan (maksimal 3 halaman).

Tugas 2: Video Edukasi Teknik Pemberian Makanan secara Responsif

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu mendemonstrasikan teknik pemberian makanan secara responsif (responsive feeding).

Instruksi Tugas:

- Buat video berdurasi maksimal 5 menit tentang demonstrasi pemberian makanan responsif kepada balita usia 1–3 tahun.
- Jelaskan secara singkat dalam video tentang tanda-tanda lapar dan kenyang pada balita, serta sikap yang harus dihindari selama pemberian makan (misalnya pemaksaan).
- Pastikan demonstrasi dilakukan dengan bahasa yang jelas dan ramah.

Keluaran Tugas:

Video demonstrasi dalam format MP4, durasi maksimal 5 menit.

Tugas 3: Studi Kasus Deteksi Dini Gizi Kurang

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu melakukan analisis deteksi dini tanda-tanda gizi kurang pada balita menggunakan grafik pertumbuhan WHO.

Instruksi Tugas:

- Susun sebuah studi kasus singkat mengenai balita usia 2 tahun yang mengalami tanda-tanda awal gizi kurang (berat badan stagnan, malas makan, lesu).
- Gunakan grafik pertumbuhan WHO untuk menganalisis status gizi anak tersebut.
- Berikan rekomendasi intervensi yang tepat berdasarkan analisis Anda.

Keluaran Tugas:

Studi kasus (maksimal 2 halaman) yang memuat analisis grafik pertumbuhan dan rekomendasi intervensi.

Tugas 4: Leaflet Edukasi Pencegahan Stunting untuk Orang Tua

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu membuat media edukasi berupa leaflet tentang pencegahan stunting yang mudah dipahami orang tua.

Instruksi Tugas:

- Desain leaflet edukasi yang menarik berisi informasi tentang penyebab stunting, tanda-tanda, dan langkah-langkah pencegahan yang efektif.
- Sertakan gambar atau ilustrasi yang relevan dan menarik perhatian.
- Gunakan bahasa sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.

Keluaran Tugas:

Leaflet edukasi (2 halaman atau satu lembar bolak-balik) dalam bentuk PDF.

Tugas 5: Makalah Penatalaksanaan Terapi Gizi pada Anak dengan Gizi Buruk

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu menjelaskan secara mendalam tentang penatalaksanaan terapi nutrisi pada anak dengan kondisi gizi buruk.

Instruksi Tugas:

- Tuliskan makalah maksimal 4 halaman yang menjelaskan langkah-langkah terapi nutrisi menggunakan Formula F75, F100, dan Ready-to-Use Therapeutic Food (RUTF).
- Jelaskan juga peran suplementasi mikronutrien dalam terapi tersebut.
- Sertakan minimal 3 referensi terbaru (maksimal 5 tahun terakhir).

Keluaran Tugas:

Makalah terstruktur maksimal 4 halaman, lengkap dengan daftar pustaka format APA.

Tugas 6: Observasi Pola Makan Anak Prasekolah dan Evaluasi Status Gizi

Tujuan Tugas:

Mahasiswa mampu melakukan observasi pola makan anak prasekolah dan mengevaluasi status gizinya.

Instruksi Tugas:

- Lakukan observasi selama 3 hari terhadap pola makan anak prasekolah (usia 4–6 tahun).
- Catat jenis makanan, jumlah porsi, frekuensi makan, serta pola pemberian makan (responsif atau tidak).
- Lakukan evaluasi kecukupan nutrisi berdasarkan standar kebutuhan anak prasekolah.
- Berikan saran atau rekomendasi perbaikan pola makan yang tepat berdasarkan hasil observasi.

Keluaran Tugas:

Laporan observasi pola makan dan evaluasi status gizi (maksimal 3 halaman).

H. Soal Kasus

Soal 1:

Seorang ibu datang membawa bayi perempuan usia 4 bulan ke klinik bidan. Ibu menyampaikan bahwa bayi sering menangis setelah disusui dan meminta tambahan susu formula. Hasil pemeriksaan menunjukkan berat badan bayi sesuai grafik pertumbuhan WHO.

Apa edukasi terbaik yang diberikan kepada ibu tersebut?

- A. Berikan susu formula setelah ASI
- B. Mulai pemberian MP-ASI dini untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi
- C. Edukasi agar ibu tetap memberikan ASI eksklusif sampai usia 6 bulan
- D. Berikan air putih tambahan agar bayi kenyang
- E. Tambahkan multivitamin untuk bayi agar tidak mudah lapar

Soal 2:

Seorang ibu datang membawa anak laki-laki usia 7 bulan dengan berat badan stagnan selama dua bulan terakhir. Ibu memberikan MP-ASI berupa bubur tepung beras saja, sebanyak dua kali sehari.

Apa tindakan bidan yang tepat untuk kondisi tersebut?

- A. Melanjutkan pemberian bubur tepung beras dengan meningkatkan frekuensi
- B. Menambahkan garam dan gula dalam bubur agar lebih menarik
- C. Mengedukasi ibu tentang variasi MP-ASI sesuai standar WHO
- D. Memberikan susu formula tambahan segera
- E. Menyarankan pemberian vitamin saja tanpa perubahan pola makan

Soal 3:

Bayi usia 11 bulan dibawa ke Posyandu dengan keluhan mudah lelah, pucat, dan kurang aktif. Berat badannya berada di bawah garis merah pada grafik WHO. Apa penatalaksanaan awal yang paling tepat dilakukan bidan?

- A. Memberikan makanan tambahan energi tinggi (Formula F-75/F-100)
- B. Memberikan vitamin A dosis tinggi sebagai terapi utama
- C. Menyarankan pemberian makanan keluarga secara langsung
- D. Memberikan MP-ASI berupa buah-buahan saja
- E. Melakukan imunisasi lengkap agar bayi sehat kembali

Soal 4:

Balita usia 2 tahun dibawa oleh ibunya dengan keluhan susah makan dan sering menolak makanan baru. Berat badan anak di bawah normal untuk usianya.

Apa saran edukasi terbaik yang dapat diberikan kepada ibu?

- A. Memberikan makanan tinggi kalori tanpa memperhatikan kandungan nutrisi lainnya
- B. Memaksa anak untuk makan hingga porsi habis agar asupan tercukupi

- C. Menawarkan variasi makanan sehat secara bertahap dan menciptakan suasana makan yang menyenangkan
- D. Mengurangi frekuensi makan agar anak merasa lebih lapar
- E. Memberikan camilan manis agar anak lebih tertarik makan

Soal 5:

Anak perempuan usia 5 tahun datang ke posyandu dengan tinggi badan 95 cm, lebih pendek dibandingkan usianya berdasarkan grafik WHO. Riwayat menunjukkan bahwa anak sering sakit infeksi saluran pernapasan dan pola makan kurang mengandung protein hewani.

Apa intervensi prioritas yang perlu dilakukan oleh bidan?

- A. Memberikan vitamin D dosis tinggi
- B. Mengedukasi keluarga tentang pemberian MP-ASI berkualitas tinggi dengan tambahan protein hewani dan pemantauan tinggi badan secara rutin
- C. Memberikan suplemen zat besi saja
- D. Menyarankan pemberian susu formula tinggi gula
- E. Mengurangi aktivitas fisik agar energi anak tersimpan lebih banyak

Kunci Jawaban:

1. Jawaban: C

Pembahasan:

Pada usia 0-6 bulan, WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif tanpa tambahan makanan atau minuman apapun, termasuk air putih, susu formula, maupun MP-ASI. Edukasi harus menegaskan pentingnya ASI eksklusif untuk memenuhi seluruh kebutuhan nutrisi bayi dan mendukung kekebalan tubuhnya. Keluhan bayi menangis setelah disusui dapat dikarenakan berbagai sebab selain lapar, seperti rasa tidak nyaman, ingin dipeluk, atau proses menyusui yang kurang optimal.

2. Jawaban: C

Pembahasan:

MP-ASI yang diberikan harus memenuhi prinsip WHO yaitu tepat waktu, adekuat nutrisi, higienis, dan responsif. MP-ASI idealnya terdiri dari karbohidrat, protein hewani/nabati, lemak sehat, serta sayur dan buah. Hanya memberi bubur tepung beras menyebabkan defisiensi energi dan mikronutrien, sehingga berat badan stagnan. Edukasi bidan harus menekankan pentingnya variasi makanan dengan tekstur sesuai usia bayi.

3. Jawaban: A

Pembahasan:

Bayi dengan berat badan di bawah garis merah pada grafik pertumbuhan WHO menunjukkan gizi buruk. Tanda lain berupa mudah lelah, pucat, kurang aktif menunjukkan defisiensi energi dan nutrisi. Penatalaksanaan awal kondisi gizi buruk dilakukan dengan pemberian makanan tambahan energi tinggi yaitu formula F-75/F-100 secara bertahap untuk memperbaiki status gizi bayi terlebih dahulu sebelum makanan keluarga diberikan.

4. Jawaban: C

Pembahasan:

Pada usia balita, penolakan terhadap makanan baru adalah hal yang wajar. Bidan harus mengedukasi orang tua untuk menciptakan suasana makan yang menyenangkan, menawarkan variasi makanan sehat secara bertahap, serta tidak

memaksa anak saat makan. Hal ini membantu anak memiliki hubungan positif dengan makanan dan mengurangi risiko gangguan makan.

5. **Jawaban: B**

Pembahasan:

Tinggi badan yang jauh lebih pendek dari standar usia menandakan stunting (pendek kronis). Riwayat infeksi berulang dan pola makan rendah protein hewani meningkatkan risiko stunting. Intervensi prioritas adalah meningkatkan kualitas MP-ASI dengan protein hewani yang kaya zat besi, zinc, dan protein tinggi nilai biologis, serta pemantauan tinggi badan secara rutin untuk mengejar pertumbuhan optimal. Pendampingan intensif kepada keluarga juga penting untuk memastikan kepatuhan terhadap rekomendasi gizi.

I. Soal OSCE

Topik: Edukasi dan Konseling Gizi Optimal pada Bayi usia 6–12 bulan (MP-ASI)

Skenario Kasus:

Seorang ibu bernama Ny. Ratih datang ke klinik kebidanan membawa bayinya yang berusia 7 bulan untuk kontrol rutin. Berat badan bayi sedikit di bawah garis normal pada grafik pertumbuhan WHO. Selama ini bayi diberikan ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. Setelah 6 bulan, ibu hanya memberikan bubur tepung beras yang sangat encer, tanpa tambahan protein dan sayuran. Ibu juga terlihat bingung tentang cara yang benar untuk memberikan MP-ASI yang adekuat secara nutrisi sesuai standar WHO.

Tugas Peserta:

1. Melakukan edukasi kepada Ny. Ratih mengenai prinsip MP-ASI yang adekuat sesuai rekomendasi WHO.
2. Menjelaskan jenis makanan yang perlu diberikan, tekstur, jumlah, frekuensi pemberian, dan prinsip responsive feeding.
3. Memberikan contoh menu MP-ASI yang optimal untuk bayi usia 7 bulan.
4. Menggunakan komunikasi yang baik, jelas, dan empati.

Tugas Penguji:

- Mengobservasi secara langsung pelaksanaan edukasi dan konseling yang dilakukan peserta.

- Menilai kemampuan komunikasi, ketepatan materi edukasi, dan keterampilan memberikan contoh yang sesuai rekomendasi WHO.
- Memberikan penilaian berdasarkan rubrik OSCE yang tersedia.

Tugas Pasien Simulasi:

- Berperan sebagai Ny. Ratih, seorang ibu dengan bayi berusia 7 bulan.
- Bersikap kooperatif tetapi menunjukkan kebingungan dan mengajukan beberapa pertanyaan berikut:
 - "Apakah hanya bubur tepung beras saja tidak cukup?"
 - "Apa saja contoh makanan yang bisa saya berikan kepada bayi saya?"
 - "Berapa kali dalam sehari saya harus memberikan MP-ASI?"
 - "Bagaimana mengetahui kalau bayi saya sudah kenyang?"

Alat Yang Dibutuhkan:

- Grafik pertumbuhan WHO (KMS bayi)
- Leaflet atau contoh menu MP-ASI standar WHO
- Boneka bayi (untuk simulasi interaksi)
- Meja dan kursi konsultasi
- Pena dan catatan kecil (untuk peserta mencatat poin penting)

RUBRIK PENILAIAN OSCE

No	Kriteria Penilaian	Skor Maks	Skor Peserta
1.	Menyapa dan memperkenalkan diri secara sopan dan empati kepada pasien	5	
2.	Menjelaskan tujuan edukasi secara jelas dan mudah dipahami oleh pasien	5	
3.	Menjelaskan pentingnya pemberian MP-ASI sesuai waktu (tepat usia 6 bulan) dan alasan pemberian MP-ASI yang adekuat nutrisi (energi, protein, vitamin, dan mineral) secara tepat	20	
4.	Menjelaskan tekstur MP-ASI yang tepat untuk usia 7 bulan (bubur kental atau semi-padat)	10	
5.	Menjelaskan frekuensi pemberian MP-ASI yang tepat (2–3 kali sehari) dengan porsi yang sesuai usia bayi (2–3 sendok makan bertahap hingga bertambah)	15	

No	Kriteria Penilaian	Skor Maks	Skor Peserta
6.	Memberikan contoh menu MP-ASI yang tepat (karbohidrat, protein hewani/nabati, sayur dan buah, lemak sehat seperti minyak kelapa atau zaitun)	15	
7.	Menjelaskan prinsip responsive feeding (mengenal tanda lapar dan kenyang bayi serta tidak memaksa bayi) secara jelas dan tepat	15	
8.	Menjawab pertanyaan pasien simulasi secara akurat, jelas, dan dengan sikap empati	10	
9.	Menutup sesi edukasi secara sopan, menawarkan kesempatan bertanya kembali, dan membuat janji kunjungan berikutnya	5	
Total Skor Maksimal	100	Skor Peserta: ...	

Contoh Kunci Jawaban (Poin-Poin Edukasi):

- **Pentingnya MP-ASI Tepat Waktu (6 bulan):** ASI saja tidak mencukupi kebutuhan energi dan nutrisi bayi setelah usia 6 bulan, MP-ASI diperlukan agar tumbuh kembang bayi optimal.
- **Adekuat Nutrisi:** MP-ASI harus mengandung energi tinggi (± 200 kal/hari di usia 6–8 bulan), protein (hewani seperti telur, ikan, ayam), zat besi, vitamin A, dan lemak sehat.
- **Tekstur MP-ASI:** usia 7 bulan diberikan makanan semi-padat (bubur agak kental, dihaluskan atau lumat).
- **Frekuensi Pemberian MP-ASI:** diberikan 2–3 kali sehari dengan porsi kecil awal (2–3 sendok makan) dan ditingkatkan secara bertahap.
- **Contoh Menu MP-ASI ideal:** bubur nasi campur daging ayam cincang halus, wortel dan bayam dihaluskan, ditambah sedikit minyak zaitun atau minyak kelapa.
- **Prinsip Responsive Feeding:** mengenali tanda lapar bayi (tertarik makanan, membuka mulut, aktif menjangkau makanan), tanda kenyang (menutup mulut, memalingkan wajah, menolak sendok). Tidak boleh memaksa bayi makan.

- **Menjawab Pertanyaan Pasien:**

- Bubur tepung beras saja tidak cukup karena kurang protein, vitamin, mineral penting.
- Contoh makanan: bubur nasi, ikan, telur, hati ayam, wortel, bayam, alpukat.
- Frekuensi MP-ASI idealnya 2–3 kali per hari untuk bayi usia 7 bulan.
- Tanda kenyang bayi seperti menutup mulut atau memalingkan wajah.

Daftar Pustaka

- American Academy of Pediatrics. (2022). *Guidelines for perinatal care* (9th ed.). American Academy of Pediatrics and American College of Obstetricians and Gynecologists.
- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., & Jensen, M. D. (2021). *Buku ajar keperawatan maternitas*. Jakarta: EGC.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelaksanaan stimulasi, deteksi, dan intervensi dini tumbuh kembang anak di tingkat pelayanan kesehatan dasar*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman pelayanan kesehatan neonatal esensial*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Hidayat, A. A. A. (2020). *Pengantar ilmu kesehatan anak untuk pendidikan kebidanan dan keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2018). *Wong's essentials of pediatric nursing* (10th ed.). Elsevier.
- Hockenberry, M. J., & Wilson, D. (2019). *Wong's essentials of pediatric nursing*. Elsevier Health Sciences.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. (2022a). *Buku panduan pemantauan tumbuh kembang bayi dan balita*. Jakarta: IDAI.
- Ikatan Dokter Anak Indonesia. (2022b). *Pedoman pemantauan tumbuh kembang balita*. Jakarta: Ikatan Dokter Anak Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). *Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Buku kesehatan ibu dan anak (KIA): Pedoman pemantauan tumbuh kembang anak*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Buku saku imunisasi rutin lengkap bagi tenaga kesehatan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kurniasari, M. D., & Nurhayati, N. (2021). Pengaruh edukasi metode dry cord care terhadap lama pelepasan tali pusat bayi baru lahir. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(2), 55–63.
- Mardiyanti, E., & Sari, Y. P. (2021). Pengaruh inisiasi menyusui dini terhadap stabilisasi suhu tubuh neonatus. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah*, 17(1), 1–8.

- Maryunani, A. (2017). *Tumbuh kembang dan stimulasi anak usia dini*. Jakarta: Trans Info Media.
- McKinney, E. S., James, S. R., Murray, S. S., & Ashwill, J. W. (2022). *Maternal-child nursing* (6th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Orami. (2024). Cara skrining tumbuh kembang anak dengan tabel Denver II.
- Poltekkes Jakarta III. (2024). *Stimulasi perkembangan anak usia prasekolah dengan evidence base*.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of nursing*. Elsevier Health Sciences.
- Potter, P. A., Perry, A. G., Stockert, P., & Hall, A. (2017). *Fundamentals of nursing* (9th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Pusat Kesehatan Masyarakat Tarogong. (2018). *Skrining/deteksi perkembangan anak menggunakan Denver II*.
- Rahadian, K., dkk. (2017). Sistem monitoring perkembangan anak berbasis Denver Development Screening Test. *Jurnal Teknoin*, 23(2), 305–312.
- Rusmini, R., Emilyani, D., Cembun, C., Fathoni, A., & Darwissusanto, D. (2023). Perkembangan motorik halus pada anak usia prasekolah (3–<6 tahun) di TK Dharma Pertiwi Penujak. *Journal of Excellent Nursing Students (JENIUS)*, 1(2), 1–10.
- Santrock, J. W. (2021). *Life-span development* (18th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Sari Pediatri. (2013). Kesepakatan hasil antara kuesioner pra skrining perkembangan, Parent's Evaluation of Developmental Status, dan tes Denver-II untuk skrining perkembangan anak balita.
- Soetjiningsih. (2017). *Tumbuh kembang anak*. Jakarta: EGC.
- Soetjiningsih. (2018). *Tumbuh kembang anak*. Jakarta: EGC.
- Syafnita, T., dkk. (2023). *Psikologi perkembangan anak usia dini*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Unifam. (2024). Tahapan tumbuh kembang anak 3–6 tahun dan stimulasinya.
- Universitas Andalas. (2024). *Tumbuh kembang anak usia prasekolah*.
- World Health Organization. (2006). *WHO child growth standards: Length/height-for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height, and body mass index-for-age*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2014a). *Global nutrition targets 2025: Breastfeeding policy brief*.

- World Health Organization. (2014b). *Global nutrition targets 2025: Policy brief series*.
- World Health Organization. (2021a). *Child growth standards*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2021b). *WHO child growth standards*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2022). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. WHO Press.
- World Health Organization. (2023a). *Guidelines on basic newborn resuscitation*. World Health Organization.
- World Health Organization. (2023b). *WHO guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age*.
- World Health Organization. (n.d.-a). *Complementary feeding*.
- World Health Organization. (n.d.-b). *Exclusive breastfeeding for optimal growth, development and health of infants*.
- Wong, D. L. (2020). *Nursing care of infants and children* (11th ed.). Mosby Elsevier.
- Wong, D. L., Hockenberry, M. J., & Rodgers, C. C. (2019). *Wong's nursing care of infants and children* (11th ed.). Elsevier.
- Yanti, Y., & Maryuni, M. (2022). Efektivitas edukasi cuci tangan dalam pencegahan infeksi neonatus pada ibu postpartum. *Indonesian Journal of Midwifery*, 5(1), 27–33.
- Zubaidah, N., & Anggraini, A. (2020). Pengaruh edukasi ASI eksklusif terhadap praktik menyusui pada ibu nifas. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 11(3), 199–205.

Buku Ajar Bayi, Balita dan Anak Prasekolah adalah sumber belajar yang komprehensif bagi mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan dalam memahami dan mengelola tumbuh kembang anak usia dini secara menyeluruh. Buku ini membahas secara mendalam tentang konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan anak, mulai dari tahap bayi (0–12 bulan), balita (1–3 tahun), hingga anak prasekolah (3–6 tahun), serta disertai dengan prinsip pemantauan, deteksi dini gangguan perkembangan, hingga intervensi dan edukasi kepada orang tua.

Melalui pendekatan yang berbasis bukti dan praktik, pembaca dibekali dengan keterampilan melakukan pengukuran antropometri, observasi perkembangan anak, serta edukasi stimulasi yang sesuai dengan kelompok usia dan aspek perkembangan. Buku ini juga dilengkapi dengan soal kasus, latihan OSCE, dan tugas praktik yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan analisis serta kesiapan praktik lapangan mahasiswa kebidanan.

Dengan gaya penyajian yang sistematis dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini tidak hanya bermanfaat sebagai referensi akademik, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam pelayanan kebidanan di komunitas maupun fasilitas kesehatan.

Buku Ajar Bayi, Balita dan Anak Prasekolah adalah sumber belajar yang komprehensif bagi mahasiswa kebidanan dan tenaga kesehatan dalam memahami dan mengelola tumbuh kembang anak usia dini secara menyeluruh. Buku ini membahas secara mendalam tentang konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan anak, mulai dari tahap bayi (0–12 bulan), balita (1–3 tahun), hingga anak prasekolah (3–6 tahun), serta disertai dengan prinsip pemantauan, deteksi dini gangguan perkembangan, hingga intervensi dan edukasi kepada orang tua. Melalui pendekatan yang berbasis bukti dan praktik, pembaca dibekali dengan keterampilan melakukan pengukuran antropometri, observasi perkembangan anak, serta edukasi stimulasi yang sesuai dengan kelompok usia dan aspek perkembangan. Buku ini juga dilengkapi dengan soal kasus, latihan OSCE, dan tugas praktik yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan analisis serta kesiapan praktik lapangan mahasiswa kebidanan. Dengan gaya penyajian yang sistematis dan bahasa yang mudah dipahami, buku ini tidak hanya bermanfaat sebagai referensi akademik, tetapi juga sebagai pedoman praktis dalam pelayanan kebidanan di komunitas maupun fasilitas kesehatan.

Penerbit:
PT Optimal Untuk Negeri
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-96029-7-6



9

786349

602976